

Buku Referensi

KESEHATAN MENTAL

**Dalam Praktik Keperawatan
Pendekatan Holistik Dan Komunitas**

Mamnuaah • Osep Yasier Almunsiri • Titik Nuryanti
Mutianingsih • Aisyah Maulina Zjubaidi



BUKU REFERENSI: KESEHATAN MENTAL DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN: PENDEKATAN HOLISTIK DAN KOMUNITAS

Penulis:

Dr. Ns. Mamnuah, M.Kep., Sp.Kep.J.
Osep Yasier Almunsiri, S.Kep., Ners., M.Kep.
Titik Nuryanti, S. Kep., Ns., M.Kep
Ns. Mutianingsih, M.Kep.
Aisyah Maulina Zjubaidi, SKM., M.Si.

Buku Referensi: Kesehatan Mental Dalam Praktik Keperawatan: Pendekatan Holistik Dan Komunitas

Penulis:

Dr. Ns. Mamnuah, M.Kep., Sp.Kep.J.
Osep Yasier Almunsiri, S.Kep., Ners., M.Kep.
Titik Nuryanti, S. Kep., Ns., M.Kep
Ns. Mutianingsih, M.Kep.
Aisyah Maulina Zjubaidi, SKM., M.Si.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-08-4

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi berjudul *Kesehatan Mental dalam Praktik Keperawatan: Pendekatan Holistik dan Komunitas* ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam memahami, mencegah, serta menangani masalah kesehatan mental melalui pendekatan yang menyeluruh, manusiawi, dan berbasis komunitas.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara utuh. Dalam praktik keperawatan, perawat tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan fisik pasien, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan aspek psikologis, sosial, spiritual, serta lingkungan yang memengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep kesehatan mental menjadi dasar penting bagi perawat dalam memberikan asuhan yang komprehensif dan berpusat pada individu, keluarga, maupun masyarakat.

Buku ini membahas berbagai topik penting, mulai dari konsep kesehatan mental dalam keperawatan, intervensi keperawatan pada gangguan depresi dan ansietas, hingga keperawatan jiwa berbasis komunitas. Selain itu, buku ini juga mengulas mengenai stigma dan pendekatan psikososial yang sering menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan mental. Tidak kalah penting, pembahasan mengenai kesehatan mental tenaga kesehatan turut disajikan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan perawat dan tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya peran perawat dalam mendukung kesehatan mental masyarakat. Pendekatan holistik dan komunitas menjadi landasan utama dalam membangun pelayanan keperawatan yang tidak hanya berorientasi pada penyembuhan, tetapi juga pada pencegahan, pemulihan, pemberdayaan, serta peningkatan kualitas hidup individu dan kelompok.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi kesehatan, perawat, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pelayanan kesehatan mental di Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat

menjadi referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas praktik keperawatan, khususnya dalam bidang kesehatan mental dengan pendekatan holistik dan komunitas.

Mei 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 KONSEP KESEHATAN MENTAL DALAM KEPERAWATAN 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Hakikat Kesehatan Mental.....	2
C. Paradigma Keperawatan Holistik.....	3
D. Sejarah dan Perkembangan Keperawatan Jiwa di Indonesia.....	4
E. Peran dan Kontribusi Perawatan dalam Kesehatan Mental Global	5
F. Tren dan Isu Kesehatan Mental: Tantangan Kesehatan Mental di Era Digital... 6	
G. Landasan Etik dan Legal dalam Pelayanan Keperawatan Jiwa	7
H. Perspektif Lintas Budaya dalam Kesehatan Mental.....	8
I. Ketahanan Mental Tenaga Kesehatan dan Dukungan Sistem Sosial.....	9
J. Teori dan Model Konseptual Keperawatan Jiwa	9
K. Upaya Promotif dan Preventif dalam Keperawatan Jiwa Komunitas	10
L. Penutup	11
Referensi.....	13
Glosarium	15

BAB 2 INTERVENSI KEPERAWATAN PADA GANGGUAN DEPRESI DAN

ANSIETAS 17

A. Pendahuluan.....	17
B. Cognitive Behavioral Therapy (CBT).....	18
C. Afirmasi Positi.....	22
D. Psikososial	27
E. Penutup	29
Referensi.....	31
Glosarium	34

BAB 3 KEPERAWATAN JIWA BERBASIS KOMUNITAS 37

A. Pendahuluan.....	37
B. Latar Belakang dan Perkembangan Keperawatan Jiwa Berbasis Komunitas .. 37	
C. Pengertian Keperawatan Jiwa Berbasis Komunitas	38
D. Ruang Lingkup Keperawatan Jiwa Berbasis Komunitas.....	38
E. Konsep Sehat Sakit dalam Keperawatan Jiwa	40

F. Tujuan Penerapan Keperawatan Jiwa Komunitas.....	43
G. Prinsip-Prinsip Keperawatan Jiwa di Komunitas.....	45
H. Pelayanan Keperawatan Jiwa Komprehensif.....	45
I. Tingkatan Keperawatan Jiwa Komunitas.....	46
J. Empat Pilar Pelayanan CMHN.....	49
K. Hambatan Implementasi Keperawatan Jiwa di Komunitas.....	50
L. Strategi Implementasi Keperawatan Jiwa di Komunitas.....	52
M. Penutup.....	54
Referensi.....	56
Glosarium.....	58

BAB 4 STIGMA DAN PENDEKATAN PSIKOSOSIAL..... 59

A. Pendahuluan.....	59
B. Konsep Dasar Stigma Kesehatan Mental.....	60
C. Dampak Stigma terhadap Individu, Keluarga, Layanan, dan Masyarakat.....	61
D. Pendekatan Psikososial: Prinsip Umum dan Orientasi Pemulihan.....	62
E. Psikoedukasi dan Literasi Kesehatan Mental.....	63
F. Kontak Sosial, Narasi Pemulihan, dan Strategi Komunikasi Publik.....	64
G. Family Psychoeducation dan Keterlibatan Caregiver.....	65
H. Rehabilitasi Psikososial, Dukungan Sebaya, dan Integrasi Komunitas.....	66
I. Penutup.....	66
Referensi.....	68
Glosarium.....	71

BAB 5 KESEHATAN MENTAL TENAGA KESEHATAN 72

A. Pendahuluan.....	72
B. Kesehatan Mental (Jiwa).....	72
C. Determinan Kesehatan Mental.....	76
D. Bahaya Psikososial di Tempat Kerja.....	79
E. Strategi Intervensi Kesehatan Mental bagi Tenaga Kesehatan.....	89
F. Contoh Rencana Implementasi Intervensi Kesehatan Mental di Rumah Sakit.....	91
G. Simpulan dan Penutup.....	93
Referensi.....	95

PROFIL PENULIS 100

BAB 1

KONSEP KESEHATAN MENTAL DALAM KEPERAWATAN

A. Pendahuluan

Memasuki masa sekarang, kesehatan mental bukan lagi sekadar urusan pribadi yang bisa dianggap sepele. Masalah ini telah bergeser menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat ini, dunia tidak hanya bergelut dengan berbagai penyakit fisik yang semakin rumit, tetapi juga sedang menghadapi "badai tersembunyi" berupa meningkatnya masalah emosional. Hal ini secara perlahan memengaruhi produktivitas serta kenyamanan hidup banyak orang, mulai dari lingkungan keluarga hingga tatanan masyarakat yang lebih luas.

Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terbaru menunjukkan adanya lonjakan kasus kecemasan dan kesedihan yang mendalam di berbagai negara. Fenomena ini memaksa setiap orang untuk memikirkan kembali apa sebenarnya arti menjadi "sehat". Kini, sehat bukan lagi sekadar kondisi tubuh yang bebas dari rasa sakit atau cacat fisik. Makna sehat telah meluas menjadi sebuah keseimbangan hidup yang dinamis, tentang bagaimana seseorang menjaga pikiran tetap jernih, tetap kuat saat menghadapi tekanan hidup, serta mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitarnya di tengah tuntutan zaman yang semakin berat (Halter & Varcarolis, 2014).

Dalam situasi seperti ini, peran perawat menjadi sangat penting sebagai jembatan yang menghubungkan layanan medis dengan kenyataan hidup di tengah masyarakat. Perawat tidak hanya hadir di rumah sakit untuk memberikan pengobatan fisik, tetapi juga berperan sebagai teman dalam proses pemulihan yang paling memahami keseharian pasien. Kehadiran perawat membantu mengisi celah antara tindakan medis dan proses adaptasi sosial yang sering kali menjadi kunci utama bagi kesembuhan jiwa seseorang (Stuart, 2014).

Melalui pendekatan yang menyeluruh (holistik), perawatan kesehatan jiwa tidak melihat seseorang hanya dari satu sisi saja. Sebaliknya, aspek fisik, pikiran, lingkungan sosial, hingga kekuatan spiritual dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cara pandang seperti ini sangat penting untuk menghapus label negatif atau stigma yang selama ini menempel pada masalah kesehatan mental. Selain itu, pendekatan ini membantu masyarakat menghadapi tantangan di era digital yang serba cepat, sambil tetap menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang sangat kental di Indonesia (Kemenkes RI, 2023).

Upaya untuk memperkuat sistem kesehatan jiwa ini didukung oleh pemahaman sejarah yang kuat serta aturan hukum yang jelas. Hadirnya regulasi terbaru, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjadi titik balik bagi layanan kesehatan yang lebih terbuka bagi siapa saja. Dengan landasan tersebut, bab ini disusun bukan sekadar sebagai instruksi teknis, melainkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga tulus secara kemanusiaan. Tujuannya adalah agar setiap bantuan yang diberikan mampu menyentuh sisi terdalam dari martabat manusia dan membantu mereka kembali menjalani hidup yang lebih bermakna.

B. Hakikat Kesehatan Mental

Sering kali muncul anggapan bahwa kesehatan mental hanyalah soal apakah seseorang memiliki diagnosis gangguan jiwa atau tidak. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang keperawatan modern, kesehatan mental bukanlah sebuah kondisi yang kaku atau "hitam-putih". Ia adalah sebuah spektrum luas yang sangat dinamis dan menyentuh setiap sisi kehidupan manusia. Konsep ini jauh lebih dalam daripada sekadar istilah "tidak sakit jiwa". Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa kesehatan mental berarti seseorang merasa sejahtera, sadar akan kemampuan dirinya, tangguh menghadapi tekanan hidup, serta mampu berperan aktif di lingkungan sosialnya (WHO, 2022).

Untuk memahaminya lebih mudah, ada sebuah konsep yang disebut sebagai "rentang kesehatan mental". Konsep ini mengingatkan bahwa ada kondisi yang disebut *languishing*, yaitu saat seseorang tidak terdiagnosis gangguan jiwa, namun ia merasa hampa dan kehilangan arah dalam hidupnya. Tujuan utama dari perawatan jiwa adalah membantu setiap orang mencapai tahap *flourishing*, sebuah kondisi di mana hidup terasa bermakna, penuh semangat, dan terus berkembang secara mental maupun sosial (Keyes, 2002).

Perjalanan cara pandang manusia terhadap kesehatan mental pun telah mengalami perubahan yang luar biasa. Memahami sejarah ini sangat penting agar pendekatan yang digunakan sekarang tidak lagi kaku. Dahulu, pada era rumah sakit besar (model medis), fokus utama hanya terbatas pada penyakit dan gejala fisik semata. Pada masa itu, seseorang sering kali diisolasi, dan keberhasilan perawatan hanya diukur dari hilangnya gejala seperti halusinasi atau kecemasan (Stuart, 2014).

Seiring berjalannya waktu, pandangan ini bergeser menuju era psikososial yang melihat manusia sebagai makhluk sosial yang kompleks. Faktor lingkungan, trauma masa lalu, hingga dukungan keluarga mulai dianggap sebagai penentu utama kesehatan jiwa. Kini, dunia telah memasuki era holistik dan pemulihan (*recovery*). Fokus utamanya bukan lagi sekadar "mengobati", melainkan mendukung

proses pemulihan agar setiap orang tetap berdaya. Pendekatan modern menekankan bahwa meskipun seseorang hidup dengan kondisi mental tertentu, mereka tetap memiliki hak dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang mandiri, bermakna, serta bermartabat (American Psychiatric Association, 2022).

Pentingnya mengubah sudut pandang ini menjadi semakin nyata jika melihat kenyataan di sekitar. Data menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Berdasarkan riset kesehatan di Indonesia, terdapat tren peningkatan masalah kesehatan mental emosional yang cukup serius di tengah masyarakat. Fakta ini menegaskan satu hal penting: kesehatan mental adalah fondasi utama bagi kesehatan fisik. Tanpa kondisi mental yang baik, seseorang akan sulit untuk tetap produktif dan memiliki kualitas hidup yang tinggi (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

C. Paradigma Keperawatan Holistik

Dalam dunia kesehatan modern, kesehatan mental tidak lagi dipandang hanya sebagai masalah pola pikir yang terganggu atau sekadar ketidakseimbangan kimiawi di otak. Sebaliknya, kesehatan jiwa dipahami sebagai sebuah jalinan rumit dari berbagai sisi kehidupan yang saling berkaitan. Untuk memahaminya secara menyeluruh, tenaga kesehatan menggunakan sudut pandang "holistik" yaitu sebuah cara pandang yang melihat manusia sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari sisi fisik, mental, sosial, hingga spiritual. Jika salah satu sisi ini diabaikan, proses pemulihan seseorang biasanya akan terhambat. Berikut adalah empat pilar utama yang saling mendukung dalam kesehatan jiwa:

1. Dimensi Biologis

Dimensi ini mencakup kondisi kesehatan tubuh, faktor keturunan, hingga fungsi sistem saraf. Perlu diingat bahwa kesehatan fisik dan mental ibarat dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan; jika tubuh sedang sakit, pikiran sering kali ikut terganggu, begitu pula sebaliknya.

2. Dimensi psikologis

Bagian ini melibatkan cara seseorang berpikir, mengelola emosi, serta ketangguhan dalam menghadapi masalah. Fokusnya adalah memahami bagaimana seseorang berinteraksi dengan tekanan di sekitarnya, termasuk bagaimana latar belakang budaya memengaruhi cara mereka mencari solusi.

3. Dimensi Sosial

Sebagai makhluk yang butuh orang lain, manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Dukungan keluarga, kondisi ekonomi yang stabil, serta diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar merupakan kunci utama agar seseorang bisa pulih lebih cepat.

4. Dimensi Spiritual

Ini adalah elemen penting yang memberikan tujuan hidup. Spiritualitas tidak selalu berarti praktik keagamaan, melainkan lebih kepada pencarian makna hidup dan ketenangan batin. Memasukkan aspek ini dalam perawatan terbukti dapat meningkatkan semangat hidup dan membantu meredakan kesedihan yang mendalam.

Pendekatan yang hanya menyentuh satu sisi saja, misalnya hanya memberikan obat-obatan tanpa membantu memperbaiki cara berpikir atau mengabaikan kondisi sosial pasien sering kali gagal memberikan hasil jangka panjang. Pelayanan kesehatan mental saat ini harus benar-benar menyentuh sisi pribadi pasien secara menyeluruh. Sebagai contoh, seseorang yang sedang merasa sangat sedih dan kehilangan harapan tidak hanya membutuhkan bantuan medis, tetapi juga butuh dikuatkan mentalnya, didampingi oleh orang-orang tersayang, serta dibimbing untuk menemukan kembali makna hidupnya (WHO, 2022).

Di sinilah peran perawat jiwa menjadi sangat berarti. Sebagai sosok yang paling lama mendampingi pasien, perawat memiliki kesempatan terbaik untuk memperhatikan setiap perubahan pada seluruh aspek kehidupan pasien tersebut. Tugas seorang perawat bukan hanya soal memberikan prosedur medis, tetapi juga menjadi pendengar yang tulus dan pemberi semangat agar pasien dapat menemukan kembali harapan untuk sembuh dan menjalani hidup dengan lebih bahagia.

D. Sejarah dan Perkembangan Keperawatan Jiwa di Indonesia

Mempelajari sejarah keperawatan jiwa di Indonesia ibarat melihat sebuah perjalanan panjang dalam memanusiakan manusia. Dahulu, pada masa kolonial, cara menangani gangguan jiwa sangat dipengaruhi oleh rasa takut dan kurangnya pengetahuan medis. Akibatnya, orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan sering kali dikurung di tempat yang terisolasi, seperti rumah sakit militer atau bahkan penjara. Pada masa itu, tujuannya bukan untuk mengobati, melainkan sekadar "mengamankan" masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang dianggap berbahaya.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai membangun Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dalam skala besar. Pada era ini, tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan pengobatan. Namun, model rumah sakit besar ini punya kelemahan: pasien menjadi terputus hubungannya dengan dunia luar. Padahal, kemampuan untuk kembali bersosialisasi dengan lingkungan adalah kunci utama agar seseorang bisa benar-benar pulih. Inilah yang memicu perubahan besar

menuju layanan kesehatan yang lebih menghargai hak asasi dan melibatkan masyarakat (Stuart, 2014; WHO, 2022).

Perubahan besar ini ditandai dengan munculnya program Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas atau yang sering dikenal dengan istilah *Community Mental Health Nursing* (CMHN). Dalam model ini, perawat jiwa tidak lagi hanya menunggu pasien di dalam rumah sakit. Mereka justru bertindak proaktif dengan turun ke Puskesmas-Puskesmas hingga melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Tujuannya agar setiap individu bisa mendapatkan perawatan tanpa harus tercabut dari lingkungan sosial dan keluarganya (WHO, 2022).

Hadirnya perawat jiwa di tengah masyarakat menjadi strategi jitu untuk meruntuhkan tembok diskriminasi. Berdasarkan kenyataan di lapangan, penderita gangguan jiwa maupun tenaga kesehatan di Indonesia ternyata masih sering menghadapi label negatif atau stigma yang cukup berat (Subu dkk., 2021). Oleh karena itu, tugas perawat di tingkat komunitas menjadi sangat penting; mereka tidak hanya memberikan bantuan medis, tetapi juga mengedukasi warga agar tidak lagi mengucilkan mereka yang sedang berjuang demi kesehatan mentalnya.

E. Peran dan Kontribusi Perawatan dalam Kesehatan Mental Global

Saat ini, peran perawat dalam dunia kesehatan mental telah berkembang jauh melampaui tugas-tugas klinis biasa. Perawat jiwa kini menjadi elemen kunci dalam agenda kesehatan dunia. Di tengah meningkatnya beban masalah mental di berbagai negara, perawat tidak hanya bertindak sebagai pemberi perawatan langsung, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membela hak-hak pasien serta memperjuangkan keadilan akses kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan keseharian masyarakat, perawat memiliki posisi strategis untuk mengenali tanda-tanda awal masalah kejiwaan sebelum kondisi tersebut menjadi lebih berat. Kontribusi ini sangat berarti untuk menutupi celah antara besarnya kebutuhan layanan dengan terbatasnya jumlah tenaga profesional kesehatan mental, terutama di negara-negara yang sedang berkembang (WHO, 2022).

Di era modern yang serba cepat ini, perawat jiwa memegang tanggung jawab yang lebih luas sebagai pendidik (edukator) dan rekan kerja bagi profesi lain. Tujuannya adalah memastikan bahwa layanan kesehatan mental bisa menyatu dengan layanan kesehatan umum secara menyeluruh. Peran ini menuntut perawat untuk menguasai kompetensi global, mulai dari pemahaman mendalam tentang keberagaman budaya hingga pemanfaatan teknologi digital melalui layanan asuhan jarak jauh atau *tele-nursing*. Selain itu, kepemimpinan perawat yang suportif menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis,

baik bagi tim kesehatan maupun bagi pasien itu sendiri di tengah lingkungan rumah sakit yang kompleks (Mrayyan & Askar, 2025).

Dengan memperkuat peran sebagai pembela kebijakan, profesi keperawatan berkontribusi langsung dalam menghapus diskriminasi di dalam sistem kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang ekonominya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dukungan kesehatan yang berkualitas dan manusiawi. Hal ini merupakan perwujudan nyata dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam skala global (ICN, 2021).

F. Tren dan Isu Kesehatan Mental: Tantangan Kesehatan Mental di Era Digital

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, wajah kesehatan mental dunia mengalami pergeseran drastis akibat menyatunya teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Era digital membawa dampak yang cukup rumit, di satu sisi menawarkan akses informasi yang sangat luas, namun di sisi lain menciptakan tekanan psikologis baru yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya. Fenomena seperti kelelahan digital (*digital burnout*), ketergantungan pada media sosial, hingga kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus telah menjadi tantangan nyata bagi ketenangan emosional masyarakat saat ini.

Kenyataan ini diperkuat oleh temuan yang menunjukkan adanya kaitan erat antara tingginya penggunaan media sosial dengan meningkatnya rasa cemas serta penurunan rasa percaya diri, terutama pada orang dewasa muda. Paparan konten digital yang kurang sehat memang dapat memperburuk gejala kecemasan dan kesedihan yang mendalam. Hal ini sangat berisiko bagi kelompok remaja yang sedang berada dalam fase penting untuk mencari identitas diri mereka (Khalaf dkk., 2023).

Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, era digital juga membuka pintu lebar bagi inovasi dalam layanan kesehatan jiwa. Pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) serta aplikasi kesehatan mental di ponsel telah mengubah cara masyarakat mendapatkan bantuan awal secara signifikan. Teknologi ini memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan dukungan pertama dengan lebih cepat dan bersifat pribadi, yang menjadi jembatan penting dalam sistem kesehatan modern.

Dukungan terhadap perubahan digital ini juga telah diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan ini memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan layanan kesehatan jarak jauh (*telemedicine*) serta percepatan teknologi kesehatan di Indonesia. Kehadiran landasan hukum ini memberikan ruang gerak bagi perawat untuk menyatukan teknologi ke dalam perawatan pasien. Dengan begitu, layanan yang diberikan

menjadi lebih efektif, terjangkau, dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di zaman yang serba digital ini.

G. Landasan Etik dan Legal dalam Pelayanan Keperawatan Jiwa

Pelayanan kesehatan jiwa bergerak di wilayah yang sangat sensitif. Sering kali, petugas kesehatan harus berdiri di antara dua sisi: melindungi kesehatan pasien atau menghormati kebebasan pribadi mereka. Oleh karena itu, aturan etika dan hukum bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan janji moral untuk menjaga martabat setiap orang, terutama mereka yang sedang dalam kondisi rentan.

Dalam keseharian, ada empat prinsip utama yang menjadi kompas bagi tenaga kesehatan. Pertama adalah menghormati hak pribadi pasien untuk menentukan pilihannya sendiri (*autonomy*). Kedua dan ketiga adalah kewajiban untuk selalu berbuat baik (*beneficence*) tanpa merugikan pasien (*non-maleficence*). Terakhir adalah prinsip keadilan (*justice*) bagi siapa pun. Tantangan terbesar muncul saat seorang perawat harus memutuskan tindakan medis demi keselamatan nyawa pasien yang mungkin saat itu sedang tidak mampu berpikir jernih. Situasi sulit ini menuntut perawat untuk tidak hanya terampil secara medis, tetapi juga memiliki kepekaan batin agar setiap tindakan tetap menghormati hak asasi manusia, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun (Johnstone, 2023).

Di Indonesia, fondasi hukum untuk praktik ini semakin kuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan ini membawa semangat baru untuk memanusiakan pasien jiwa, salah satunya dengan menjamin hak mereka untuk mendapatkan perawatan yang layak serta bebas dari praktik pemasungan. Negara kini mewajibkan layanan kesehatan jiwa menyatu dengan kehidupan masyarakat, mulai dari upaya pencegahan hingga pemulihan. Bagi perawat, aturan ini adalah mandat sekaligus peluang untuk menjadi pembela (advokat) hak-hak pasien. Namun, hal ini juga dibarengi dengan tanggung jawab besar, terutama dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dan rahasia medis pasien agar tidak disalahgunakan.

Selain itu, aspek hukum juga mengatur pentingnya penjelasan yang jujur sebelum tindakan medis dilakukan, atau yang dikenal dengan istilah persetujuan tindakan (*informed consent*). Perawat jiwa memiliki tugas penting untuk memastikan pasien atau keluarganya menerima informasi yang lengkap dan mudah dimengerti. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan pemahaman yang utuh mengenai manfaat maupun risikonya.

Pada akhirnya, kesembuhan mental yang sejati hanya bisa dicapai jika hak asasi manusia dijunjung tinggi dan pasien dipandang sebagai subjek utama dalam perawatannya sendiri (WHO, 2022). Dengan memahami landasan etika dan hukum

ini, tenaga kesehatan tidak hanya terlindungi secara profesi, tetapi juga mampu memberikan perawatan yang tulus untuk memuliakan martabat manusia seutuhnya.

H. Perspektif Lintas Budaya dalam Kesehatan Mental

Memahami kesehatan mental tidak bisa dilepaskan dari budaya tempat seseorang tinggal. Budaya bukan sekadar latar belakang, melainkan kacamata yang digunakan seseorang untuk memaknai rasa sakit dan penderitaan yang mereka alami. Di Indonesia, dengan ribuan suku dan tradisi, masalah kejiwaan sering kali tidak dipandang sebagai masalah medis semata. Sering kali, kondisi ini dianggap berkaitan erat dengan nilai-nilai lokal, kepercayaan spiritual, hingga aturan sosial yang sudah ada sejak lama. Fenomena seperti "kesurupan" atau "kena guna-guna" mungkin dalam ilmu medis disebut gangguan jiwa, namun bagi masyarakat setempat, hal itu adalah peristiwa spiritual yang butuh penanganan khusus.

Para ahli kesehatan global mengingatkan adanya bahaya "kebutaan budaya" yang terjadi jika tenaga kesehatan terlalu kaku menggunakan standar teori dari luar tanpa melihat kenyataan di lapangan. Banyak orang di Indonesia yang sebenarnya sedang mengalami tekanan batin hebat, namun tidak mengatakannya dengan terminologi medis seperti depresi, melainkan melalui keluhan fisik atau somatisasi seperti pusing kronis, sesak napas, atau rasa lemas yang luar biasa. Jika perawat tidak peka terhadap cara masyarakat mengungkapkan rasa sakit ini, maka akar masalah mentalnya bisa terabaikan karena hanya fokus mengobati keluhan fisiknya saja (Gureje dkk., 2020).

Di sinilah perawat jiwa berperan penting sebagai "jembatan" antara dunia medis modern dan kepercayaan masyarakat dengan melibatkan kekuatan komunitas serta kearifan lokal. Perawat harus mampu membedakan mana yang merupakan gejala klinis dan mana yang merupakan ekspresi budaya guna mencari titik temu agar pasien merasa nyaman dan dihargai. Menghargai kepercayaan pasien, seperti melibatkan dukungan tokoh agama atau pendekatan kekeluargaan, sering kali menjadi kunci utama agar pasien merasa diterima dan bersedia menjalani pengobatan secara rutin (Gopalkrishnan, 2018).

Langkah ini juga sejalan dengan aturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus menghormati norma dan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Dengan menggabungkan standar keamanan medis dan rasa hormat terhadap budaya setempat, asuhan keperawatan jiwa akan terasa lebih manusiawi. Pasien tidak hanya sembuh secara klinis, tetapi juga merasa tetap menjadi bagian dari masyarakatnya karena identitas dan keyakinan pasien tetap dijunjung tinggi.

I. Ketahanan Mental Tenaga Kesehatan dan Dukungan Sistem Sosial

Keberhasilan dalam membantu pasien sangat bergantung pada kesehatan mental perawat itu sendiri. Mengingat perawat bekerja di lingkungan yang penuh tantangan, mulai dari menghadapi ketidakstabilan emosi pasien hingga risiko kelelahan fisik, menjaga kondisi psikologis perawat menjadi hal yang mutlak. Penelitian menunjukkan bahwa ketangguhan mental seorang perawat berpengaruh langsung pada keselamatan pasien. Kondisi stres berat atau burnout (kelelahan kerja) dapat menghambat pemberian empati dan meningkatkan risiko kesalahan medis. Oleh karena itu, kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kesejahteraan emosional para tenaga kesehatan yang bertugas (Melnik dkk., 2025).

Menjaga kesehatan diri bagi perawat bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kewajiban profesional yang harus didukung oleh lingkungan kerja yang sehat. Fasilitas seperti sesi berbagi cerita antarrekan kerja (*peer support*) atau kebijakan jam kerja yang manusiawi sangat diperlukan untuk melepaskan beban emosional setelah bertugas. Perawat yang sehat secara mental akan memiliki kesabaran dan profesionalisme yang lebih stabil, sehingga mereka bisa menjadi pendamping yang kuat bagi pasien dalam perjalanan menuju kesembuhan.

Namun, perlu diingat bahwa pemulihan pasien tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan perawatan di rumah sakit. Keluarga dan lingkungan sekitar memegang peranan yang sangat besar dalam keberhasilan jangka panjang. Pengobatan yang paling efektif adalah yang berlanjut hingga ke lingkungan rumah agar pasien tidak merasa terasing dari dunianya. Keluarga adalah orang terdekat yang mendampingi pasien setiap hari, namun mereka juga manusia biasa yang rentan merasa lelah dan stres. Tanpa pemahaman yang benar, beban emosional keluarga justru bisa memengaruhi kondisi pasien (WHO, 2022).

Di sinilah pentingnya memberikan edukasi kepada keluarga agar mereka tahu cara menghadapi pasien dengan sabar dan tepat. Sinergi antara perawat yang tangguh, keluarga yang paham cara merawat, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, akan menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyembuhan. Tujuan akhirnya adalah membantu pasien agar bisa kembali berdaya, diterima oleh lingkungan tanpa rasa malu, dan mampu menjalani hidup yang bermakna kembali di tengah masyarakat.

J. Teori dan Model Konseptual Keperawatan Jiwa

Memahami teori keperawatan sebenarnya bukan hanya soal menghafal di bangku sekolah, melainkan tentang bagaimana ilmu tersebut menjadi penuntun bagi perawat untuk memberikan asuhan yang lebih manusiawi. Salah satu

pandangan yang paling menyentuh adalah teori dari Jean Watson. Ia menegaskan bahwa inti dari keperawatan adalah proses kepedulian (caring) dan hubungan antarmanusia yang mendalam. Perawat tidak hanya hadir untuk memberikan pengobatan secara fisik, tetapi juga menciptakan koneksi yang menghargai martabat pasien. Penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa penerapan teori ini dalam praktik nyata terbukti meningkatkan kualitas pemulihan serta membuat pasien merasa lebih puas dan dihargai (Alligood, 2014).

Selain hubungan antarmanusia, sudut pandang mengenai cara manusia beradaptasi juga sangat penting. Setiap orang ibarat sebuah sistem yang terus-menerus menghadapi berbagai tantangan hidup, baik dari tekanan batin maupun lingkungan sekitar. Di sinilah tenaga keperawatan berperan sebagai "penyeimbang". Ketika seseorang merasa kehilangan arah akibat beban hidup yang berat, perawat hadir untuk membantu menemukan kembali kekuatan terpendam agar orang tersebut mampu bertahan dan bangkit. Pendekatan ini terbukti sangat membantu, terutama bagi mereka yang sering merasakan sakit pada tubuh akibat beban pikiran yang terlalu menumpuk (Masters, 2024).

Saat ini, cara memandang kesehatan jiwa pun sudah semakin meluas dan menyeluruh. Masalah kesehatan mental tidak lagi hanya dilihat sebagai gangguan pada fungsi otak, tetapi juga berkaitan erat dengan ketenangan batin dan kekuatan spiritual. Dengan memadukan perawatan medis dan teknik relaksasi seperti meditasi atau olahraga pernapasan, seseorang diajak untuk memulihkan keharmonisan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Pendekatan yang menyentuh sisi kemanusiaan terdalam ini terbukti memberikan ketenangan yang lebih awet dan stabil karena menyentuh akar kesejahteraan manusia secara utuh (Belchamber & Payne, 2022).

K. Upaya Promotif dan Preventif dalam Keperawatan Jiwa Komunitas

Kesehatan jiwa pada dasarnya bukan hanya urusan rumah sakit jiwa, melainkan tanggung jawab bersama di tengah lingkungan tempat tinggal. Langkah yang paling utama adalah melakukan upaya pencegahan dan promosi kesehatan sejak dini. Tujuannya sederhana namun sangat penting: membekali setiap orang agar tetap tangguh secara mental dalam menghadapi dinamika kehidupan yang serba cepat. Melalui edukasi mengenai cara mengelola stres dan pemahaman yang benar, masyarakat sebenarnya sedang diajak untuk membangun "benteng pertahanan diri" agar tidak mudah goyah saat menghadapi masa-masa sulit (WHO, 2022).

Dalam dunia keperawatan komunitas, terdapat strategi yang tertata rapi untuk menjaga kesehatan jiwa warga. Langkah awalnya adalah dengan mengenali risiko sedini mungkin. Sebagai contoh, memberikan pendampingan bagi para remaja yang sering kali merasa tertekan oleh beban pelajaran atau pengaruh lingkungan digital.

Saat ini, tenaga kesehatan mulai lebih aktif terjun ke lapangan, bahkan menyediakan layanan konsultasi atau pemeriksaan (skrining) kesehatan jiwa yang lebih mudah diakses melalui bantuan teknologi. Hal ini dilakukan agar masalah-masalah kecil yang dirasakan masyarakat tidak menumpuk menjadi beban mental yang lebih berat di kemudian hari (Kemenkes RI, 2023).

Terakhir, peran perawat sangatlah berarti dalam mendampingi mereka yang sedang berupaya bangkit kembali agar bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Tantangan terbesar dalam proses ini sering kali bukan berasal dari kondisi medisnya, melainkan dari pandangan negatif atau pengucilan oleh lingkungan sekitar. Di sinilah perawat hadir sebagai jembatan untuk memberikan pengertian kepada warga bahwa setiap orang yang pernah mengalami masa sulit berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dengan dukungan yang tulus dan pendampingan yang tepat, seseorang yang pernah berjuang dengan masalah kesehatan mental dapat kembali berkarya dan menjalani hidup yang produktif di tengah masyarakat (Halter & Varcarolis, 2014).

L. Penutup

Penting untuk disadari kembali bahwa memahami kesehatan mental bukan sekadar upaya mempelajari teori klinis atau menghafal jenis-jenis penyakit. Lebih dari itu, ini adalah tentang mengasah kepekaan terhadap martabat kemanusiaan yang sering kali terabaikan. Perjalanan panjang yang telah ditelusuri, mulai dari perubahan cara pandang tentang arti sehat, sejarah layanan kesehatan di Indonesia, hingga aturan hukum terbaru, menunjukkan bahwa profesi keperawatan memikul tanggung jawab moral yang besar. Perawat berada pada posisi penting untuk menjaga keseimbangan antara asuhan yang berdasarkan bukti ilmiah dengan sentuhan empati yang tulus.

Di tengah dinamika era digital yang kian rumit, tantangan yang dihadapi perawat tidak lagi terbatas pada dinding ruang perawatan di rumah sakit. Peran perawat kini meluas menjadi seorang pendidik yang harus mampu meluruskan pemahaman keliru di masyarakat, seorang pembela (advokat) yang berani menyuarakan hak-hak pasien di bawah payung hukum yang berlaku, serta pendamping yang membantu masyarakat menghadapi arus informasi dan tekanan media sosial. Keberhasilan dalam merawat jiwa seseorang tidak hanya diukur dari hilangnya gejala penyakit, tetapi dari sejauh mana seseorang dibantu agar mampu menemukan kembali makna hidupnya dan berfungsi secara optimal di lingkungan sosial.

Dengan memegang teguh prinsip etika dan aturan hukum yang telah dibahas, setiap perawat kini memiliki arah yang kuat untuk menjalankan peran profesional

tersebut. Pemahaman dasar ini merupakan fondasi yang tidak boleh goyah sebelum melangkah lebih jauh ke tahap tindakan medis berikutnya. Harapannya, landasan filosofis ini tidak hanya tersimpan sebagai pengetahuan di dalam buku, tetapi menjelma menjadi sikap profesional yang menghargai setiap proses kehidupan manusia dengan sepenuh hati.

Referensi

- Alligood, M. Raile. (2014). *Nursing theory: utilization & application*. Elsevier Mosby.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TR*. American Psychiatric Association Publishing.
- Belchamber, Caroline., & Payne, R. A. . (2022). *Payne's handbook of relaxation techniques: a practical handbook for the health care professional*. Elsevier.
- Gopalkrishnan, N. (2018). Cultural Diversity and Mental Health: Considerations for Policy and Practice. *Frontiers in Public Health*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00179>
- Gureje, O., Lewis-Fernandez, R., Hall, B. J., & Reed, G. M. (2020). Cultural considerations in the classification of mental disorders: why and how in ICD-11. *BMC Medicine*, 18(1), 25. <https://doi.org/10.1186/s12916-020-1493-4>
- Halter, M. J. ., & Varcarolis, E. M. . (2014). *Varcarolis' foundations of psychiatric mental health nursing: a clinical approach*. Elsevier.
- ICN. (2021). *Global Nursing Priorities: Investing in the Nursing Workforce for Mental Health*.
- Johnstone, M.-Jane. (2023). *Bioethics: a nursing perspective*. Elsevier Australia.
- Kemenkes RI. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam Angka*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Keyes, C. L. M. (2002). The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. *Journal of Health and Social Behavior*, 43(2), 207. <https://doi.org/10.2307/3090197>
- Khalaf, A. M., Alubied, A. A., Khalaf, A. M., & Rifaey, A. A. (2023). The Impact of Social Media on the Mental Health of Adolescents and Young Adults: A Systematic Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.42990>
- Masters, K. (2024). *Role Development in Professional Nursing Practice*.
- Melnyk, B. M., Davidson, J. E., Tucker, S., Tan, A., Hsieh, A. P., Cooper, A., Mayfield, C., & Hoying, J. (2025). Burnout, Mental Health, and Workplace Characteristics: Contributors and Protective Factors Associated With

- Suicidal Ideation in High-Risk Nurses. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 22(3). <https://doi.org/10.1111/wvn.70042>
- Mrayyan, M. T., & Askar, A. I. (2025). Effect of Nursing Leaders' Moral Leadership on Nurses' and Teams' Psychological Safety: A Cross-Sectional Online Study. *Sage Open Nursing*, 11. <https://doi.org/10.1177/23779608251397449>
- Stuart, G. Wiscarz. (2014). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. Elsevier Health Sciences.
- Subu, M. A., Wati, D. F., Netrida, N., Priscilla, V., Dias, J. M., Abraham, M. S., Slewa-Younan, S., & Al-Yateem, N. (2021). Types of stigma experienced by patients with mental illness and mental health nurses in Indonesia: a qualitative content analysis. *International Journal of Mental Health Systems*, 15(1), 77. <https://doi.org/10.1186/s13033-021-00502-x>
- WHO. (2022). *World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All*.

Glosarium

A – C

- Autonomy (Otonomi) : Prinsip etik yang menghormati hak pribadi pasien untuk mengambil keputusan sendiri atas perawatan dan hidupnya.
- Beneficence : Kewajiban tenaga kesehatan untuk selalu melakukan tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi pasien.
- Burnout : Kondisi kelelahan fisik dan mental yang hebat akibat stres kerja yang berkepanjangan, sering dialami oleh tenaga kesehatan.
- Caring : Inti dari keperawatan menurut Jean Watson yang menekankan pada hubungan antarmanusia yang mendalam dan empati yang tulus.
- Community Mental Health Nursing (CMHN) : Keperawatan kesehatan jiwa komunitas; model pelayanan di mana perawat proaktif memberikan asuhan di tingkat Puskesmas hingga kunjungan rumah.

D – H

- Digital Burnout : Kelelahan mental yang disebabkan oleh penggunaan teknologi digital dan media sosial secara berlebihan.
- Dimensi Biologis : Aspek kesehatan jiwa yang berkaitan dengan fisik, genetika, dan fungsi sistem saraf.
- Dimensi Psikososial : Sudut pandang yang melihat manusia sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan, trauma, dan hubungan keluarga.
- Flourishing : Kondisi mental yang ideal di mana seseorang merasa hidupnya penuh semangat, bermakna, dan terus berkembang secara sosial maupun mental.
- Holistik : Pendekatan menyeluruh dalam keperawatan yang melihat manusia sebagai satu kesatuan utuh (fisik, mental, sosial, dan spiritual).

I – P

- Informed Consent : Persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau keluarga setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jujur dari tenaga kesehatan.

Justice (Keadilan)	: Prinsip etik untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang.
Languishing	: Kondisi di mana seseorang tidak memiliki gangguan jiwa yang terdiagnosis, namun merasa hampa, kosong, dan kehilangan arah hidup.
Non-maleficence	: Prinsip etik untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan atau memperburuk kondisi pasien (do no harm).
Paradigma Keperawatan	: Pola pikir atau kerangka kerja yang mendasari pemberian asuhan keperawatan.
Pemasungan	: Praktik pengurungan atau pengikatan penderita gangguan jiwa yang kini dilarang keras secara hukum dan etika.
Preventif	: Upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko terjadinya gangguan kesehatan mental.
Promotif	: Upaya peningkatan kesehatan mental melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

R – T

Recovery (Pemulihan)	: Proses di mana individu dengan masalah kesehatan mental didukung untuk tetap berdaya, mandiri, dan hidup bermartabat.
Rentang Sehat-Sakit Jiwa	: Konsep yang menyatakan bahwa kesehatan mental adalah kondisi dinamis (seperti spektrum), bukan kondisi kaku "sakit" atau "sehat" saja.
Somatisasi	: Munculnya keluhan fisik (seperti pusing atau sesak napas) yang sebenarnya bersumber dari tekanan batin atau masalah mental.
Spiritualitas	: Pencarian makna hidup dan ketenangan batin; tidak selalu berkaitan dengan agama tertentu tetapi menjadi elemen penting dalam pemulihan.
Stigma	: Label negatif atau pandangan buruk dari masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa yang sering kali menghambat proses penyembuhan.
Tele-nursing/ Telemedicine	: Layanan asuhan keperawatan atau medis yang dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi digital.

BAB 2

INTERVENSI KEPERAWATAN PADA GANGGUAN DEPRESI DAN ANSIETAS

A. Pendahuluan

Gangguan kesehatan mental, khususnya depresi dan ansietas, merupakan masalah kesehatan global yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Organisasi kesehatan dunia, yaitu World Health Organization, melaporkan bahwa depresi menjadi salah satu penyebab utama disabilitas di dunia, sementara gangguan ansietas termasuk dalam kelompok gangguan mental dengan prevalensi tertinggi di berbagai negara. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek psikologis individu, tetapi juga memengaruhi fungsi sosial, produktivitas kerja, serta kualitas hidup secara keseluruhan.

Depresi merupakan gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan kesedihan mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas, gangguan tidur, serta perubahan nafsu makan. Sementara itu, ansietas adalah respon emosional berupa rasa khawatir yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Kedua gangguan ini sering muncul secara bersamaan (komorbid), sehingga memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan kompleksitas penanganan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa individu dengan ansietas memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, demikian pula sebaliknya, yang menunjukkan adanya hubungan yang erat secara psikopatologis (Silva et al., 2026).

Di Indonesia, prevalensi gangguan mental emosional juga menunjukkan tren peningkatan. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui laporan kesehatan nasional menyebutkan bahwa gangguan depresi dan kecemasan banyak ditemukan pada kelompok usia produktif, remaja, hingga lansia. Faktor pemicu yang beragam seperti tekanan sosial, ekonomi, perubahan gaya hidup, serta dampak pasca pandemi menjadi penyebab utama meningkatnya kasus tersebut (Kemenkes RI, 2023).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, perawat memiliki peran strategis dalam menangani pasien dengan gangguan depresi dan ansietas. Perawat tidak hanya berperan dalam pemberian asuhan keperawatan secara fisik, tetapi juga dalam intervensi psikososial yang berfokus pada peningkatan kemampuan coping, regulasi emosi, serta dukungan sosial pasien. Intervensi keperawatan berbasis bukti (evidence-based nursing) seperti terapi kognitif perilaku (Cognitive Behavioral

Therapy), mindfulness, terapi relaksasi, dan psychoeducation telah terbukti efektif dalam menurunkan gejala depresi dan ansietas secara signifikan (Maulida, 2026; Wijaya, 2026).

Selain itu, pendekatan teori keperawatan seperti teori adaptasi Sister Callista Roy dan teori caring Kristen Swanson menjadi landasan penting dalam memberikan intervensi yang holistik dan berpusat pada pasien. Teori-teori ini menekankan pentingnya hubungan terapeutik, empati, serta kemampuan pasien dalam beradaptasi terhadap stresor psikologis yang dialaminya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut memengaruhi inovasi dalam intervensi keperawatan, seperti penggunaan terapi berbasis digital, aplikasi kesehatan mental, serta pendekatan komunitas yang lebih luas. Hal ini menuntut perawat untuk terus meningkatkan kompetensi dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan buku mengenai intervensi keperawatan pada gangguan depresi dan ansietas menjadi sangat penting sebagai sumber referensi ilmiah bagi mahasiswa keperawatan, tenaga kesehatan, maupun praktisi di bidang kesehatan mental. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar, teori, serta implementasi intervensi keperawatan berbasis bukti dalam menangani gangguan depresi dan ansietas.

B. Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) merupakan salah satu intervensi psikologis yang paling banyak digunakan dalam penatalaksanaan gangguan depresi dan ansietas. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan modifikasi pola pikir negatif (cognitive distortions) yang memengaruhi emosi dan perilaku individu. CBT berakar pada teori kognitif yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck, yang menyatakan bahwa gangguan psikologis, termasuk depresi dan ansietas, disebabkan oleh interpretasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri, lingkungan, dan masa depan (cognitive triad). Dalam konteks keperawatan, CBT menjadi intervensi yang sangat relevan karena dapat diintegrasikan dalam proses asuhan keperawatan melalui komunikasi terapeutik, edukasi, dan pembinaan koping adaptif. Perawat berperan dalam membantu pasien mengenali pikiran otomatis negatif, mengevaluasi validitasnya, serta menggantinya dengan pola pikir yang lebih rasional dan konstruktif.

Penerapan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dalam praktik klinis dilakukan secara bertahap melalui beberapa sesi terstruktur yang bertujuan untuk mengubah pola pikir maladaptif dan perilaku disfungsional pasien. Pendekatan ini sejalan dengan teori kognitif oleh Aaron T. Beck yang menekankan bahwa perubahan

kognitif akan berdampak langsung terhadap emosi dan perilaku individu. Berdasarkan hasil studi kasus empiris, intervensi CBT dilaksanakan dalam tujuh sesi utama sebagai berikut:

Sesi I: Pra-Intervensi

Pada tahap awal, dilakukan kontrak terapeutik antara terapis dan klien terkait rencana intervensi. Klien menunjukkan komitmen untuk mengikuti seluruh proses terapi. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa klien telah mampu mengidentifikasi permasalahan secara umum dalam aspek sosial, pendidikan, dan psikologis, namun belum sepenuhnya menyadari kondisi emosional yang dialami, seperti perasaan sedih berkepanjangan dan tekanan psikologis.

Selain itu, ditemukan adanya gangguan fungsi sehari-hari yang meliputi:

1. Penarikan diri dari interaksi sosial
2. Pola makan tidak sehat
3. Gangguan tidur (insomnia)
4. Penurunan aktivitas perawatan diri
5. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai

Temuan ini konsisten dengan karakteristik depresi yang dijelaskan oleh World Health Organization, di mana terjadi gangguan fungsi emosional, kognitif, dan perilaku secara simultan (WHO, 2022).

Sesi II: Psikoedukasi

Pada sesi ini, klien diberikan pemahaman mengenai kondisi depresi yang dialami, termasuk gejala, penyebab, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Psikoedukasi juga mencakup pengenalan terhadap stigma diri (*self-stigma*), seperti keyakinan bahwa dirinya menjadi beban bagi keluarga.

Hasil intervensi menunjukkan bahwa klien mulai:

1. Memahami kondisi psikologis yang dialami
2. Mengenali hubungan antara pikiran negatif dan emosi
3. Menyadari adanya distorsi kognitif

Psikoedukasi terbukti meningkatkan *insight* pasien dan partisipasi dalam terapi, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan CBT (Cuijpers et al., 2021).

Sesi III: Restrukturisasi Kognitif

Sesi ini merupakan inti dari CBT, di mana klien diajak untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pikiran disfungsional. Klien menunjukkan adanya *core belief* negatif seperti:

1. *Worthless belief* (merasa tidak berharga)

2. *Helpless belief* (merasa tidak berdaya)

Pikiran tersebut berdampak pada munculnya emosi negatif seperti sedih, kecewa, dan perilaku *self-harm*. Melalui proses restrukturisasi kognitif, klien mulai mengembangkan pola pikir alternatif yang lebih adaptif.

Selain itu, klien dilatih menggunakan strategi koping seperti:

1. Positive self-talk
2. Deep breathing

Temuan ini menunjukkan bahwa CBT efektif dalam meningkatkan regulasi emosi dan mengurangi perilaku maladaptif.

Sesi IV: Behavioral Activation (Scheduling)

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan aktivitas terstruktur (*activity scheduling*) yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan klien dalam aktivitas positif. Klien mengidentifikasi:

1. Aktivitas menyenangkan: membaca novel, berjalan pagi, menonton film
2. Aktivitas tanggung jawab: membersihkan kamar, mencuci, merapikan tempat tidur

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan motivasi, yang merupakan masalah utama pada depresi.

Sesi V: Pemantauan

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan aktivitas selama dua minggu. Hasil menunjukkan adanya peningkatan dalam:

1. Konsistensi aktivitas harian
2. Perbaikan pola tidur (5 hari tidur optimal)
3. Peningkatan aktivitas mandiri

Namun, masih ditemukan hambatan pada pola makan yang belum sepenuhnya sehat. Secara keseluruhan, terdapat kemajuan signifikan dalam fungsi sehari-hari klien.

Sesi VI: Evaluasi dan Penyesuaian

Pada sesi ini dilakukan identifikasi hambatan dan penyesuaian intervensi. Masalah utama yang ditemukan adalah inkonsistensi dalam pola makan sehat. Sebagai solusi, diterapkan strategi:

1. *Food journaling*
2. Identifikasi pemicu perilaku makan tidak sehat

Pendekatan ini menunjukkan bahwa CBT bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Sesi VII: Tindak Lanjut dan Terminasi

Sesi akhir bertujuan untuk mengevaluasi keberlanjutan hasil terapi dan kesiapan klien dalam melakukan manajemen diri. Hasil menunjukkan bahwa klien mengalami peningkatan dalam:

1. Kemandirian aktivitas sehari-hari
2. Konsistensi perilaku positif
3. Kemampuan mengelola emosi

CBT merupakan intervensi yang sangat kuat dalam penanganan depresi dan ansietas karena secara langsung menargetkan akar permasalahan kognitif yang mendasari gangguan tersebut. Dibandingkan intervensi lain, CBT memiliki keunggulan dalam hal struktur, efektivitas, dan keberlanjutan hasil terapi. Namun, keberhasilan CBT sangat bergantung pada keterlibatan aktif pasien dan kompetensi tenaga kesehatan dalam mengimplementasikannya. Dalam praktik keperawatan, CBT memberikan peluang besar untuk meningkatkan peran perawat sebagai pemberi intervensi psikososial yang mandiri. Dengan pelatihan yang memadai, perawat dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat secara luas.

Penelitian oleh Kholifah & Kurniawan (2025) dalam jurnal ilmiah Indonesia menunjukkan bahwa penerapan CBT pada pasien dengan *Major Depressive Disorder (MDD)* mampu menurunkan tingkat depresi secara signifikan. Intervensi dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup wawancara klinis, observasi, serta penggunaan instrumen seperti Beck Depression Inventory (BDI-II). Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa CBT efektif dalam mengubah kognisi maladaptif serta memperbaiki emosi dan perilaku pasien.

Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa depresi tidak hanya memengaruhi suasana hati, tetapi juga fungsi kognitif, perilaku, dan kondisi fisik pasien. CBT bekerja dengan memperbaiki seluruh aspek tersebut secara simultan, sehingga memberikan dampak yang lebih menyeluruh terhadap pemulihan pasien.

Temuan ini sejalan dengan penelitian lain di Indonesia yang menunjukkan bahwa CBT efektif dalam menurunkan gejala depresi sedang serta meningkatkan pola pikir positif dan perilaku adaptif pasien. Bahkan, studi literatur juga menunjukkan bahwa CBT secara konsisten memberikan hasil signifikan dalam mengatasi depresi di berbagai setting klinik.

Dalam praktik keperawatan, CBT membuka peluang besar bagi perawat untuk berperan aktif dalam intervensi psikososial. Dengan pelatihan yang memadai, perawat tidak hanya menjadi pemberi perawatan fisik, tetapi juga agen terapeutik

dalam meningkatkan kesehatan mental pasien. Oleh karena itu, integrasi CBT dalam praktik keperawatan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mental berbasis evidence. Dalam praktik keperawatan, CBT dapat diterapkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Pengkajian kognitif pasien
2. Identifikasi pikiran negatif
3. Diskusi dan klarifikasi pikiran tersebut
4. Latihan mengganti pikiran dengan alternatif positif
5. Pemberian tugas rumah (homework)
6. Evaluasi perkembangan pasien

C. Afirmasi Positif

Afirmasi positif merupakan salah satu intervensi psikologis berbasis kognitif yang digunakan untuk membantu individu mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan pernyataan positif (*positive self-talk*) yang diulang secara konsisten untuk memodifikasi pola pikir negatif yang mendasari gangguan emosional. Secara teoritis, afirmasi positif berakar pada konsep *self-perception theory* dan memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)*, khususnya dalam aspek restrukturisasi kognitif (Beck, 2011; Setiawan, 2023).

Dalam konteks depresi, individu sering mengalami distorsi kognitif berupa pikiran otomatis negatif seperti perasaan tidak berharga (*worthlessness*), tidak berdaya (*helplessness*), dan pesimisme terhadap masa depan. Afirmasi positif berfungsi sebagai stimulus kognitif untuk menggantikan pola pikir tersebut dengan keyakinan yang lebih adaptif dan konstruktif. Dengan pengulangan yang konsisten, afirmasi dapat memengaruhi sistem bawah sadar (*subconscious mind*), sehingga individu secara bertahap membangun persepsi diri yang lebih positif (Sasson, 1977; Lestari, 2020).

Dalam praktik keperawatan, afirmasi positif menjadi intervensi yang relevan karena mudah diterapkan, bersifat non-invasif, dan dapat diintegrasikan dalam proses asuhan keperawatan melalui komunikasi terapeutik, edukasi, serta pembinaan koping adaptif. Perawat berperan dalam membantu pasien mengidentifikasi pikiran negatif, menyusun afirmasi yang realistis, serta membimbing pasien dalam penerapan secara konsisten (Amalia, 2023).

Penerapan Afirmasi Positif dalam Praktik Klinis

Penerapan afirmasi positif dilakukan secara bertahap dan terstruktur untuk mencapai perubahan kognitif dan emosional yang optimal. Pendekatan ini sejalan

dengan teori kognitif yang menyatakan bahwa perubahan pada aspek kognitif akan memengaruhi emosi dan perilaku individu (Beck, 2011).

Sesi I: Pra-Intervensi

Pada tahap awal dilakukan pembentukan hubungan terapeutik antara perawat dan pasien serta kontrak terkait pelaksanaan intervensi. Pasien menunjukkan kesiapan untuk mengikuti terapi, meskipun belum sepenuhnya memahami kondisi emosional yang dialami.

Hasil pengkajian menunjukkan adanya:

1. Pikiran negatif berulang
2. Perasaan sedih berkepanjangan
3. Penurunan motivasi
4. Gangguan aktivitas sehari-hari

Selain itu, ditemukan gangguan fungsi seperti:

1. Menarik diri dari lingkungan sosial
2. Gangguan tidur
3. Penurunan minat aktivitas
4. Perawatan diri kurang optimal

Temuan ini konsisten dengan karakteristik depresi yang mencakup gangguan aspek emosional, kognitif, dan perilaku secara simultan (World Health Organization, 2022).

Sesi II: Psikoedukasi

Pada sesi ini pasien diberikan edukasi mengenai:

1. Pengertian depresi
2. Hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku
3. Konsep afirmasi positif

Pasien juga mulai mengenali adanya *self-talk* negatif yang selama ini mendominasi pikirannya.

Hasil intervensi menunjukkan:

1. Peningkatan pemahaman kondisi diri
2. Kesadaran terhadap pola pikir negatif
3. Meningkatnya keterlibatan dalam terapi

Psikoedukasi terbukti meningkatkan *insight* pasien dan partisipasi dalam terapi, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan intervensi psikologis (Cuijpers et al., 2021).

Sesi III: Identifikasi dan Penyusunan Afirmasi

Sesi ini merupakan inti intervensi, di mana pasien diajak untuk:

1. Mengidentifikasi pikiran negatif dominan
2. Mengubahnya menjadi afirmasi positif yang realistis

Contoh perubahan:

1. "Saya tidak berharga" → "Saya memiliki nilai dan sedang belajar berkembang"
2. "Saya gagal" → "Saya sedang berproses menjadi lebih baik"

Pasien mulai:

1. Mengembangkan *self-talk* positif
2. Mengurangi intensitas pikiran negatif
3. Meningkatkan harapan terhadap diri sendiri

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa afirmasi positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menurunkan pikiran negatif (Khofifah, 2025).

Sesi IV: Latihan Afirmasi Positif

Pada tahap ini pasien dilatih untuk mengucapkan afirmasi secara rutin dalam kondisi relaks.

Teknik yang digunakan:

1. Pengulangan afirmasi (3–5 kali)
2. Dilakukan pagi dan malam hari
3. Dikombinasikan dengan relaksasi napas dalam

Hasil menunjukkan:

1. Penurunan kecemasan
2. Peningkatan ketenangan
3. Munculnya emosi positif

Latihan ini membantu memperkuat internalisasi afirmasi dalam sistem kognitif pasien (Sari, 2008).

Sesi V: Pemantauan

Evaluasi dilakukan terhadap konsistensi latihan afirmasi dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil menunjukkan:

1. Pasien mulai rutin melakukan afirmasi
2. Terjadi penurunan pikiran negatif
3. Peningkatan aktivitas harian
4. Perbaikan interaksi sosial

Namun, masih ditemukan hambatan berupa:

Kurangnya konsistensi pada situasi stres tinggi

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan afirmasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal individu (Khofifah, 2025).

Sesi VI: Evaluasi dan Penguatan

Pada sesi ini dilakukan:

1. Identifikasi hambatan
2. Penguatan motivasi
3. Penyesuaian afirmasi agar lebih personal

Strategi tambahan:

1. Menulis afirmasi (*journaling*)
2. Menggunakan pengingat harian
3. Dukungan keluarga

Pendekatan ini memperkuat keberlanjutan intervensi dan meningkatkan efektivitas terapi (Damayanty & Ane, n.d.).

Sesi VII: Terminasi dan Tindak Lanjut

Sesi akhir bertujuan untuk mengevaluasi keberlanjutan intervensi.

Hasil menunjukkan:

1. Peningkatan kepercayaan diri
2. Penurunan gejala depresi
3. Kemampuan mengelola emosi lebih baik
4. Kemandirian dalam penggunaan afirmasi

Pasien dianjurkan untuk melanjutkan praktik afirmasi sebagai bagian dari *self-care* (Setiawan, 2023).

Efektivitas Afirmasi Positif dalam Depresi

Afirmasi positif merupakan intervensi yang efektif dalam mengurangi gejala depresi, terutama pada tingkat ringan hingga sedang. Intervensi ini bekerja dengan cara mengubah pola pikir maladaptif yang menjadi akar dari gangguan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa afirmasi positif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis dan menurunkan tingkat depresi (Khofifah, 2025).

Namun demikian, efektivitas afirmasi sangat bergantung pada:

1. Konsistensi latihan
2. Keyakinan individu
3. Dukungan lingkungan
4. Tingkat keparahan depresi

Pada depresi berat, afirmasi positif perlu dikombinasikan dengan terapi lain seperti CBT dan farmakoterapi untuk hasil yang optimal (Cuijpers et al., 2021).

Implikasi dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, afirmasi positif memberikan peluang bagi perawat untuk berperan aktif dalam intervensi psikososial. Perawat tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam perubahan kognitif pasien.

Langkah penerapan dalam keperawatan:

1. Pengkajian pikiran negatif pasien
2. Identifikasi pola *self-talk*
3. Penyusunan afirmasi positif
4. Latihan afirmasi secara rutin
5. Pemberian *reinforcement*
6. Evaluasi perkembangan

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *patient-centered care* dan pemberdayaan pasien dalam meningkatkan kesehatan mental (Amalia, 2023).

D. Psikososial

Intervensi psikososial merupakan pendekatan terapeutik yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi psikologis dan sosial individu melalui dukungan emosional, edukasi, serta penguatan mekanisme koping adaptif. Intervensi ini mencakup psikoedukasi, terapi keluarga, terapi kelompok, serta intervensi berbasis komunitas (Townsend & Morgan, 2021). Secara teoritis, intervensi psikososial berakar pada teori stres dan koping dari Lazarus dan Folkman, yang menyatakan bahwa respons individu terhadap stres sangat dipengaruhi oleh kemampuan koping dan dukungan sosial yang dimiliki. Dukungan psikososial berperan sebagai *buffer* yang mampu menurunkan dampak stres terhadap kondisi mental individu (Lazarus & Folkman, 1984 dalam Li et al., 2022). Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan teori adaptasi Roy, yang menekankan bahwa individu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan melalui mekanisme koping yang efektif. Dalam konteks depresi dan ansietas, intervensi psikososial membantu pasien mencapai adaptasi yang lebih baik secara fisiologis, psikologis, dan sosial.

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi psikososial secara signifikan mampu menurunkan tingkat depresi dan ansietas serta meningkatkan fungsi sosial pasien (Asiandi et al., 2026). Selain itu, intervensi ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan keterlibatan pasien dalam proses terapi (Dinarti et al., 2025).

Peran Keluarga dalam Perawatan Pasien Depresi dan Ansietas

Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memiliki pengaruh besar terhadap proses pemulihan pasien. Dalam perspektif teori sistem keluarga (Family System Theory), keluarga dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi, sehingga perubahan pada satu anggota akan memengaruhi anggota lainnya (Bowen, 1978 dalam Townsend & Morgan, 2021). Selain itu, teori dukungan sosial (Social Support Theory) menjelaskan bahwa dukungan emosional, instrumental, dan informasional dari keluarga dapat meningkatkan ketahanan psikologis individu serta menurunkan risiko gangguan mental (House, 1981 dalam Park & Schumacher, 2020). Peran keluarga meliputi:

1. Dukungan Emosional

Dukungan berupa empati, kasih sayang, dan penerimaan terbukti mampu mengurangi tingkat stres dan kecemasan pasien. Hal ini diperkuat oleh teori dukungan sosial yang menyatakan bahwa hubungan interpersonal yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis (Primadasa et al., 2024).

2. Pemantauan Terapi

Keluarga berperan dalam memastikan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan terapi psikologis. Menurut model *health belief*, kepatuhan pasien sangat dipengaruhi oleh dukungan dan keyakinan yang dibentuk dalam lingkungan keluarga (Li et al., 2022).

3. Deteksi Dini Kekambuhan

Keluarga yang teredukasi mampu mengenali tanda awal kekambuhan seperti perubahan mood, isolasi sosial, dan peningkatan kecemasan. Hal ini sesuai dengan konsep pencegahan sekunder dalam keperawatan jiwa (Townsend & Morgan, 2021).

4. Pencipta Lingkungan Terapeutik

Lingkungan keluarga yang suportif dapat menurunkan stresor eksternal yang memicu kekambuhan. Teori lingkungan terapeutik menekankan pentingnya suasana yang aman dan suportif dalam proses penyembuhan pasien (Park & Schumacher, 2020). Family psychoeducation terbukti meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat pasien serta menurunkan beban caregiver secara signifikan (Larantukan & Yudiarso, 2025; Jayanti & Lestari, 2020).

Bentuk Intervensi Psikososial Berbasis Keluarga

1. Psikoedukasi Keluarga

Psikoedukasi merupakan intervensi utama yang bertujuan meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai penyebab, gejala, serta proses pengobatan depresi dan ansietas. Pendekatan ini didasarkan pada teori pembelajaran kognitif (Cognitive Learning Theory) yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan akan memengaruhi perubahan sikap dan perilaku (Bandura, 1986). Dengan pemahaman yang baik, keluarga dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan tidak bersifat menghakimi. Program psikoedukasi terbukti efektif dalam menurunkan beban caregiver dan meningkatkan kualitas hidup keluarga (Asiandi et al., 2026).

2. Terapi Dukungan Keluarga

Terapi ini berfokus pada peningkatan komunikasi terapeutik dan hubungan interpersonal dalam keluarga. Pendekatan ini selaras dengan teori komunikasi terapeutik Peplau, yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal dalam proses penyembuhan pasien. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan menurunkan kecemasan pasien. Dukungan keluarga yang baik dapat meningkatkan stabilitas emosional pasien serta mempercepat proses pemulihan (Primadasa et al., 2024).

3. Family Psychoeducation (FPE)

FPE merupakan intervensi berbasis bukti yang menggabungkan edukasi dan terapi keluarga. Intervensi ini didukung oleh model stress-vulnerability, yang menjelaskan bahwa gangguan mental muncul akibat interaksi antara kerentanan individu dan stres lingkungan. FPE membantu mengurangi stresor keluarga serta meningkatkan kemampuan koping. Meta-analisis menunjukkan bahwa FPE secara signifikan menurunkan *caregiver burden* dan meningkatkan fungsi keluarga (Larantukan & Yudiarso, 2025).

4. Dukungan Sosial Berbasis Komunitas

Dukungan dari lingkungan sosial seperti kader kesehatan jiwa dan komunitas berperan penting dalam proses pemulihan pasien. Hal ini sejalan dengan model keperawatan komunitas, yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan mental. Dukungan komunitas dapat memperkuat sistem pendukung pasien di luar keluarga inti. Intervensi berbasis komunitas terbukti meningkatkan kepatuhan terapi dan menurunkan stres psikologis (Dinarti et al., 2025).

Peran Perawat dalam Intervensi Psikososial

Perawat memiliki peran strategis dalam implementasi intervensi psikososial, yaitu sebagai:

1. Edukator, memberikan informasi terkait penyakit dan perawatan
2. Konselor, membantu keluarga mengatasi stres emosional
3. Fasilitator, menghubungkan dengan layanan kesehatan
4. Advokat, memastikan pasien memperoleh perawatan optimal

Peran ini sesuai dengan teori hubungan interpersonal Peplau, yang menempatkan perawat sebagai agen terapeutik dalam membantu pasien mencapai pemulihan. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan model keperawatan keluarga yang menekankan interaksi antara individu dan sistem keluarga (Townsend & Morgan, 2021).

E. Penutup

Intervensi gangguan depresi dan ansietas memerlukan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti untuk mencapai hasil yang optimal. Cognitive Behavioral Therapy (CBT), afirmasi positif, serta intervensi psikososial merupakan tiga pilar utama yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesehatan mental individu. CBT berperan dalam mengidentifikasi dan mengubah distorsi kognitif yang menjadi akar permasalahan, afirmasi positif memperkuat pembentukan pola pikir adaptif melalui pengulangan keyakinan yang konstruktif,

sedangkan intervensi psikososial memperluas dukungan melalui keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial.

Integrasi ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan depresi dan ansietas tidak hanya berfokus pada aspek intrapersonal, tetapi juga mencakup dimensi interpersonal dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep keperawatan holistik yang menempatkan individu sebagai makhluk bio-psiko-sosial-spiritual. Dengan demikian, keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pasien, keluarga, tenaga kesehatan, serta sistem pendukung yang ada.

Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki posisi strategis sebagai pemberi asuhan sekaligus agen terapeutik yang mampu mengimplementasikan intervensi psikologis secara mandiri maupun kolaboratif. Peningkatan kompetensi perawat dalam bidang kesehatan mental, khususnya dalam penerapan CBT, teknik afirmasi positif, dan intervensi psikososial, menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

Secara keseluruhan, pendekatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpusat pada pasien (*patient-centered care*) terbukti mampu meningkatkan kemampuan coping, kemandirian, serta kualitas hidup individu dengan depresi dan ansietas. Oleh karena itu, penguatan intervensi berbasis evidence dan pemberdayaan perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan mental menjadi kunci dalam menghadapi tantangan gangguan psikologis di masyarakat modern.

Referensi

- Amalia, N. (2023). Analisis asuhan keperawatan implementasi terapi afirmasi positif pada pasien depresi dengan masalah harga diri rendah di RSJ Provinsi Jawa Barat. STIKes Karsa Husada Garut. <http://repository.lp4mstikeskhg.org/227/>
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.
- Asiandi, A., Wigati, I., & Asrin, A. (2026). Efektivitas intervensi psikoedukasi dan dukungan psikososial terhadap beban caregiver pada pasien gangguan jiwa. *Jurnal Keperawatan Mersi*, 12(1), 45–53.
- Aziz, R., Mangestuti, R., Sholichatun, Y., Rahayu, I. T., Purwaningtyas, E. K., & Wahyuni, E. N. (2021). Measurement and profiling models of student mental health in Islamic higher education. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 1(2), 1–4.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.
- Beck, A. T. (1979). *Cognitive therapy and the emotional disorders*. Penguin Books.
- Cuijpers, P., Karyotaki, E., Reijnders, M., & Ebert, D. D. (2021). Was Eysenck right after all? A reassessment of the effects of psychotherapy for adult depression. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 30, e16. <https://doi.org/10.1017/S2045796020000957>
- Cuijpers, P., Karyotaki, E., Reijnders, M., & Huibers, M. J. H. (2021). Who benefits from cognitive behavioral therapy for depression? A meta-analytic update of the evidence. *World Psychiatry*, 20(2), 283–293. <https://doi.org/10.1002/wps.20860>
- Dinarti, D., Nurhaeni, H., Nuraeni, A., & Aprianti, T. (2025). Penanganan psikososial dengan kartu sehat psikososial pada pasien gangguan jiwa. *Quality: Jurnal Kesehatan*, 19(2), 130–137.
- Dirgayunita, A. (2016). Depresi: Ciri, penyebab dan penanganannya. *Journal An-Nafs*, 1(1), 1–14. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/psikologi/article/view/235>
- Ekers, D., Webster, L., Van Straten, A., Cuijpers, P., Richards, D., & Gilbody, S. (2020). Behavioural activation for depression; an update of meta-analysis of effectiveness and sub group analysis. *PLOS ONE*, 15(5), e0232092. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232092>
- Handayani, E. (2022). *Kesehatan mental (mental hygiene)*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.

- Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2020). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. *Cognitive Therapy and Research*, 44(5), 427–440. <https://doi.org/10.1007/s10608-019-10062-4>
- Jayanti, D. M. A. D., & Lestari, N. K. Y. (2020). Family psychoeducation increases family role in caring patients with mental disorders. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 8(2), 75–82.
- Khofifah. (2025). Afirmasi positif untuk mengurangi depresi. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(5), 1149–1154. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Khoirot, U., Astutik, F., Furqon, M. A., Suseno, A., Alvasa, B., & Nurdiansyah. (2022). Pengembangan aplikasi skrining kesehatan mental. <http://repository.uin-malang.ac.id/12963/>
- Kholifah, N., & Kurniawan, A. (2025). Cognitive behavior therapy untuk mengurangi tingkat depresi pada individu dengan major depressive disorder. *Procedia: Studi Kasus dan Intervensi Psikologi*, 13(2), 168–177. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/procedia/article/view/39325>
- Larantukan, A. M. F., & Yudiarto, A. (2025). Efektivitas family psychoeducation (FPE) untuk menurunkan caregiver burden: Meta-analisis. *Jurnal Intervensi Psikologi*, 17(1), 1–12.
- Lestari, K. P. (2020). Pengaruh afirmasi positif terhadap peningkatan kepercayaan diri individu. *Jurnal Psikologi*, 8(2), 45–52.
- Li, Q., Loke, A. Y., & Cui, Y. (2022). The effectiveness of psychoeducational interventions on caregivers of people with mental illness: A meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 127, 104162. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104162>
- Mariyani. (2022). Efektivitas cognitive behavior therapy dalam menurunkan depresi sedang. *Jurnal Riset Psikologi*, 7(2), 101–110.
- Park, E. O., & Schumacher, K. L. (2020). The state of the science of family caregiver–care recipient mutuality: A systematic review. *Nursing Outlook*, 68(5), 562–574. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2020.04.004>
- Primadasa, A., Putri, R. A., & Sari, D. P. (2024). Dukungan emosional keluarga terhadap anggota keluarga dengan gangguan jiwa. *Social Engagement Journal*, 3(2), 112–120.
- Richards, D. A., Ekers, D., McMillan, D., Taylor, R. S., Byford, S., Warren, F. C., Barrett, B., Farrand, P. A., Gilbody, S., Kuyken, W., O'Mahen, H., Watkins, E., Wright, K. A., Hollon, S. D., Reed, N., Rhodes, S., Fletcher, E., & Finning, K. (2021). Cost and outcome of behavioural activation versus cognitive behavioural therapy for depression (COBRA): A randomised, controlled, non-inferiority trial. *The*

Lancet, 388(10047), 871–880. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31140-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31140-0)

- Rizky, M., Andayani, T. R., & Sari, D. P. (2022). Efektivitas cognitive behavioral therapy dalam mengurangi depresi pada pasien. *Jurnal Eduktum*, 5(1), 45–52.
- Sari, M. K. (2008). Pengaruh relaksasi afirmasi terhadap penurunan depresi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Waluyo Husodo Tulungagung. Universitas Airlangga.
- Setiawan, D. E. (2023). Memahami potensi positive self-talk sebagai alat dalam konseling pastoral: Analisis studi kualitatif. *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling*, 4(1), 14–29. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/poimen/article/view/1440>
- Silva, L. C. M. A., et al. (2026). Nursing interventions in mental health: A systematic review. *Journal of Psychiatric Nursing*, 15(1), 1–12.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2021). *Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice* (10th ed.). F.A. Davis Company.
- World Health Organization. (2019). *Mental disorders*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- World Health Organization. (2021). *Comprehensive mental health action plan 2013–2030*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029>
- World Health Organization. (2022). *Depression and other common mental disorders: Global health estimates*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications>

Glosarium

Afirmasi Positif

Pernyataan atau kalimat yang bersifat konstruktif dan diulang secara konsisten untuk membentuk pola pikir adaptif serta meningkatkan kesejahteraan psikologis individu.

Ansietas (Kecemasan)

Respon emosional berupa perasaan khawatir, takut, atau gelisah terhadap ancaman yang belum jelas atau belum terjadi.

Behavioral Activation

Teknik dalam CBT yang berfokus pada peningkatan keterlibatan individu dalam aktivitas positif untuk mengurangi gejala depresi.

Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Pendekatan psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir negatif (kognitif) dan perilaku maladaptif untuk memperbaiki kondisi emosional individu.

Cognitive Distortion

Pola pikir yang tidak rasional atau bias negatif yang memengaruhi persepsi individu terhadap diri sendiri, lingkungan, dan masa depan.

Cognitive Triad

Konsep dalam teori kognitif yang menjelaskan tiga pola pikir negatif utama pada depresi: pandangan negatif terhadap diri, dunia, dan masa depan.

Core Belief

Keyakinan mendasar yang terbentuk sejak lama dan memengaruhi cara individu memandang diri dan lingkungannya.

Depresi

Gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, serta gangguan fungsi sosial dan aktivitas sehari-hari.

Distorsi Kognitif

Kesalahan dalam proses berpikir yang menyebabkan interpretasi tidak realistis terhadap suatu situasi.

Family Psychoeducation (FPE)

Intervensi yang menggabungkan edukasi dan dukungan kepada keluarga untuk meningkatkan kemampuan dalam merawat pasien dengan gangguan mental.

Gangguan Tidur (Insomnia)

Kondisi kesulitan untuk memulai atau mempertahankan tidur yang berdampak pada fungsi harian individu.

Helplessness

Perasaan tidak berdaya yang ditandai dengan keyakinan bahwa individu tidak mampu mengendalikan situasi yang dihadapi.

Intervensi Psikososial

Pendekatan terapeutik yang bertujuan meningkatkan fungsi psikologis dan sosial melalui dukungan emosional, edukasi, dan penguatan koping.

Koping Adaptif

Strategi yang digunakan individu untuk menghadapi stres secara efektif dan konstruktif.

Maladaptif

Pola perilaku atau respons yang tidak efektif dalam menghadapi stres atau masalah, sehingga memperburuk kondisi individu.

Monitoring (Pemantauan)

Proses evaluasi berkelanjutan terhadap perkembangan kondisi pasien selama intervensi berlangsung.

Patient-Centered Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan perawatan.

Psikoedukasi

Pemberian informasi dan pemahaman kepada pasien atau keluarga mengenai kondisi kesehatan mental dan cara penanganannya.

Restrukturisasi Kognitif

Teknik dalam CBT untuk mengidentifikasi, menantang, dan mengganti pikiran negatif dengan pola pikir yang lebih rasional.

Self-Harm

Perilaku menyakiti diri sendiri sebagai bentuk ekspresi emosi negatif atau mekanisme koping yang tidak sehat.

Self-Stigma

Stigma internal yang dialami individu berupa keyakinan negatif terhadap diri sendiri akibat kondisi yang dialami.

Self-Talk

Dialog internal individu yang dapat bersifat positif atau negatif dan memengaruhi emosi serta perilaku.

Support System (Sistem Dukungan)

Lingkungan sosial yang memberikan bantuan emosional, informasi, dan instrumental kepada individu.

Terminasi

Tahap akhir dalam proses terapi yang bertujuan mengakhiri intervensi secara terencana dan mengevaluasi hasil yang dicapai.

Therapeutic Communication (Komunikasi Terapeutik)

Teknik komunikasi yang digunakan tenaga kesehatan untuk membangun hubungan saling percaya dan membantu proses penyembuhan pasien.

Worthlessness

Perasaan tidak berharga yang sering muncul pada individu dengan depresi.

BAB 3

KEPERAWATAN JIWA BERBASIS KOMUNITAS

A. Pendahuluan

Keperawatan jiwa berbasis komunitas adalah suatu pendekatan dalam pelayanan kesehatan mental yang mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini muncul sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan jiwa yang tidak lagi hanya berpusat di rumah sakit, tetapi juga menjangkau individu di lingkungan tempat mereka tinggal, berinteraksi, dan berkembang.

Permasalahan kesehatan jiwa merupakan tantangan global yang memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup individu, keluarga, maupun masyarakat. Stigma, terbatasnya akses terhadap layanan, serta minimnya pengetahuan masyarakat kerap menjadi penghambat dalam penanganan gangguan jiwa secara maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan model pelayanan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal.

Dalam keperawatan jiwa berbasis komunitas, perawat berperan sebagai fasilitator, pendidik, advokat, dan mitra kolaborasi dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Melalui pendekatan ini, perawat tidak hanya memberikan asuhan kepada individu dengan gangguan jiwa, tetapi juga memberdayakan keluarga dan komunitas agar mampu mengenali, mencegah, serta mengatasi masalah kesehatan jiwa secara mandiri.

B. Latar Belakang dan Perkembangan Keperawatan Jiwa Berbasis Komunitas

Keperawatan jiwa berbasis komunitas berkembang sebagai respons terhadap perubahan paradigma pelayanan kesehatan mental global yang beralih dari pendekatan institusional menuju pelayanan berbasis masyarakat. Pada masa sebelumnya, individu dengan gangguan jiwa lebih banyak dirawat di rumah sakit jiwa dalam jangka panjang, yang seringkali menimbulkan isolasi sosial dan memperkuat stigma. Seiring berkembangnya pemahaman tentang kesehatan mental, pendekatan ini mulai dianggap kurang efektif dalam mendukung pemulihan jangka panjang (Stuart, 2016; Videbeck, 2018).

Menurut literatur internasional, pelayanan kesehatan jiwa modern menekankan pentingnya pemberian layanan di lingkungan tempat individu tinggal dan berinteraksi sehari-hari. Keperawatan jiwa komunitas berperan dalam

menyediakan layanan yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan berorientasi pada pemulihan (*recovery-oriented care*) dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai sistem pendukung utama (Hercelinskyj & Petrie, 2014).

Selain itu, organisasi kesehatan dunia menyebutkan bahwa gangguan jiwa merupakan salah satu penyumbang utama beban penyakit global, sehingga diperlukan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan akses layanan serta menurunkan kesenjangan pelayanan kesehatan mental. Pergeseran ini juga didukung oleh kebijakan kesehatan yang mendorong integrasi layanan kesehatan jiwa ke dalam pelayanan kesehatan primer.

C. Pengertian Keperawatan Jiwa Berbasis Komunitas

Keperawatan kesehatan jiwa komunitas adalah bentuk pelayanan keperawatan yang bersifat komprehensif, holistik, dan terpadu, dengan fokus pada masyarakat yang sehat secara mental, kelompok yang rentan mengalami stres (berisiko gangguan jiwa), serta individu yang sedang dalam masa pemulihan dan pencegahan kekambuhan gangguan jiwa (Keliat et al., 2016).

Keperawatan jiwa berbasis komunitas merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pemberian asuhan keperawatan kepada individu dengan gangguan jiwa di lingkungan masyarakat, bukan hanya di fasilitas kesehatan. Pendekatan ini menekankan keterlibatan keluarga dan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pemulihan pasien.

D. Ruang Lingkup Keperawatan Jiwa Berbasis Komunitas

Pelayanan keperawatan jiwa dalam konteks komunitas dilakukan secara langsung di rumah atau komunitas oleh tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan khusus sehingga mampu memberikan intervensi yang komprehensif dan berkesinambungan. Pelayanan keperawatan komprehensif sendiri merupakan layanan yang mencakup pencegahan primer bagi masyarakat dengan kondisi mental sehat, pencegahan sekunder bagi individu yang menghadapi masalah psikososial (berisiko gangguan jiwa), serta pencegahan tersier bagi pasien dengan gangguan jiwa yang sedang menjalani proses pemulihan (Keliat et al., 2016). Selain itu, pendekatan ini berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan model perawatan institusional, dengan tujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa sekaligus mengurangi stigma sosial terhadap penderita gangguan jiwa. Program seperti *Community Mental Health Nursing (CMHN)* terbukti efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan jiwa masyarakat melalui edukasi dan interaksi langsung antara pasien dan lingkungan sosialnya (Lismayanti, 2025).

Pelayanan keperawatan holistik merupakan bentuk pelayanan yang menyeluruh dengan memperhatikan seluruh dimensi kehidupan manusia, meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual.

1. Aspek biologis (fisik) berkaitan dengan kondisi kesehatan tubuh, seperti kehilangan anggota tubuh akibat bencana yang menuntut adanya pelayanan untuk membantu individu beradaptasi dengan perubahan fisiknya. Selain itu, berbagai penyakit fisik baik akut, kronis, maupun terminal juga dapat memengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang.
2. Aspek psikologis berhubungan dengan berbagai masalah kejiwaan yang dialami masyarakat, seperti rasa takut, trauma, kecemasan, hingga gangguan yang lebih berat, sehingga diperlukan intervensi agar individu mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi.
3. Aspek sosial terkait dengan berbagai kehilangan yang dialami individu, seperti kehilangan pasangan, anak, anggota keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, maupun harta benda. Kondisi ini memerlukan dukungan lintas sektor agar individu tetap dapat mempertahankan kehidupan sosial yang baik.
4. Aspek kultural berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seperti semangat gotong royong dan kekeluargaan, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dukungan sosial dalam menghadapi berbagai permasalahan.
5. Aspek spiritual berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan yang dimiliki masyarakat, yang dapat diberdayakan sebagai kekuatan dalam menghadapi konflik serta berbagai masalah kesehatan yang terjadi.

Pelayanan keperawatan paripurna merupakan layanan yang mencakup seluruh tingkat pelayanan, mulai dari layanan kesehatan jiwa spesialis, layanan kesehatan jiwa terintegrasi, hingga layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, berbagai potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat diberdayakan agar tercipta kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Selain itu, pelayanan keperawatan diberikan secara berkesinambungan (*continuity of care*), mencakup kondisi sehat hingga sakit maupun sebaliknya. Layanan ini dapat dilakukan di berbagai tempat, baik di rumah maupun di fasilitas pelayanan kesehatan, serta mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia, mulai dari masa dalam kandungan hingga usia lanjut.

E. Konsep Sehat Sakit dalam Keperawatan Jiwa

Konsep sehat dan sakit merupakan fondasi utama dalam praktik keperawatan, termasuk dalam keperawatan jiwa. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi penting karena menentukan cara tenaga kesehatan dalam menilai kondisi individu, merencanakan intervensi, serta mengevaluasi hasil asuhan keperawatan. Dalam konteks kesehatan mental, konsep sehat dan sakit tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai dua kondisi yang saling berlawanan, melainkan sebagai suatu spektrum yang dinamis dan terus berubah.

Perkembangan ilmu kesehatan mental menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penyakit (*disease-oriented*) menuju pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan (*well-being oriented*). Dalam pendekatan modern, kesehatan mental dipandang sebagai kondisi di mana individu mampu berfungsi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan sehat secara mental meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup, selama ia mampu beradaptasi secara efektif.

Sebaliknya, kondisi sakit dalam keperawatan jiwa tidak hanya terbatas pada adanya diagnosis gangguan mental tertentu, tetapi juga mencakup berbagai kondisi yang mengganggu keseimbangan psikologis individu. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memahami konsep sehat-sakit secara komprehensif agar dapat memberikan asuhan yang tepat dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Dalam keperawatan jiwa komunitas, konsep sehat sakit terdiri dari konsisi sehat jiwa, masalah psikososial dan kondisi gangguan jiwa.

1. Sehat Jiwa

Sehat dalam keperawatan jiwa diartikan sebagai kondisi kesejahteraan psikologis di mana individu mampu mengenali potensi dirinya, mengelola stres kehidupan sehari-hari, bekerja secara produktif, serta berkontribusi dalam masyarakat (WHO, 2025). Kesehatan mental tidak hanya diukur dari ketiadaan gejala gangguan jiwa, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengelola emosi, berpikir secara rasional, serta menjalin hubungan sosial yang harmonis.

Individu yang sehat secara mental umumnya memiliki kesadaran diri yang baik, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, individu tersebut juga mampu menghadapi stres kehidupan sehari-hari tanpa mengalami gangguan yang signifikan dalam fungsi kehidupannya.

Konsep sehat juga berkaitan erat dengan kemampuan adaptasi. Individu yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik perubahan

internal maupun eksternal, cenderung memiliki kondisi mental yang lebih stabil. Adaptasi ini mencakup penggunaan mekanisme koping yang efektif, seperti pemecahan masalah, dukungan sosial, serta pengelolaan emosi yang baik.

2. Masalah psikososial

Masalah psikososial adalah persoalan yang berkaitan dengan aspek psikologis maupun sosial, yang muncul sebagai dampak dari perubahan dalam kehidupan seseorang. Permasalahan ini memiliki hubungan timbal balik dan berpotensi besar menjadi salah satu penyebab gangguan kesehatan jiwa. Sebaliknya, gangguan kesehatan jiwa juga dapat memengaruhi kondisi sosial individu.

Beberapa ciri individu yang mengalami masalah psikososial antara lain:

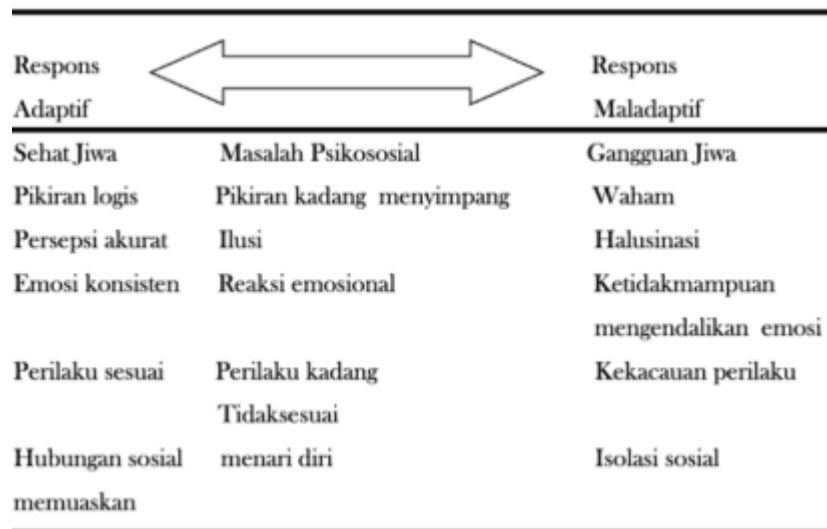
- a. Mengalami kecemasan dan kekhawatiran berlebihan
- b. Mudah tersinggung
- c. Sulit berkonsentrasi
- d. Merasa kecewa
- e. Cenderung marah dan agresif
- f. Muncul gejala fisik seperti jantung berdebar, otot tegang, sakit kepala, kesulitan tidur, atau penurunan nafsu makan

3. Gangguan jiwa

Sakit dalam konteks keperawatan jiwa merujuk pada kondisi di mana individu mengalami gangguan dalam fungsi psikologis, emosional, maupun perilaku yang mempengaruhi kemampuan berfungsi secara normal. Gangguan ini dapat berupa perubahan pola pikir, emosi, maupun perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya.

Kondisi sakit tidak selalu berarti adanya diagnosis gangguan jiwa berat, tetapi juga dapat mencakup gangguan ringan hingga sedang yang mempengaruhi kualitas hidup individu. Dalam praktik keperawatan, penting untuk memahami bahwa pengalaman sakit bersifat subjektif, sehingga persepsi individu terhadap kondisi yang dialaminya perlu menjadi pertimbangan dalam pemberian asuhan.

Gangguan kesehatan mental juga seringkali dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam keperawatan jiwa harus bersifat menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja



Gambar 3.1
Rentang sehat sakit dalam keperawatan jiwa

Konsep sehat-sakit dalam keperawatan jiwa umumnya digambarkan sebagai suatu kontinum atau rentang. Dalam konsep ini, individu tidak dikategorikan secara kaku sebagai "sehat" atau "sakit", tetapi berada pada posisi tertentu dalam suatu spektrum yang dapat berubah seiring waktu. Pada satu ujung kontinum terdapat kondisi sehat optimal, yang ditandai dengan kesejahteraan psikologis yang tinggi, kemampuan adaptasi yang baik, serta fungsi sosial yang optimal. Individu pada tahap ini mampu menghadapi stres dengan efektif serta memiliki kualitas hidup yang baik. Di sisi lain, ujung kontinum yang berlawanan menunjukkan kondisi gangguan mental berat, di mana individu mengalami disfungsi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini biasanya memerlukan intervensi intensif dan dukungan profesional yang berkelanjutan.

Di antara kedua ujung tersebut terdapat berbagai kondisi transisi, seperti stres ringan, gangguan emosional, hingga gangguan mental sedang. Konsep kontinum ini membantu perawat dalam memahami bahwa kondisi mental individu dapat berubah dan tidak bersifat statis. Pendekatan ini juga memungkinkan dilakukannya intervensi dini sebelum kondisi berkembang menjadi lebih berat. Dengan demikian, keperawatan jiwa tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan promosi kesehatan mental.

F. Tujuan Penerapan Keperawatan Jiwa Komunitas

1. Tujuan Umum Keperawatan Jiwa Komunitas

Tujuan umum keperawatan jiwa komunitas adalah meningkatkan derajat kesehatan mental masyarakat secara menyeluruh melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara berkesinambungan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada individu yang mengalami gangguan jiwa, tetapi juga pada populasi berisiko dan masyarakat secara luas (Halter, 2017; Stuart, 2013).

Selain itu, keperawatan jiwa komunitas bertujuan untuk memperluas akses layanan kesehatan mental dengan membawa pelayanan ke lingkungan masyarakat sehingga lebih mudah dijangkau. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada layanan institusional dan meningkatkan kemandirian individu dalam proses pemulihan (WHO, 2022).

2. Tujuan Khusus Keperawatan Jiwa Komunitas

a. Meningkatkan kesadaran dan literasi Kesehatan mental

Salah satu tujuan penting keperawatan jiwa komunitas adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan mental, termasuk tanda, gejala, serta cara penanganan gangguan jiwa. Edukasi kesehatan mental terbukti dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali masalah sejak dini. Peningkatan literasi kesehatan mental juga berperan dalam menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap individu dengan gangguan jiwa. Masyarakat yang memiliki pemahaman baik tentang kesehatan mental cenderung lebih menerima dan mendukung proses pemulihan pasien

b. Pencegahan Gangguan Jiwa

Keperawatan jiwa komunitas bertujuan untuk melakukan pencegahan gangguan jiwa melalui tiga tingkat pencegahan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer berfokus pada promosi kesehatan mental, sedangkan pencegahan sekunder menitikberatkan pada deteksi dini dan intervensi cepat. (Townsend & Morgan, 2018). Pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah kekambuhan dan memperbaiki fungsi sosial individu yang telah mengalami gangguan jiwa. Pendekatan ini penting untuk mengurangi dampak jangka panjang dari gangguan mental terhadap kualitas hidup individu

c. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa

Tujuan lain dari keperawatan jiwa komunitas adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas. Hal ini dilakukan dengan mendekatkan pelayanan ke lingkungan masyarakat melalui

puskesmas, kunjungan rumah, dan program berbasis komunitas. Peningkatan akses ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang membutuhkan layanan dapat memperoleh bantuan secara cepat dan tepat. Dengan demikian, risiko perburukan kondisi dapat diminimalkan melalui intervensi dini.

d. Mendukung Proses Pemulihan (*Recovery*)

Keperawatan jiwa komunitas bertujuan untuk mendukung proses pemulihan individu dengan gangguan jiwa agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial. Pendekatan *recovery* menekankan bahwa individu memiliki potensi untuk pulih dan menjalani kehidupan yang bermakna. Perawat berperan dalam membantu pasien mengembangkan keterampilan hidup, meningkatkan kemandirian, serta membangun kembali hubungan sosial yang positif. Pemulihan tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi juga pada kualitas hidup secara keseluruhan.

e. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan perawatan pasien dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, keperawatan jiwa komunitas bertujuan untuk memberdayakan keluarga agar mampu menjadi bagian dari sistem pendukung pasien. Pemberdayaan dilakukan melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan sehingga keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa secara lebih efektif. Masyarakat juga dilibatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan.

f. Mengurangi Stigma dan Diskriminasi

Stigma terhadap gangguan jiwa merupakan salah satu hambatan utama dalam pelayanan kesehatan mental. Keperawatan jiwa komunitas bertujuan untuk mengurangi stigma melalui edukasi dan peningkatan interaksi sosial antara masyarakat dan individu dengan gangguan jiwa. Pengurangan stigma diharapkan dapat meningkatkan keberanian individu untuk mencari bantuan serta meningkatkan penerimaan sosial terhadap mereka yang mengalami gangguan jiwa.

g. Integrasi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Keperawatan jiwa komunitas juga bertujuan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam sistem pelayanan kesehatan primer. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Integrasi ini memungkinkan pelayanan kesehatan jiwa menjadi bagian dari sistem kesehatan yang lebih luas, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat di berbagai tingkat.

G. Prinsip-Prinsip Keperawatan Jiwa di Komunitas

Keperawatan jiwa berbasis komunitas didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain:

1. Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik menekankan bahwa kesehatan mental dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, intervensi keperawatan harus mempertimbangkan seluruh aspek tersebut secara terpadu. Konsep ini sejalan dengan teori keperawatan modern yang menekankan hubungan antara individu dan lingkungannya dalam menentukan status kesehatan

2. Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

Praktik keperawatan jiwa komunitas harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaru agar intervensi yang diberikan efektif dan aman. Penggunaan pendekatan berbasis bukti juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kesehatan pasien.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan prinsip penting dalam keperawatan komunitas. Perawat berperan sebagai fasilitator yang membantu individu dan komunitas untuk mengenali masalah kesehatan mental serta mengembangkan kemampuan dalam mengatasinya secara mandiri.

4. Aksesibilitas dan Kesenjangan

Layanan kesehatan jiwa harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pendekatan komunitas memungkinkan layanan menjangkau individu yang sebelumnya sulit mengakses fasilitas kesehatan.

5. Berorientasi pada Pemulihan (*Recovery-Oriented Care*)

Pendekatan ini menekankan bahwa individu dengan gangguan jiwa memiliki potensi untuk pulih dan menjalani kehidupan yang produktif. Fokus pelayanan tidak hanya pada pengurangan gejala, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup.

H. Pelayanan Keperawatan Jiwa Komprehensif

Pelayanan keperawatan jiwa komprehensif merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama pada kondisi pascabencana dan konflik, dengan karakteristik kondisi yang beragam dalam rentang sehat hingga sakit. Oleh karena itu, diperlukan intervensi keperawatan pada berbagai tingkat pencegahan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Secara keseluruhan, pelayanan keperawatan

kesehatan jiwa komprehensif mencakup ketiga upaya pencegahan tersebut sebagai satu kesatuan dalam penanganan.

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer dalam keperawatan jiwa berfokus pada upaya meningkatkan kesehatan mental sekaligus mencegah munculnya gangguan jiwa. Tujuan utama layanan ini adalah menjaga serta meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat agar tetap optimal. Sasaran utamanya adalah individu yang belum mengalami gangguan jiwa, mencakup seluruh kelompok usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi edukasi kesehatan, stimulasi perkembangan, sosialisasi mengenai kesehatan jiwa, pengelolaan stres, serta persiapan dalam menjalani peran sebagai orang tua.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder dalam pelayanan keperawatan berfokus pada upaya deteksi dini serta penanganan cepat terhadap masalah psikososial dan gangguan kesehatan jiwa. Layanan ini bertujuan untuk mengurangi angka kejadian gangguan jiwa. Sasaran utamanya adalah individu atau kelompok masyarakat yang berisiko atau sudah menunjukkan gejala masalah psikososial maupun gangguan kesehatan mental.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier merupakan bentuk pelayanan keperawatan yang menitikberatkan pada peningkatan fungsi individu, kemampuan bersosialisasi, serta pencegahan kekambuhan pada pasien dengan gangguan jiwa. Tujuan dari layanan ini adalah meminimalkan dampak kecacatan atau keterbatasan akibat gangguan mental. Sasaran utamanya adalah anggota masyarakat yang sedang berada pada tahap pemulihan dari gangguan jiwa.

I. Tingkatan Keperawatan Jiwa Komunitas

Keperawatan jiwa berbasis komunitas atau *Community Mental Health Nursing (CMHN)* merupakan pendekatan pelayanan keperawatan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat intervensi. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan jiwa melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam praktiknya, CMHN tidak hanya berfokus pada individu dengan gangguan jiwa, tetapi juga mencakup keluarga, kelompok, dan masyarakat luas sebagai bagian dari sistem dukungan (Allender et al., 2014; Keliat et al., 2016).

Untuk menjamin kualitas pelayanan, pengembangan kompetensi perawat CMHN dilakukan secara bertahap melalui tiga tingkat pelatihan, yaitu Basic Course

(BC), Intermediate Course (IC), dan Advance Course (AC) (Kemenkes, 2018). Setiap tingkatan memiliki fokus kompetensi, peran, dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kompleksitas pelayanan di masyarakat, yaitu :

1. *Basic Course* (BC-CMHN)

Pada tingkat dasar atau *Basic Course*, perawat dibekali dengan kemampuan fundamental dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa di masyarakat. Fokus utama pada tahap ini adalah pemahaman konsep dasar kesehatan jiwa serta kemampuan melakukan pengkajian terhadap kondisi psikologis individu dan keluarga. Perawat dilatih untuk mengenali tanda-tanda awal gangguan jiwa serta masalah psikososial yang sering muncul di masyarakat. Selain itu, perawat juga diharapkan mampu memberikan intervensi sederhana seperti edukasi kesehatan jiwa, dukungan emosional, serta kunjungan rumah untuk memantau kondisi klien. Pada tahap ini, peran perawat lebih banyak sebagai pemberi asuhan langsung dan pendidik bagi masyarakat. Keberadaan perawat di garis depan pelayanan memungkinkan deteksi dini terhadap gangguan jiwa sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi berkembang menjadi lebih berat.

2. *Intermediate Course* (IC-CMHN)

Intermediate Course menekankan pada kemampuan pengembangan program kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Pada tahap ini, perawat tidak lagi hanya berfokus pada individu, tetapi mulai melihat masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang perlu diberdayakan. Perawat dilatih untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan jiwa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, perawat juga memiliki peran penting dalam melatih kader kesehatan jiwa sebagai perpanjangan tangan pelayanan di masyarakat. Melalui pelibatan kader, upaya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan jiwa dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan. Pada tingkat ini, perawat berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang menjembatani berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan lain. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam keberhasilan program, karena permasalahan kesehatan jiwa sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

3. *Advance Course* (AC-CMHN)

Advance Course berfokus pada penguatan kemampuan manajerial dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan jiwa. Perawat pada tahap ini diharapkan mampu merencanakan program kesehatan jiwa dalam skala yang lebih luas, termasuk melakukan analisis kebutuhan masyarakat, menyusun kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan. Selain itu, perawat juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan supervisi terhadap

tenaga kesehatan lain serta memberikan pembinaan kepada kader dan perawat di tingkat yang lebih rendah. Peran strategis ini menempatkan perawat sebagai agen perubahan yang tidak hanya bekerja pada tataran praktik klinis, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan jiwa dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Ketiga tingkatan dalam CMHN tersebut pada dasarnya saling melengkapi dan membentuk suatu sistem pelayanan yang terpadu. Perawat pada tingkat dasar berperan dalam memberikan pelayanan langsung dan melakukan deteksi dini, sementara perawat pada tingkat *intermediate* memperkuat sistem melalui pengembangan program dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, perawat pada tingkat *advance* memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya pembagian peran yang jelas ini, pelayanan kesehatan jiwa di komunitas dapat dilakukan secara komprehensif, mulai dari upaya pencegahan hingga rehabilitasi.

Penerapan CMHN yang efektif juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat secara aktif. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai mitra yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jiwa bersama. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan menjadi salah satu prinsip utama dalam keperawatan jiwa komunitas. Perawat perlu mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, memahami nilai-nilai budaya setempat, serta mengembangkan intervensi yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, program kesehatan jiwa yang dijalankan tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga dapat diterima dan berkelanjutan di masyarakat.

Secara keseluruhan, tingkatan keperawatan jiwa berbasis komunitas melalui *Basic Course*, *Intermediate Course*, dan *Advance Course* menunjukkan bahwa peran perawat sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Dimulai dari pemberian asuhan langsung hingga pengelolaan program dan kebijakan, perawat memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan jiwa masyarakat. Pendekatan berjenjang ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

J. Empat Pilar Pelayanan CMHN

Pelayanan *Community Mental Health Nursing (CMHN)* merupakan pendekatan keperawatan berbasis komunitas yang menekankan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif, holistik, dan berkesinambungan pada masyarakat, baik dalam kondisi sehat, berisiko, maupun mengalami gangguan jiwa. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu (Purwaningsih et al., 2024). Dalam implementasinya, pengelolaan CMHN dikembangkan melalui empat pilar utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat, yaitu:

1. Pilar Manajemen Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Pilar pertama menekankan pada pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan kesehatan jiwa masyarakat serta menentukan intervensi yang tepat berbasis data epidemiologis dan kondisi lokal. Pelaksanaan pelayanan mencakup asuhan keperawatan jiwa di komunitas, deteksi dini gangguan jiwa, serta tindak lanjut kasus secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program serta sebagai dasar perbaikan pelayanan. Pendekatan ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan jiwa berlangsung secara terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelayanan CMHN bersifat *continuity of care*, artinya pelayanan diberikan secara berkesinambungan dari kondisi sehat hingga sakit, baik di rumah, fasilitas kesehatan, maupun lingkungan sosial lainnya (Zaini et al., 2022).

2. Pilar Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

Pilar kedua berfokus pada peningkatan kapasitas individu, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan jiwa. Pemberdayaan dilakukan melalui edukasi kesehatan jiwa, pelatihan kader, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai deteksi dini dan penanganan masalah psikososial. Keluarga memiliki peran penting dalam perawatan pasien gangguan jiwa, termasuk mengenali tanda-tanda gangguan, mengambil keputusan terkait pelayanan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Dengan pemberdayaan yang optimal, masyarakat diharapkan mampu menjadi agen utama dalam menjaga kesehatan jiwa komunitas. Program CMHN juga terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mendukung perawatan kesehatan jiwa serta mengurangi stigma terhadap penderita gangguan jiwa (Farida & Lismayanti, 2025).

3. Pilar Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program

Pilar ketiga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai sektor, seperti tenaga kesehatan, pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat. Pelayanan kesehatan jiwa tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh tenaga kesehatan, tetapi memerlukan dukungan lintas sektor agar intervensi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kemitraan ini juga mencakup integrasi program kesehatan jiwa dengan program kesehatan lain di tingkat pelayanan dasar, seperti puskesmas. Dengan adanya kerja sama lintas program, pelayanan kesehatan jiwa dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan prinsip pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan terintegrasi dalam sistem kesehatan masyarakat

4. Pilar Manajemen Kasus Kesehatan Jiwa

Pilar keempat adalah manajemen kasus, yang berfokus pada penanganan individu dengan masalah kesehatan jiwa secara menyeluruh dan berkesinambungan. Perawat CMHN berperan dalam melakukan identifikasi kasus, perencanaan intervensi, pelaksanaan asuhan keperawatan, serta monitoring dan evaluasi perkembangan pasien. Manajemen kasus bertujuan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan jika diperlukan. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan rehabilitasi dan reintegrasi pasien ke dalam masyarakat agar dapat berfungsi secara optimal. Pendekatan ini mendukung upaya pencegahan kekambuhan serta meningkatkan kualitas hidup pasien gangguan jiwa melalui layanan yang berkelanjutan

K. Hambatan Implementasi Keperawatan Jiwa di Komunitas

Implementasi keperawatan jiwa di komunitas (*Community Mental Health Nursing/CMHN*) merupakan upaya strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional, meliputi aspek individu, sosial, sistem pelayanan, serta kebijakan kesehatan. Hambatan-hambatan ini dapat memengaruhi efektivitas pelayanan serta keberlanjutan program kesehatan jiwa berbasis komunitas.

1. Hambatan Stigma dan Persepsi Negatif Masyarakat

Salah satu hambatan utama dalam implementasi keperawatan jiwa di komunitas adalah masih kuatnya stigma terhadap individu dengan gangguan jiwa. Stigma sosial menyebabkan individu enggan mencari bantuan serta menghambat proses pemulihan karena adanya diskriminasi dan penolakan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa stigma menjadi faktor utama yang membatasi

akses layanan kesehatan jiwa serta menghambat integrasi pasien ke dalam Masyarakat. Selain itu, bahkan tenaga pelaksana di komunitas masih memiliki persepsi negatif terhadap gangguan jiwa, yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan (Farida & Lismayanti, 2025; Rinawati et al., 2020).

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Perawat

Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan jiwa, khususnya perawat yang terlatih dalam CMHN, menjadi hambatan signifikan dalam implementasi program. Tidak semua perawat memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa berbasis komunitas. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas perawat menyebabkan pelayanan tidak optimal, terutama dalam penerapan pendekatan holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Selain itu, pelatihan CMHN terbukti berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan perawat dalam menangani masalah kesehatan jiwa, sehingga tanpa pelatihan yang memadai, kualitas pelayanan cenderung menurun (Ismailinar et al., 2023; Yusuf et al., 2022).

3. Keterbatasan Sistem Pelayanan dan Dukungan Fasilitas Kesehatan

Hambatan lain yang sering ditemukan adalah keterbatasan sistem pelayanan kesehatan, khususnya di tingkat pelayanan primer seperti puskesmas. Beberapa fasilitas kesehatan belum mampu menjalankan program CMHN secara optimal karena keterbatasan sarana, prasarana, serta sistem pendukung. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program CMHN di puskesmas masih belum berjalan maksimal, ditandai dengan kurangnya pemberdayaan kader serta tidak adanya evaluasi program secara berkala. Selain itu, kompleksitas masalah kesehatan jiwa yang luas dan multidimensional juga menjadi tantangan dalam sistem pelayanan berbasis komunitas (Manullang et al., 2022; Umar, 2022).

4. Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Kesehatan Jiwa

Pemberdayaan masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan CMHN, namun dalam praktiknya sering belum optimal. Kader kesehatan jiwa yang telah dibentuk sering kali belum diberdayakan secara maksimal dalam kegiatan promotif dan preventif. Kurangnya keterlibatan masyarakat menyebabkan rendahnya deteksi dini gangguan jiwa serta terbatasnya dukungan sosial terhadap pasien. Padahal, CMHN dirancang sebagai pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyelesaian masalah kesehatan jiwa (Rahman, 2024).

5. Hambatan Kebijakan dan Koordinasi Lintas Sektor

Implementasi keperawatan jiwa di komunitas juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan dan koordinasi antar sektor. Kurangnya dukungan kebijakan yang kuat serta lemahnya koordinasi lintas sektor dapat menghambat pelaksanaan program

secara menyeluruh. Hambatan struktural seperti kurangnya integrasi program kesehatan jiwa dalam sistem kesehatan nasional serta keterbatasan regulasi menjadi tantangan dalam pengembangan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas (Yusuf et al., 2022).

6. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan keberhasilan program CMHN. Namun, dalam praktiknya kegiatan evaluasi sering tidak dilakukan secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaporan program dilakukan secara rutin, tidak adanya evaluasi dari pimpinan menyebabkan program tidak berkembang dan sulit untuk diperbaiki (Umar, 2022). Tanpa evaluasi yang sistematis, sulit untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan program secara akurat.

7. Hambatan Sosial Ekonomi dan Dukungan Keluarga

Faktor sosial ekonomi juga menjadi hambatan dalam implementasi keperawatan jiwa di komunitas. Keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan, kepatuhan pengobatan, serta kemampuan keluarga dalam merawat anggota yang mengalami gangguan jiwa. Selain itu, kurangnya dukungan keluarga sering kali memperburuk kondisi pasien, karena keluarga memiliki peran penting dalam proses perawatan dan rehabilitasi di komunitas (Asyari & Widayanti, 2024).

L. Strategi Implementasi Keperawatan Jiwa di Komunitas

Implementasi keperawatan jiwa di komunitas merupakan upaya sistematis dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang berorientasi pada masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif individu, keluarga, dan komunitas sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi implementasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan kesehatan jiwa masyarakat secara optimal.

1. Strategi Pendekatan Holistik dan Komprehensif

Pendekatan holistik menjadi strategi utama dalam implementasi keperawatan jiwa di komunitas, yaitu dengan memperhatikan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual secara terpadu. Pendekatan ini terbukti meningkatkan proses pemulihan pasien, memperkuat dukungan keluarga, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perawatan kesehatan jiwa. Pelayanan keperawatan jiwa tidak hanya berfokus pada individu yang mengalami gangguan jiwa, tetapi juga mencakup kelompok berisiko dan masyarakat umum. Dengan demikian, intervensi dapat dilakukan sejak tahap promotif dan preventif

untuk mencegah terjadinya gangguan yang lebih berat (Rahman, 2024; Yusuf et al., 2022).

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Kesehatan Jiwa

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan jiwa di komunitas. Program seperti pelatihan kader kesehatan jiwa bertujuan meningkatkan literasi kesehatan mental serta kemampuan masyarakat dalam mendeteksi dan menangani masalah psikososial secara dini.

Pelatihan kader dan edukasi masyarakat terbukti mampu menurunkan stigma terhadap gangguan jiwa serta meningkatkan dukungan sosial terhadap pasien melalui interaksi langsung dan kegiatan berbasis komunitas. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perawat melalui pelatihan CMHN juga menjadi bagian penting dalam strategi ini, karena tenaga kesehatan yang kompeten akan mampu memberikan asuhan yang lebih efektif di masyarakat (Farida & Lismayanti, 2025; Ismailinar et al., 2023).

3. Strategi Integrasi Pelayanan dengan Sistem Kesehatan Primer

Integrasi pelayanan keperawatan jiwa dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, merupakan strategi penting dalam memperluas jangkauan layanan. Puskesmas berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang dapat mengidentifikasi, menangani, dan merujuk kasus gangguan jiwa secara berjenjang. Pelayanan berbasis komunitas yang terintegrasi dengan sistem kesehatan primer memungkinkan deteksi dini, intervensi cepat, serta pemantauan berkelanjutan terhadap pasien gangguan jiwa di masyarakat. Namun demikian, implementasi strategi ini sering menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pemberdayaan kader, serta kurangnya evaluasi program secara berkelanjutan (Manullang et al., 2022; Umar, 2022).

4. Strategi Pelayanan Berbasis Kunjungan Rumah dan Kontinuitas Asuhan

Pelayanan keperawatan jiwa di komunitas dilakukan secara langsung melalui kunjungan rumah (*home visit*) yang memungkinkan perawat memberikan asuhan secara kontekstual sesuai kondisi lingkungan pasien. Pendekatan ini memperkuat hubungan terapeutik antara perawat, pasien, dan keluarga. Kunjungan rumah juga memungkinkan pemantauan kepatuhan pengobatan, deteksi dini kekambuhan, serta pemberian edukasi kepada keluarga dalam merawat pasien secara mandiri. Strategi ini merupakan bagian dari prinsip *continuity of care* yang menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan jiwa

5. Strategi Kolaborasi dan Kemitraan Lintas Sektor

Pelayanan keperawatan jiwa di komunitas tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh tenaga kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat dukungan sosial, meningkatkan akses pelayanan, serta memastikan keberlanjutan program kesehatan jiwa di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi kolaboratif memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program CMHN, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kesehatan pasien (Manullang et al., 2022; Umar, 2022).

6. Strategi Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi merupakan strategi penting dalam memastikan keberhasilan implementasi keperawatan jiwa di komunitas. Kegiatan ini mencakup pencatatan, pelaporan, serta penilaian terhadap capaian program secara berkala. Melalui evaluasi, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi kendala, mengukur efektivitas intervensi, serta melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap program pelayanan. Tanpa evaluasi yang optimal, pelaksanaan CMHN cenderung tidak berjalan maksimal meskipun program telah direncanakan dengan baik (Umar, 2022).

M. Penutup

Keperawatan jiwa berbasis komunitas merupakan pendekatan strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan individu, keluarga, dan masyarakat sebagai pusat pelayanan dengan mengedepankan prinsip promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Melalui konsep ini, pelayanan kesehatan jiwa tidak lagi terbatas pada fasilitas kesehatan, tetapi hadir secara langsung di tengah kehidupan masyarakat. Sepanjang pembahasan dalam buku ini, telah diuraikan berbagai konsep, pilar, strategi implementasi, serta hambatan dalam pelaksanaan *Community Mental Health Nursing (CMHN)*. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan keperawatan jiwa di komunitas sangat ditentukan oleh sinergi berbagai komponen, termasuk tenaga kesehatan, keluarga, masyarakat, serta dukungan kebijakan dan sistem pelayanan yang memadai. Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya peningkatan kesehatan jiwa masyarakat akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Tantangan dalam implementasi keperawatan jiwa berbasis komunitas, seperti stigma, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemberdayaan masyarakat, menjadi pengingat bahwa intervensi kesehatan jiwa harus dilakukan secara

komprehensif dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperkuat literasi kesehatan jiwa di masyarakat, serta mengembangkan kebijakan yang berpihak pada pelayanan kesehatan jiwa yang inklusif dan mudah diakses. Keperawatan jiwa berbasis komunitas diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Inovasi dalam pelayanan, penguatan peran keluarga dan kader, serta pemanfaatan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa.

Referensi

- Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. D. (2014). *Community & Public Health Nursing Promoting the Public Health* (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Asyari, W. H., & Widayanti, A. W. (2024). Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pasien dengan Gangguan Jiwa: Studi Literature Review. *Majalah Farmaseutik*, 20(3). <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v20i3.96306>
- Farida, R., & Lismayanti, L. (2025). Efektivitas Program Community Mental Health Nursing (CMHN) dalam Menurunkan Stigma Gangguan Jiwa di Komunitas Literature Review. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6).
- Halter, M. J. (2017). *Varcarolis' Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach* (7th ed.). Elsevier Mosby.
- Hercelinskyj, & Petrie. (2014). *Community Mental Health Nursing*. Cambridge University Press.
- Ismailinar, I., Sulaiman, S., & Simeulu, P. (2023). PELATIHAN COMMUNITY MENTAL HEALTH NURSING (CMHN) BAGI PERAWAT DAPAT MENINGKATKAN PENANGANAN MASALAH KESEHATAN JIWA DI MASYARAKAT. *JOURNAL KEPERAWATAN*, 2(2). <https://doi.org/10.58774/jourkep.v2i2.45>
- Keliat, B. A., Akemat, Helena, N., & Nurhaeni, H. (Eds.). (2016). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas CMHN (Basic Course)*. EGC.
- Kemenkes. (2018). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa di Masyarakat*.
- Lismayanti, L. (2025). Efektivitas Program Community Mental Health Nursing (CMHN) dalam Menurunkan Stigma Gangguan Jiwa di Komunitas : Literatur Review. *Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 1191–1200.
- Manullang, Y., Rochadi, R. K., Tarigan, F. L., Nababan, D., & Bangun, H. A. (2022). Implementasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas di Puskesmas Parilitan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 8(2).
- Purwaningsih, D. R., Aryanti, D., Setyawati, Z. G., Hanafi, M., & Sugiarto, A. (2024). Penguatan Community Mental Health Nursing (CMHN). *Journal of Midwifery in Community*, 2(1).
- Rahman, R. (2024). Konsep Keperawatan Jiwa Komunitas. *Bookchapter Jiwa*, 1(2).
- Rinawati, F., Setyawati, N., Keperawatan Dharma, A., Kediri, H., Penanggungan, J., No, N., 41 A, B., Lor, K., Mojoroto, K., Kediri, J., & Timur, I. (2020). Stigma and Perceptions of the Community Mental Health Implementation Team on Mental Health Problems in the Community. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(4).
- Stuart, G. W. (2013). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. Elsevier Mosby.

- Stuart, G. W. (2016). *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart* (B. A. Keliat (Ed.)). Elsevier Ltd.
- Umar, E. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN COMMUNITY MENTAL HEALTH NURSING (CMHN) DI PUSKESMAS GUNUNG SARI SERANG. *Jurnal.Untirta.Ac.Id*.
- Videbeck, L. S. (2018). Psychiatric-Mental Health NURSING Eighth Edition. In *Wolters Kluwer*.
- WHO. (2022). *Mental Health: Strengthening Our Response*.
- Yusuf, A. ., Fitryasari. Rizki, Nihayati, E. H., & Tristiana, R. D. (2022). Keperawatan kesehatan jiwa: Pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan. *Jakarta: Salemba Medika., February*.
- Zaini, M., Widada, W., Dwi Cahya Ningrum, D., & Isnaini Agustina, I. (2022). OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN JIWA. *Jurnal of Community Health Development, 3*(2). <https://doi.org/10.20884/1.jchd.2022.3.2.5882>

Glosarium

AC-CMHN (*Advance Course - Community Mental Health Nursing*) adalah adalah tingkat pelatihan lanjutan dalam keperawatan kesehatan jiwa berbasis komunitas yang ditujukan untuk perawat yang sudah memiliki dasar CMHN (*basic course*) dan ingin memperdalam kemampuan klinis, manajerial, serta intervensi kesehatan jiwa di masyarakat

BC- CMHN (*Basic Course - Community Mental Health Nursing*) adalah pelatihan dasar dalam keperawatan kesehatan jiwa berbasis komunitas yang diberikan kepada perawat untuk membekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan awal dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

CMHN (*Community Mental Health Nursing*) adalah pendekatan pelayanan keperawatan kesehatan jiwa berbasis komunitas yang berfokus pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk individu, keluarga, serta masyarakat yang memiliki risiko atau mengalami masalah kesehatan jiwa.

IC-CMHN (*Intermediate Course - Community Mental Health Nursing*) adalah pelatihan tingkat menengah dalam keperawatan kesehatan jiwa berbasis komunitas yang berada di antara *Basic Course* dan *Advance Course*, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang lebih kompleks di komunitas.

Rehabilitasi: Proses pemulihan fungsi individu agar dapat kembali berperan di masyarakat kompleks di komunitas.

Stigma: Pandangan negatif masyarakat terhadap individu dengan gangguan tertentu

BAB 4

STIGMA DAN PENDEKATAN PSIKOSOSIAL

A. Pendahuluan

Stigma kesehatan mental merupakan salah satu hambatan utama dalam upaya pemulihan orang dengan masalah kesehatan mental dan gangguan jiwa. Stigma tidak hanya muncul sebagai sikap negatif masyarakat, tetapi juga menjelma menjadi perilaku diskriminatif, pembatasan akses layanan, penolakan sosial, hambatan pekerjaan, dan rendahnya dukungan keluarga. Dalam konteks pelayanan kesehatan jiwa, stigma dapat membuat individu menunda mencari pertolongan, menyembunyikan gejala, tidak patuh terhadap terapi, serta menarik diri dari lingkungan sosial.

Stigma dan diskriminasi kesehatan mental harus diakhiri karena keduanya menciptakan beban ganda: beban dari kondisi kesehatan mental itu sendiri dan beban sosial akibat penolakan, stereotip, dan pelanggaran hak. Komisi tersebut juga menekankan pentingnya kontak sosial, pelibatan orang dengan pengalaman hidup, reformasi kebijakan, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia sebagai bagian dari strategi anti-stigma (Thornicroft et al., 2022).

Dalam literatur terbaru, stigma tidak lagi dipahami sebagai masalah individual semata. Stigma adalah proses sosial yang bergerak dari pengetahuan yang keliru, stereotip, prasangka, sampai diskriminasi. Karena itu, intervensinya tidak cukup dilakukan melalui penyuluhan satu arah. Diperlukan pendekatan psikososial yang melibatkan perubahan kognitif, peningkatan keterampilan sosial, dukungan keluarga, pemberdayaan pasien, dukungan sebaya, perubahan organisasi layanan, dan kebijakan anti-diskriminasi.

Bab ini memfokuskan pembahasan pada hubungan antara stigma dan pendekatan psikososial. Istilah pendekatan psikososial digunakan untuk menggambarkan intervensi non-farmakologis yang memperhatikan aspek psikologis, sosial, keluarga, komunitas, dan sistem layanan. Dalam praktik keperawatan jiwa dan kesehatan masyarakat, pendekatan ini penting karena pemulihan tidak hanya ditentukan oleh perbaikan gejala, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk kembali berfungsi, merasa berharga, berelasi, bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

B. Konsep Dasar Stigma Kesehatan Mental

Secara umum, stigma kesehatan mental dapat dipahami sebagai proses pelabelan negatif terhadap individu atau kelompok yang mengalami masalah kesehatan mental. Label tersebut sering kali dikaitkan dengan anggapan berbahaya, lemah, tidak mampu, tidak dapat dipercaya, atau menjadi beban keluarga. Label ini kemudian menghasilkan jarak sosial dan perlakuan berbeda. Dalam buku referensi, penting membedakan beberapa bentuk stigma agar intervensi dapat dirancang secara tepat.

1. Public stigma

Public stigma adalah sikap, keyakinan, dan perilaku negatif masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa atau masalah kesehatan mental. Bentuknya dapat berupa ejekan, penghindaran, pengucilan, atau ketakutan berlebihan. Masyarakat sering kali memiliki prasangka negatif terhadap pasien gangguan jiwa, yang menyebabkan diskriminasi sosial, penolakan, dan isolasi (Subu et al., 2021). Stigma publik juga memengaruhi akses pasien terhadap layanan kesehatan mental (Kågström et al., 2025).

Stigma publik mencakup pandangan negatif masyarakat terhadap pasien, sedangkan self-stigma terjadi ketika pasien menerima dan mempercayai stereotip negatif tersebut (Di Vincenzo et al., 2024). Stigma ini sering kali diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa, yang menyebabkan diskriminasi dan isolasi sosial (Xie et al., 2021).

2. Self-stigma atau internalized stigma

Self-stigma terjadi ketika seseorang menginternalisasi stereotip negatif masyarakat ke dalam cara memandang dirinya. Individu mulai percaya bahwa dirinya tidak berharga, tidak mampu pulih, memalukan, atau menjadi beban. Pada psikosis dan skizofrenia, self-stigma terbukti menjadi target penting intervensi karena berkaitan dengan harga diri, harapan, fungsi sosial, dan keterlibatan dalam pemulihan. Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa intervensi multi-komponen yang menggabungkan psikoedukasi, pendekatan kognitif, dan pelatihan sosial cenderung lebih efektif dalam menurunkan self-stigma (Lamarca et al., 2024). Pasien sering menginternalisasi sikap negatif masyarakat, yang memperburuk persepsi diri mereka dan menghambat pemulihan (Xie et al., 2021; Roy & Chowdhury, 2024).

3. Family stigma dan affiliate stigma

Family stigma muncul ketika keluarga mengalami rasa malu, disalahkan, atau dijauhi karena memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Pada beberapa konteks budaya, keluarga dapat menyembunyikan anggota keluarga

yang sakit, menunda pengobatan, atau membatasi partisipasi sosial karena takut dicap negatif. Karena itu, family psychoeducation memiliki peran penting untuk meningkatkan pengetahuan, mengurangi beban, dan membangun cara pandang yang lebih suportif. Keluarga dan institusi sering kali menjadi sumber stigma melalui pelabelan, penolakan, atau pengucilan (Roy & Chowdhury, 2024; Subu et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa stigma juga memengaruhi keluarga pasien, yang sering kali mengalami stigma terkait dengan hubungan mereka dengan individu yang memiliki gangguan jiwa (Shalaby et al., 2025).

4. *Structural stigma*

Structural stigma adalah stigma yang tertanam dalam kebijakan, aturan, praktik institusi, dan sistem sosial. Contohnya adalah pembatasan kesempatan kerja, pelayanan kesehatan yang tidak ramah, kebijakan yang mendiskriminasi, atau kurangnya akses rehabilitasi berbasis komunitas. Kågström et al., (2025) menekankan bahwa penelitian tentang stigma struktural masih relatif terbatas, padahal dampaknya besar terhadap akses layanan, inklusi sosial, dan kesejahteraan. Tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, terkadang menunjukkan sikap diskriminatif terhadap pasien gangguan jiwa, yang memperburuk pengalaman pasien dalam sistem kesehatan (Roy & Chowdhury, 2024; Subu et al., 2021; Brahmi et al., 2022). Stigma ini sering kali dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan atau pengalaman langsung dengan pasien gangguan jiwa (López García et al., 2025).

C. Dampak Stigma terhadap Individu, Keluarga, Layanan, dan Masyarakat

Dampak stigma bersifat multidimensional. Pada tingkat individu, stigma menurunkan harga diri, harapan, keberanian mencari bantuan, kepatuhan pengobatan, relasi sosial, dan kualitas hidup. Pada orang dengan psikosis atau skizofrenia, self-stigma dapat memperkuat penarikan diri sosial, rasa tidak berdaya, dan rendahnya orientasi pemulihan. Penelitian intervensi pada pasien skizofrenia di Taiwan menunjukkan bahwa program anti-stigma enam minggu dapat menurunkan self-stigma dan meningkatkan harga diri, sehingga mendukung pentingnya intervensi psikososial terstruktur (Shih et al., 2022).

Pada tingkat keluarga, stigma dapat menyebabkan keluarga menyembunyikan kondisi pasien, merasa malu, mengalami beban emosional, dan kurang percaya diri dalam mendampingi pemulihan. Dalam banyak situasi, keluarga menjadi sistem dukungan utama, tetapi juga dapat menjadi sumber tekanan apabila pemahamannya tentang gangguan jiwa masih dipengaruhi mitos dan rasa takut. Oleh karena itu, pendekatan psikososial perlu memperlakukan keluarga sebagai mitra pemulihan, bukan sekadar penanggung jawab pasien.

Pada tingkat layanan, stigma dapat terlihat dalam bahasa yang merendahkan, komunikasi yang kurang empatik, asumsi bahwa pasien tidak mampu mengambil keputusan, atau pelayanan yang terlalu berorientasi kontrol. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan pasien kepada tenaga kesehatan. Pada tingkat masyarakat, stigma menurunkan inklusi sosial, membatasi kesempatan pendidikan dan pekerjaan, serta memperkuat ketimpangan. Dampak stigma dikelompokkan ke dalam ranah kesehatan, penggunaan layanan, psikososial, ekonomi, dan struktural (Kågström et al., 2025). Penelitian lain menjelaskan bahwa sebagian besar pengasuh pasien skizofrenia mengalami tingkat stigma afiliasi yang tinggi dan parah (78,66%) dan beban pengasuhan (95,26%)(Wang et al., 2023).

D. Pendekatan Psikososial: Prinsip Umum dan Orientasi Pemulihan

Pendekatan psikososial adalah rangkaian intervensi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan psikologis, fungsi sosial, relasi keluarga, kemampuan menghadapi stres, serta partisipasi individu dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak menggantikan terapi farmakologis, tetapi melengkapinya. Dalam gangguan jiwa berat, terapi obat dapat membantu mengendalikan gejala, sedangkan intervensi psikososial membantu individu membangun kembali makna hidup, keterampilan sosial, kemandirian, dan peran sosial.

Review kritis tentang intervensi psikososial pada skizofrenia menekankan bahwa praktik berbasis bukti mencakup psikoedukasi keluarga, cognitive behavioral therapy for psychosis, cognitive remediation, social skills training, supported employment, assertive community treatment, dan rehabilitasi psikososial yang dipersonalisasi (Barlati et al., 2024). Prinsip utamanya adalah pemulihan, kolaborasi, kontinuitas, keterlibatan keluarga, dan penguatan fungsi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip inti pendekatan psikososial anti-stigma

1. Berorientasi pemulihan: fokus pada harapan, kekuatan, tujuan hidup, dan partisipasi sosial.
2. Berbasis bukti: intervensi dirancang berdasarkan temuan riset, bukan hanya kebiasaan layanan.
3. Partisipatif: melibatkan pasien, keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, dan orang dengan pengalaman hidup.
4. Kontekstual budaya: menyesuaikan bahasa, nilai keluarga, agama, norma sosial, dan sumber daya lokal.
5. Anti-diskriminatif: mengurangi praktik yang merendahkan martabat dan memperkuat hak pasien.

Dalam buku referensi, pendekatan psikososial sebaiknya tidak hanya dijelaskan sebagai daftar teknik. Penulis perlu menunjukkan hubungan antara masalah stigma dan pemilihan intervensi. Misalnya, ketika masalah utama adalah pengetahuan keliru masyarakat, maka literasi kesehatan mental dan kontak sosial menjadi prioritas. Ketika masalah utama adalah self-stigma, maka Cognitive Behavioral Therapy (CBT), self-compassion, empowerment, dan dukungan sebaya lebih relevan. Ketika masalah utama adalah penolakan keluarga, maka family psychoeducation dan konseling keluarga menjadi penting.

Beberapa strategi untuk mengurangi stigma yaitu, edukasi publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gangguan jiwa melalui kampanye informasi (Di Vincenzo et al., 2024). Intervensi berbasis kontak dapat mendorong interaksi langsung antara masyarakat dan individu dengan gangguan jiwa untuk mengurangi stereotip (Di Vincenzo et al., 2024). Pendekatan budaya sensitif dengan cara menyesuaikan intervensi dengan nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan efektivitas (Shalaby et al., 2025; Rahmat et al., 2025). Program pendidikan yang menargetkan masyarakat umum dan tenaga Kesehatan juga terbukti efektif dalam mengurangi stigma (López García et al., 2025; Dias et al., 2025). Interaksi langsung dengan pasien gangguan jiwa dapat membantu mengubah persepsi negatif (Kågström et al., 2025; López García et al., 2025). Program Compassion-focused therapy (CFT) berbasis kelompok dapat mengurangi stigma diri dan berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan intervensi terapeutik berbasis bukti (Riebel et al., 2023).

E. Psikoedukasi dan Literasi Kesehatan Mental

Psikoedukasi merupakan pendekatan dasar dalam pengurangan stigma. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membantu individu, keluarga, dan masyarakat memahami bahwa gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang dapat dipahami, ditangani, dan dipulihkan. Psikoedukasi yang baik memperbaiki pengetahuan, mengurangi mitos, membangun empati, dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan terkait perawatan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan positif tentang kesehatan mental, meskipun beberapa mengungkapkan adanya stigma dan mencatat kurangnya kedalaman pendidikan (Dias et al., 2025).

Materi psikoedukasi anti-stigma dapat mencakup pengertian gangguan jiwa, faktor biologis-psikologis-sosial, tanda bahaya, cara mencari bantuan, prinsip pemulihan, hak pasien, dukungan keluarga, dan cara berkomunikasi yang tidak menghakimi. Pada keluarga pasien skizofrenia, psikoedukasi perlu dilengkapi dengan pengenalan gejala kekambuhan, manajemen obat, komunikasi terapeutik,

pengelolaan stres keluarga, dan perencanaan krisis. Edukasi yang tepat dapat diimplementasikan dari berbagai perspektif, termasuk keterampilan komunikasi, sumber daya dukungan sosial, dan topik untuk mengurangi stigma dan prasangka (Lin et al., 2022).

Studi Shih et al., (2022) menunjukkan bahwa program anti-stigma berbasis kelompok yang memuat diskusi pengalaman, edukasi tentang stigma, dan restrukturisasi sikap dapat menurunkan self-stigma serta meningkatkan harga diri. Hasil ini penting karena psikoedukasi yang efektif tidak berhenti pada transfer informasi, tetapi mendorong peserta mengevaluasi keyakinannya, memahami pengalaman stigma, dan membangun cara pandang yang lebih adaptif. Program daring juga dapat berkontribusi untuk mengurangi stigma terhadap gangguan mental (Rodríguez-Rivas et al., 2021).

F. Kontak Sosial, Narasi Pemulihan, dan Strategi Komunikasi Publik

Kontak sosial adalah strategi anti-stigma yang mempertemukan masyarakat atau kelompok sasaran dengan orang yang memiliki pengalaman hidup terkait gangguan jiwa dan pemulihan. Kontak sosial dapat dilakukan secara langsung, melalui video, cerita tertulis, forum komunitas, podcast, atau media sosial. Tujuannya adalah mengubah persepsi dari gambaran abstrak yang menakutkan menjadi pemahaman manusiawi tentang pengalaman, perjuangan, harapan, dan kemampuan pulih.

Crockett et al., (2025) menemukan bahwa intervensi anti-stigma berhubungan dengan perbaikan jangka pendek pada pengetahuan, sikap, perilaku terkait stigma, serta sikap dan niat mencari bantuan. Temuan ini mendukung penggunaan edukasi dan kontak sosial, tetapi juga mengingatkan bahwa bukti jangka panjang masih perlu diperkuat.

Dalam komunikasi publik, pesan anti-stigma perlu menghindari dua ekstrem. Pertama, pesan yang terlalu menakutkan, misalnya mengaitkan gangguan jiwa dengan kekerasan. Kedua, pesan yang terlalu kasihan sehingga menempatkan pasien sebagai objek belas kasihan. Pesan yang lebih tepat adalah pesan berbasis martabat: gangguan jiwa dapat ditangani, orang dengan masalah kesehatan mental memiliki hak yang sama, dukungan sosial mempercepat pemulihan, dan masyarakat dapat berperan menciptakan lingkungan inklusif.

Prinsip pesan anti-stigma

1. Gunakan bahasa person-first: "orang dengan skizofrenia", bukan "skizofrenik".
2. Tampilkan narasi pemulihan realistis: ada tantangan, tetapi ada harapan dan kemungkinan berfungsi.
3. Hindari sensasionalisme dan stereotip berbahaya.

4. Libatkan penyintas atau pengguna layanan sebagai narasumber, bukan hanya objek cerita.
5. Sesuaikan media dengan kelompok sasaran: sekolah, kampus, keluarga, tenaga kesehatan, atau masyarakat umum..

G. Family Psychoeducation dan Keterlibatan Caregiver

Keluarga memiliki posisi sentral dalam pemulihan kesehatan mental, terutama pada masyarakat dengan ikatan keluarga kuat. Namun keluarga juga dapat mengalami beban, kelelahan, rasa malu, konflik, dan kebingungan dalam merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Family psychoeducation dirancang untuk membantu keluarga memahami kondisi pasien, mengelola stres, berkomunikasi lebih efektif, mengenali tanda kekambuhan, dan membangun lingkungan pemulihan.

Zhang et al., (2023) menguji mindfulness-based family psychoeducation untuk caregiver dewasa muda dengan first-episode psychosis. Intervensi ini menunjukkan pentingnya menggabungkan edukasi keluarga dengan keterampilan regulasi emosi dan kesadaran penuh. Studi lanjutan juga menunjukkan bahwa program mindfulness-based family psychoeducation dapat meningkatkan pengalaman pengasuhan positif dan memengaruhi ekspresi emosi caregiver.

Penelitian longitudinal Tozoğlu dan Gürbüz, (2024) pada layanan *community mental health center* menunjukkan bahwa kombinasi psychoeducation, case management, dukungan aktivitas harian, dan promosi partisipasi sosial berkaitan dengan penurunan internalized stigma pada pasien, self-stigma keluarga, dan beban caregiver selama 12 bulan. Temuan ini menguatkan bahwa intervensi keluarga paling baik dilakukan sebagai bagian dari sistem layanan komunitas yang berkelanjutan, bukan kegiatan sesaat.

Komponen *family psychoeducation*

1. Informasi dasar tentang diagnosis, gejala, penyebab multifaktor, pengobatan, dan pemulihan.
2. Keterampilan komunikasi: mendengarkan aktif, validasi emosi, mengurangi kritik, dan menghindari menyalahkan.
3. Manajemen stres keluarga dan perawatan diri caregiver.
4. Pengenalan tanda kekambuhan dan penyusunan rencana krisis.
5. Penguatan harapan dan pengurangan stigma dalam keluarga besar.

H. Rehabilitasi Psikososial, Dukungan Sebaya, dan Integrasi Komunitas

Rehabilitasi psikososial bertujuan membantu individu memperoleh kembali keterampilan, peran, dan partisipasi sosial yang terganggu akibat masalah kesehatan mental. Intervensi ini dapat mencakup pelatihan keterampilan sosial, aktivitas okupasional, dukungan pendidikan, supported employment, manajemen kehidupan sehari-hari, kegiatan seni, olahraga, serta penguatan jaringan komunitas. Dalam konteks anti-stigma, rehabilitasi psikososial penting karena menunjukkan bahwa pemulihan bukan hanya hilangnya gejala, melainkan kembalinya fungsi dan martabat sosial.

Dukungan sebaya atau peer support juga menjadi bagian penting. Orang dengan pengalaman pemulihan dapat menjadi role model, pendamping, fasilitator kelompok, atau narasumber anti-stigma. Kehadiran peer support membantu pasien merasa tidak sendirian, meningkatkan harapan, dan menantang stereotip bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak mampu berkontribusi. Dalam kerangka The Lancet Commission, pelibatan orang dengan pengalaman hidup merupakan elemen kunci untuk mengakhiri stigma dan diskriminasi (Thornicroft et al., 2022).

Program komunitas yang efektif perlu menghubungkan layanan kesehatan, keluarga, tokoh masyarakat, kader, sekolah, tempat kerja, dan organisasi sosial. Intervensi yang hanya dilakukan di ruang klinik sering tidak cukup karena stigma banyak terjadi di luar fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, perawat jiwa komunitas dan tenaga kesehatan masyarakat perlu melakukan kunjungan rumah, pemetaan dukungan sosial, edukasi kader, mediasi keluarga, dan fasilitasi aktivitas produktif. Contoh indikator hasil rehabilitasi psikososial

1. Peningkatan aktivitas harian dan perawatan diri.
2. Peningkatan interaksi sosial dan partisipasi kegiatan komunitas.
3. Penurunan self-stigma dan rasa malu.
4. Peningkatan harapan, harga diri, dan kualitas hidup.
5. Peningkatan keterlibatan pendidikan, pekerjaan, atau aktivitas produktif.

I. Penutup

Stigma kesehatan mental merupakan persoalan sosial, psikologis, budaya, dan struktural yang berdampak langsung pada pemulihan individu. Stigma membuat orang menunda mencari bantuan, menurunkan harga diri, melemahkan dukungan keluarga, membatasi kesempatan sosial, dan memperkuat diskriminasi. Karena itu, stigma harus dipahami sebagai isu utama dalam pelayanan kesehatan jiwa, bukan sebagai masalah tambahan.

Pendekatan psikososial menawarkan jalan yang lebih komprehensif. Psikoedukasi memperbaiki pengetahuan. Kontak sosial membangun empati dan mengurangi jarak sosial. CBT, self-compassion, dan stigma resistance membantu individu melawan internalisasi label negatif. Family psychoeducation memperkuat keluarga sebagai sistem dukungan. Rehabilitasi psikososial dan peer support mengembalikan fungsi sosial dan harapan. Sementara itu, reformasi layanan dan advokasi kebijakan diperlukan untuk mengurangi stigma struktural.

Untuk konteks pendidikan dan praktik keperawatan jiwa, bab ini menegaskan bahwa intervensi anti-stigma perlu dirancang bertingkat: individu, keluarga, komunitas, layanan, dan kebijakan. Program yang hanya mengandalkan ceramah tidak cukup. Program yang lebih kuat adalah program yang menggabungkan edukasi, pengalaman kontak, keterampilan komunikasi, pendampingan keluarga, pemulihan fungsi, pelibatan penyintas, dan perubahan sistem layanan.

Referensi

- Barlati, S., Nibbio, G., & Vita, A. (2024). Evidence-based psychosocial interventions in schizophrenia: A critical review. *Current Opinion in Psychiatry*, 37(3), 131–139. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000925>
- Brahmi, L., Amamou, B., Ben Haouala, A., Mhalla, A., & Gaha, L. (2022). Attitudes toward mental illness among medical students and impact of temperament. *International Journal of Social Psychiatry*. <https://doi.org/10.1177/00207640221077551>
- Crockett, M. A., Núñez, D., Martínez, P., Borghero, F., Campos, S., Langer, Á. I., Carrasco, J., & Martínez, V. (2025). Interventions to Reduce Mental Health Stigma in Young People: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Network Open*, 8(1), 457–468. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.54730>
- Di Vincenzo, M., Cipolla, S., Arsenio, E., & Sampogna, G. (2024). Initiatives for Ending Stigma and Discrimination in Mental Health. *Sustainable Development Goals Series, Part F3757*, 35–47. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70165-8_4
- Dias, J. M., Alhmoudi, M. R., Aldhuhoori, H. A., Raeisi, A. M., Alnaqbi, N. S., Najjar, O. A., Ahmed, F. R., Abraham, M. S., Mottershead, R., Yateem, N. Al, Dias, A. R., & Subu, M. A. (2025). Unraveling Mental Health Stigma: A Qualitative Study of Health Science Students' Perceptions Toward Patients With Mental Illness in the United Arab Emirates. *Public Health Nursing*, 42(6), 1890–1899. <https://doi.org/10.1111/phn.70007>
- Kågström, A., Guerrero, Z., Aliev, A. A., Tomášková, H., Rüsch, N., Ouali, U., Thornicroft, G., Sartorius, N., & Winkler, P. (2025). Mental health stigma and its consequences: a systematic scoping review of pathways to discrimination and adverse outcomes. *EClinicalMedicine*, 89. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103588>
- Lamarca, M., Espinosa, V., Acuña, V., Vila-Badia, R., Balsells-Mejia, S., Moritz, S., Berna, F., König, C., Gawęda, Ł., Group, P., Barajas, A., & Ochoa, S. (2024). Reducing self-stigma in psychosis: A systematic review and meta-analysis of psychological interventions. *Psychiatry Research*, 342. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2024.116262>
- Lin, C. H., Lai, T. Y., Chen, Y. J., & Lin, S. K. (2022). Social distance towards schizophrenia in health professionals. *Asia-Pacific Psychiatry*, 14(3). <https://doi.org/10.1111/appy.12506>
- López García, Á., Mata-Martín, J. L., de los Santos-Roig, M., & Robles-Ortega, H. (2025). Stigma toward mental disorders in university students of health sciences. *Maskana*, 16(2), 97–112. <https://doi.org/10.18537/mskn.16.02.06>
- Rahmat, I., Merlin, N. M., & Maisyaroh, A. (2025). Unveiling the predisposing factors of

- stigma towards individuals with mental disorders: A scoping review. *Journal of Psychiatric Nursing*, 16(4), 359–367. <https://doi.org/10.14744/phd.2025.63549>
- Riebel, M., Rohmer, O., Charles, E., Lefebvre, F., Weibel, S., & Weiner, L. (2023). Compassion-focused therapy (CFT) for the reduction of the self-stigma of mental disorders: the COMPASSION for Psychiatric disorders, Autism and Self-Stigma (COMPASS) study protocol for a randomized controlled study. *Trials*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s13063-023-07393-y>
- Rodríguez-Rivas, M. E., Cangas, A. J., & Fuentes-Olavarría, D. (2021). Controlled Study of the Impact of a Virtual Program to Reduce Stigma Among University Students Toward People With Mental Disorders. *Frontiers in Psychiatry*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.632252>
- Roy, P., & Chowdhury, K. U. A. (2024). Exploring the stigma against people with mental illness in Bangladesh. *Global Mental Health*, 11. <https://doi.org/10.1017/gmh.2024.107>
- Shalaby, A. S., Ibrahim, R. A. L., Seleem, M. A., Sharfeldin, A. Y., ElWasify, M., Abdel-Raouf, S. Y., ElWasify, M., Mohammed, A. A., Shourb, E., Elrassas, H., & Hasan, H. (2025). Perceived stigma toward individuals with mental illness and their families: perspectives of patients' relatives in a multicentric Egyptian study. *Middle East Current Psychiatry*, 32(1). <https://doi.org/10.1186/s43045-025-00576-0>
- Shih, C. A., Huang, J. H., & Yang, M. H. (2022). Anti-stigma psychosocial intervention effects on reducing mental illness self-stigma and increasing self-esteem among patients with schizophrenia in Taiwan: A quasi-experiment. *Asian Journal of Psychiatry*, 73. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2022.103171>
- Subu, M. A., Wati, D. F., Netrida, N., Priscilla, V., Dias, J. M., Abraham, M. S., Slewa-Younan, S., & Al-Yateem, N. (2021). Types of stigma experienced by patients with mental illness and mental health nurses in Indonesia: a qualitative content analysis. *International Journal of Mental Health Systems*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s13033-021-00502-x>
- Thornicroft, G., Sunkel, C., Alikhon Aliev, A., Baker, S., Brohan, E., el Chammay, R., Davies, K., Demissie, M., Duncan, J., Fekadu, W., Gronholm, P. C., Guerrero, Z., Gurung, D., Habtamu, K., Hanlon, C., Heim, E., Henderson, C., Hijazi, Z., Hoffman, C., ... Winkler, P. (2022). The Lancet Commission on ending stigma and discrimination in mental health. *The Lancet*, 400(10361), 1438–1480. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01470-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01470-2)
- Tozoğlu, E. Ö., & Gürbüz, N. (2024). Internalized stigma level, family self-stigma, and family burden of patients receiving community mental health center services: a comparative, longitudinal study. *Frontiers in Psychiatry*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1469448>

- Wang, Y. Z., Meng, X. D., Zhang, T. M., Weng, X., Li, M., Luo, W., Huang, Y., Thornicroft, G., & Ran, M. S. (2023). Affiliate stigma and caregiving burden among family caregivers of persons with schizophrenia in rural China. *International Journal of Social Psychiatry*, 69(4), 1024–1032. <https://doi.org/10.1177/00207640231152206>
- Xie, Y., Shi, Z., Jie, Y., & Wang, Z. (2021). Stigma: The Illness Narrative of Mental Patients from the Perspective of Medical Humanities. *Chinese Medical Ethics*, 34(3), 390–395. <https://doi.org/10.1206/j.issn.1001-8565.2021.03.23>
- Zhang, Z. J., Lo, H. H. M., Ng, S. M., Mak, W. W. S., Wong, S. Y. S., Hung, K. S. Y., Lo, C. S. L., Wong, J. O. Y., Lui, S. S. Y., Lin, E., Siu, C. M. W., Yan, E. W. C., Chan, S. H. W., Yip, A., Poon, M. F., Wong, G. O. C., Mak, J. W. H., Tam, H. S. W., Tse, I. H. H., & Leung, B. F. H. (2023). The Effects of a Mindfulness-Based Family Psychoeducation Intervention for the Caregivers of Young Adults with First-Episode Psychosis: A Randomized Controlled Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph20021018>

Glosarium

C

CBT: adalah Cognitive Behavioral Therapy

CFT: Compassion-focused therapy

BAB 5

KESEHATAN MENTAL TENAGA KESEHATAN

A. Pendahuluan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Indonesia, 2023). Regulasi di Indonesia menyebutkan pengertian tenaga kesehatan berbeda dengan tenaga medis yang adalah dokter atau dokter gigi. Namun dalam tulisan ini, pengertian tenaga kesehatan mencakup dokter, perawat, bidan, psikolog, tenaga kesehatan masyarakat dan lainnya yang bekerja di sektor kesehatan memberikan layanan kesehatan pada masyarakat.

Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam upaya pelayanan kesehatan dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Mereka mempunyai risiko tinggi terpapar berbagai masalah kesehatan akibat tuntutan tinggi profesi antara lain melakukan kontak langsung dengan pasien. Tuntutan pekerjaan ini membuat tenaga kesehatan memerlukan kondisi fisik dan mental yang baik agar dapat bekerja secara optimal.

Ironi kenyataan menyebutkan ternyata tenaga kesehatan merupakan pekerja yang paling banyak mengalami masalah kesehatan mental dibandingkan dengan pekerja di berbagai sektor industri dan pekerjaan lain (Khanlari et al., 2025). Tenaga kesehatan terpapar berbagai stresor dalam pekerjaan mereka yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan emosional (Mohanty et al., 2019; Søvold et al., 2021). Kondisi kesehatan mental yang terganggu pada akhirnya menyebabkan penurunan kinerja tenaga kesehatan, yang tidak hanya merugikan individu tersebut tetapi juga membahayakan keselamatan pasien dan menurunkan efektivitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Dall'Ora et al., 2020).

B. Kesehatan Mental (Jiwa)

Kesehatan mental dipahami sebagai model dua dimensi yang mencakup kontinum patogenik dan salutogenik (Fisher, 2023; Mjøsund, 2021). Dalam paradigma patogenik, fokus utama terletak pada dikotomi antara ketiadaan gangguan dan penyakit mental yang serius. Namun, dalam dimensi salutogenik, perhatian dialihkan pada kemampuan fungsional dan resiliensi individu. Lebih lanjut, spektrum ini sering kali direpresentasikan sebagai kontinum antara kondisi

flourishing atau *thriving* (tumbuh berkembang secara optimal) dan *languishing* atau *surviving* (kondisi lemah, merasa kurang bermakna atau sekadar bertahan hidup) (Keyes, 2002; Keyes et al., 2008).

Fokus pada kesejahteraan (salutogenesis) ini memperkuat definisi dari *World Health Organization* (WHO) mengenai kesehatan mental sebagai status kesejahteraan yang mencakup kapasitas individu dalam menghadapi tantangan hidup, bekerja secara bermanfaat, serta berpartisipasi aktif dalam lingkungan (European Union, 2021; WHO, 2022b)

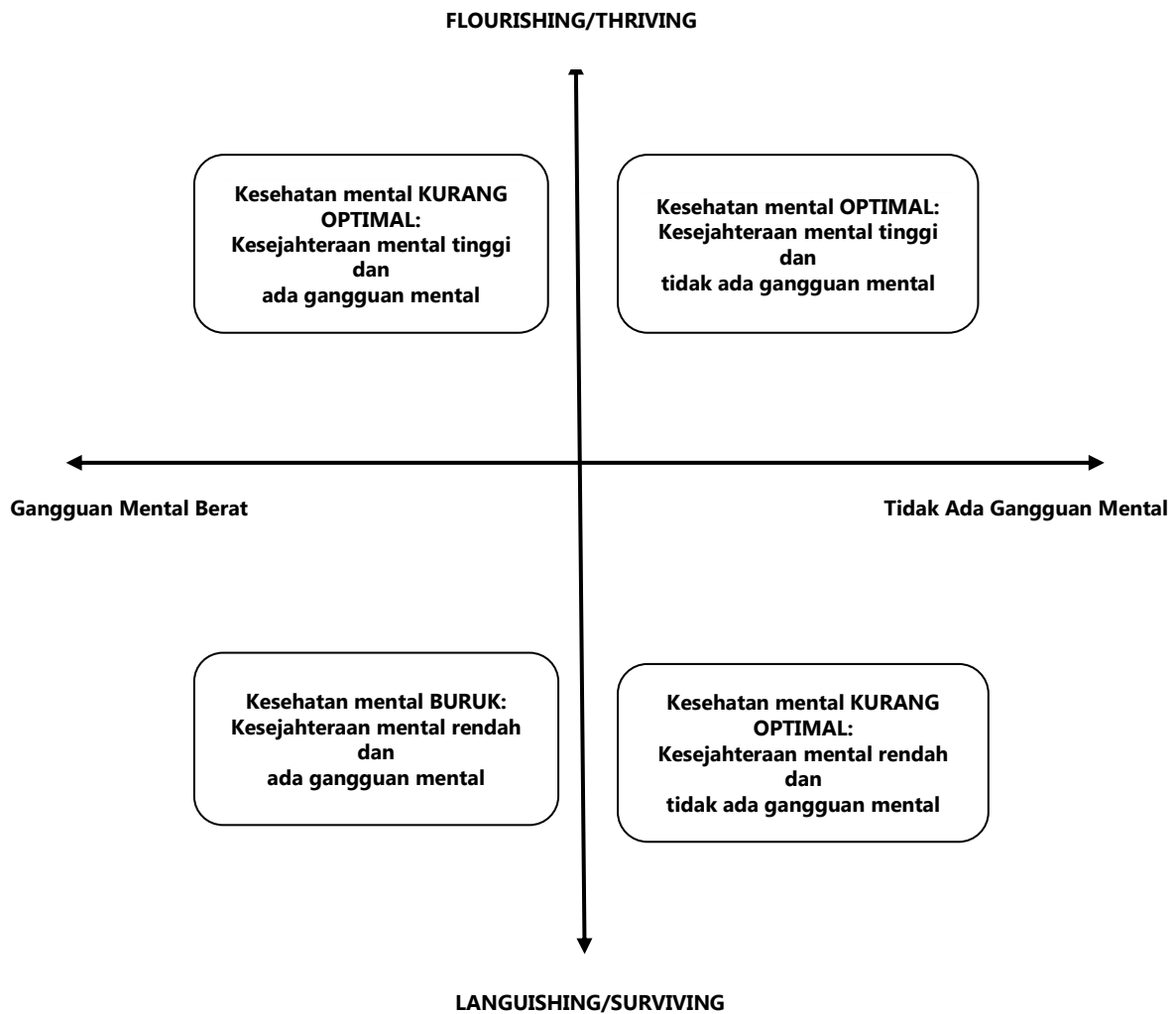
Gambar 1 menunjukkan model dual kontinum tersebut yang melihat kondisi kesehatan mental sebagai kontinum gangguan mental (patogenik) dan kontinum kesejahteraan mental (salutogenik) yang diadaptasi dari konsep WHO (WHO, 2022b).

1. Garis mendatar (horizontal) adalah kontinum gangguan mental, pada ujung sebelah kiri menggambarkan ada gangguan mental dan di ujung sebelah kanan tidak ada gangguan mental.
2. Garis tegak (vertikal) adalah kontinum kesejahteraan mental, pada bagian atas menggambarkan kondisi kesehatan mental yang optimal (*flourishing*) dan pada bagian bawah kondisi kesehatan mental yang lemah (*languishing*).

Kondisi dual kontinum pada diri seseorang bersifat dinamis, artinya dapat berubah dari waktu ke waktu, dipengaruhi berbagai faktor determinan yang terjadi pada diri seseorang. Berdasarkan Gambar 1, ada beberapa kondisi kesehatan mental yang dapat terjadi yaitu:

1. Kesehatan Mental Optimal

Kesehatan mental yang optimal dikonseptualisasikan pada kondisi ketika individu memiliki tingkat kesejahteraan mental yang tinggi di saat yang bersamaan dengan ketiadaan gangguan mental yang terdiagnosis (lihat kuadran kanan atas pada Gambar 1). Kondisi ini, disebut sebagai fase *flourishing* yang sesungguhnya (Keyes, 2002), mencerminkan keadaan di mana individu tidak hanya bebas dari gejala patologis, tetapi juga memiliki energi mental yang cukup untuk menjalankan fungsi sosial, menunjukkan resiliensi terhadap tekanan, serta menemukan makna dalam tanggung jawab profesionalnya.



Gambar 5.1
Dua Dimensi Kesehatan Mental (diadaptasi dari WHO, 2022)

Berikut adalah dua contoh kondisi kesehatan mental yang optimal pada tenaga kesehatan:

- a. Seorang dokter spesialis yang secara rutin menangani prosedur medis berisiko tinggi tetap mampu menjaga kejernihan kognitif dan ketenangan saat mengambil keputusan klinis yang kritis karena mempunyai kemampuan regulasi emosi yang baik. Secara medis, ia tidak menunjukkan gejala ansietas atau gangguan tidur yang mengganggu fungsi harian. Di saat yang sama, ia memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi yang ditandai dengan perasaan kompeten, mampu menjalin komunikasi empati yang tulus dengan pasien tanpa merasa terbebani secara emosional, serta memiliki keseimbangan yang sehat antara tuntutan profesi dan kehidupan personal.

- b. Seorang tenaga kesehatan masyarakat yang bertugas mengelola program kesehatan di wilayah dengan keterbatasan sumber daya tetap mampu bekerja secara produktif dan kreatif tanpa mengalami kelelahan emosional atau tanda-tanda depresi. Ia memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi karena merasakan dampak nyata dari upaya pemberdayaan yang dilakukannya terhadap komunitas. Meskipun menghadapi tantangan birokrasi yang kompleks, ia memandang hambatan tersebut sebagai bagian dari dinamika profesional yang dapat dikelola, didukung oleh hubungan sosial yang positif dengan rekan sejawat dan masyarakat lokal.

2. Kesehatan Mental Kurang Optimal

Kondisi kesehatan mental kurang optimal muncul saat munculnya gejala klinis atau rendahnya tingkat kesejahteraan mental mulai mengintervensi kinerja profesional dan fungsi personal sehari-hari (kuadran kanan bawah atau kiri atas pada Gambar 1).

Kondisi kesehatan mental kurang optimal mencerminkan sebuah fase transisi di mana ambang batas resiliensi individu mulai terlampaui oleh tekanan lingkungan. Kondisi ini tidak hanya ditandai oleh kemunculan gejala klinis, tetapi juga adanya penurunan kapasitas internal individu untuk merasakan kesejahteraan. Selanjutnya, kondisi ini akan mengganggu efektivitas peran dalam lingkungan kerja serta kualitas hidup sehari-hari.

Berikut ini adalah dua contoh kondisi yang mencerminkan fenomena tersebut dalam konteks tenaga kesehatan,:

- a. Seorang dokter mengalami gejala ansietas terus-menerus akibat beban tanggung jawab klinis yang berat, mungkin belum memenuhi kriteria diagnosis gangguan kecemasan secara penuh. Namun, manifestasi kecemasan tersebut mulai mengintervensi kinerja profesionalnya dalam bentuk kesulitan berkonsentrasi atau keraguan yang berlebihan saat mengambil keputusan diagnostik yang krusial. Secara bersamaan, kondisi ini memengaruhi fungsi personalnya, seperti ketidakmampuan untuk melepaskan beban pikiran pekerjaan saat berada di rumah, yang mengakibatkan gangguan tidur kronis dan iritabilitas dalam interaksi keluarga.
- b. Seorang perawat pada kondisi kecewa berat karena merasa karir dan pendapatannya tidak berkembang terlihat menjadi kurang bersemangat melakukan pekerjaannya. Kondisi kesejahteraan mental perawat tersebut dapat dikatakan mengalami *languishing* (kesejahteraan mental rendah) yang mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda depresi klinis yang nyata, namun ia merasa kehilangan makna dan semangat dalam menjalankan tugasnya. Dalam kinerja profesional, hal ini bermanifestasi pada sikap yang dingin dan

menurunnya empati terhadap penderitaan pasien yang berisiko menurunkan kualitas asuhan keperawatan. Di ranah fungsi personal, kondisi ini sering kali dapat diikuti dengan penarikan diri dari aktivitas sosial dan hilangnya minat pada hobi atau kegiatan yang sebelumnya memberikan kepuasan emosional.

3. Kesehatan Mental Buruk

Kondisi kesehatan mental yang buruk ketika seseorang mengalami gangguan mental sekaligus memiliki tingkat kesejahteraan mental yang rendah. Fenomena ini menciptakan hambatan ganda bagi tenaga kesehatan; kehadiran gangguan mental (seperti depresi klinis atau gangguan ansietas) yang disertai dengan rendahnya kemampuan fungsional mengakibatkan individu tersebut sulit untuk mencapai kondisi *thriving* dalam pekerjaannya. Penelitian pada pekerja kesehatan di Turki menemukan kondisi *languishing* berkorelasi dengan rendahnya kinerja dan kepuasan pada pekerjaan (Aydın & Demir, 2025). Tanpa adanya kesejahteraan mental yang memadai untuk menyangga beban penyakit tersebut, tenaga kesehatan akan kehilangan kapasitas untuk menjalankan peran profesionalnya, yang pada akhirnya berdampak pada degradasi kualitas layanan kesehatan.

Perlu dipahami bahwa kondisi kesehatan mental seseorang memiliki sifat dinamis. Setiap orang, pada satu waktu dalam hidupnya, dapat saja merasakan kondisi *languishing* namun minim gejala, atau bahkan tidak ada gejala gangguan mental namun merasa hampa. Pada kenyataannya, banyak orang dengan gangguan mental dapat tetap bekerja dan berkarya dan banyak juga orang yang tidak memiliki gangguan mental namun berjuang agar tetap sehat mental karena sedang mengalami masalah kehidupan.

C. Determinan Kesehatan Mental

Kesehatan mental ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara berbagai determinan yaitu faktor risiko dan faktor protektif pada tingkat individu, keluarga dan komunitas serta struktural. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan bervariasi dari waktu ke waktu serta dialami secara berbeda dari orang ke orang. Rincian berbagai determinan kesehatan mental secara umum digambarkan pada Tabel 1.

1. Determinan pada Tingkat Individu

Kerentanan seseorang terhadap masalah kejiwaan dipengaruhi oleh faktor biologis dan psikologis.

- a. Faktor biologis, antara lain genetika, penggunaan NAPZA, faktor penyulit saat kelahiran dan menderita penyakit kronis. Kesehatan otak sangat penting karena banyak mempengaruhi faktor risiko atau protektif.

- b. Faktor psikologis, antara lain kognitif (misal: konsep diri, cara problem solving) dan interpersonal (misal: kemampuan regulasi emosi, ketrampilan hidup/ketrampilan sosial).

Tabel 5.1
Determinan Kesehatan Mental

Faktor protektif (meningkatkan kesehatan mental)	Faktor risiko (mengancam kesehatan mental)
Individu	
Biologis: • Faktor genetik • Kesehatan fisik yang baik • Aktivitas fisik Psikologis: • Ketrampilan sosial dan emosional • Rasa keberhargaan dan penguasaan diri	Biologis: • Faktor genetik • Penggunaan NAPZA • Nutrisi yang tidak sehat • Penyakit kronis • Komplikasi saat kelahiran • Kekurangan vitamin D Psikologis: • Tingkat pendidikan rendah • Ketidakpuasan pada tubuh • Regulasi emosi, penguasaan diri
Keluarga dan Komunitas	
• Nutrisi kehamilan yang baik • Pengasuhan yang baik • Komunikasi dalam keluarga • Keamanan dan keselamatan fisik • Jejaring sosial, dukungan sosial yang kuat	• Kekerasan dan pelecehan seksual • Pola asuh keras • Penelantaran • Bullying • Kehilangan orang yang dicintai • Beban kerja tinggi • Jejaring sosial, dukungan sosial yang lemah
Struktural	
• Keamanan ekonomi/penghasilan • Infrastruktur yang berkualitas baik • Pemerataan akses pada pelayanan • Lingkungan alami yang berkualitas • Integrasi dan keadilan sosial • Perlindungan sosial dan penghasilan • Kondisi sosial dan gender yang ekual	• Krisis iklim, polusi dan penurunan kualitas lingkungan • Infrastruktur yang buruk • Akses pada pelayanan yang buruk • Ketidakadilan, diskriminasi sosial, pengasingan • Ketidaksetaraan kondisi sosial, ekonomi dan gender • Konflik dan pemindahan paksa • Kedaruratan kesehatan

Diadaptasi dari WHO (2022)

2. Determinan pada Tingkat Keluarga/Komunitas

Keluarga dan komunitas merupakan lingkungan terdekat seseorang, tempat seseorang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai aktivitas bersama antara lain kehidupan keluarga, bersekolah atau bekerja. Keluarga dan komunitas dapat menjadi faktor protektif atau faktor risiko pada kesehatan mental.

Dalam keluarga, perilaku dan sikap orang tua, termasuk kondisi kejiwaannya, sangat berpengaruh pada anak-anaknya sejak masa bayi hingga remaja. Pola asuh yang keras dan hukuman fisik diketahui merusak kesehatan mental anak dan dapat menimbulkan masalah perilaku. Sebaliknya pola asuh yang moderat memungkinkan tumbuh kembang anak secara optimal.

Di tempat kerja, situasi sosial yang saling mendukung, berempati, rasa keadilan dan tidak ada ancaman kekerasan akan mendukung kesehatan mental anggota komunitas tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada atau kurang rasa empati dan dukungan sosial, atau bahkan terjadinya kekerasan, maka tempat kerja menjadi faktor risiko terjadinya masalah kesehatan mental.

3. Determinan Struktural

Faktor struktural berkaitan dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, seperti infrastruktur, ketimpangan, stabilitas sosial, dan kualitas lingkungan. Akses pada layanan dan ketersediaan kebutuhan makanan, air, tempat tinggal yang aman sangat penting mempengaruhi kesehatan mental. Kebijakan sosial dan ekonomi pun dapat berdampak pada kondisi kesehatan mental masyarakat melalui terjadinya stress, depresi dan kecemasan.

Faktor-faktor individu, keluarga/komunitas dan struktural secara bersama-sama menentukan kesehatan mental kita. Faktor-faktor penentu ini berinteraksi satu sama lain secara dinamis dan mempengaruhi kemampuan seseorang mengatasi tekanan kehidupan (stress) yang dialaminya yang berkontribusi pada kondisi kesehatan mental. Jadi, mental yang sehat tidak hanya terbentuk karena seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan kondisi fisik yang sehat, namun memerlukan rasa aman karena tercukupi kebutuhan pribadi dan sosialnya.

Berikut ini adalah beberapa contoh interaksi antar faktor determinan:

- a. Seorang anak yang berasal dari keluarga harmonis, mendapatkan pengasuhan yang sehat, mempunyai kesehatan yang baik, ketika di sekolah mendapat kekerasan dari teman-temannya berupa bullying; atau malah dari gurunya berupa kata-kata dan perilaku kasar, maka kondisi kejiwaan si anak dapat terpengaruh.

- b. Seorang pekerja menyadari bahwa pekerjaannya menguras tenaga dan pikiran sehingga dirinya dapat mengalami stress. Pekerja tersebut melakukan upaya mengelola stress sehingga tidak sampai berdampak pada kesehatan mental.
- c. Suatu perguruan tinggi membuat kebijakan setiap mahasiswa baru harus mengikuti kuliah tentang *softskill* manajemen waktu dan cara mengelola stress karena akademik dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengatasi stress dan terhindar dari munculnya gejala masalah kejiwaan.
- d. Pemerintah menyediakan layanan transportasi umum murah dan nyaman, agar masyarakat tidak resah dengan biaya transportasi yang terus meningkat.
- e. Pemerintah membuka balai pelatihan kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan.
- f. Keluarga memberikan dukungan psikologis dan finansial untuk berobat pada seseorang yang didiagnosis bipolar.

D. Bahaya Psikososial di Tempat Kerja

Dalam konteks kesehatan mental tenaga kesehatan, maka perlu memperhatikan kondisi tempat kerja yang berisiko adanya *hazard* (bahaya) psikososial yang dapat mempengaruhi status kesehatan pekerja, yaitu (Stavroula, Leka; Houdmont, 2010):

1. Tuntutan kerja (*job demand*)
2. Waktu kerja yang berlebihan
3. Kurangnya kendali pekerjaan (*job control*)
4. Kurangnya dukungan sosial (*support*) di tempat kerja.
5. Konflik pekerjaan dan kehidupan keluarga
6. Perubahan peran yang memicu ketidakpastian (*job insecurity*)
7. Perilaku anti-sosial di tempat kerja.

Bahaya psikososial berupa tuntutan kerja, termasuk waktu kerja berlebihan, kurangnya kendali pekerjaan dan kurangnya dukungan sosial di tempat kerja akan dibahas dengan pendekatan Model *Job Demand-Control-Support* yang dikemukakan oleh Karasek dan Johnson (de Araújo et al., 2016; Stavroula, Leka; Houdmont, 2010).

Pembahasan tentang bahaya psikososial berikut sudah dikaitkan dengan konteks yang dialami oleh tenaga kesehatan.

1. Tuntutan Kerja, Kendali Pekerjaan dan Dukungan Sosial

Salah satu pilar utama untuk membedah fenomena ini adalah model *Job Demand-Control* (JDC) yang dipopulerkan oleh Karasek. Model ini menjadi

instrumen penting dalam literatur kesehatan global karena kemampuannya memetakan hubungan antara stresor kerja dengan kondisi kesehatan pekerja.

Pada dasarnya, JDC berfokus pada dua dimensi utama yang menentukan kualitas hidup pekerja (Stavroula, Leka; Houdmont, 2010):

a. Tuntutan kerja (*job demand*).

Tuntutan kerja merupakan tekanan fisik mental dari beban tugas yang dihadapi tenaga kerja. Tuntutan kerja mencerminkan totalitas pengerahan sumber daya fisik, kognitif, dan psikologis yang dibutuhkan oleh seorang tenaga kesehatan untuk menyelesaikan tanggung jawab profesionalnya. Aspek ini bersifat dualistik; tuntutan yang terlalu besar melampaui kapasitas individu dapat memicu kelelahan emosional (*burnout*), sementara tuntutan yang terlalu rendah berisiko menurunkan motivasi serta efikasi diri.

b. Kendali pekerjaan (*job control*).

Kontrol pekerjaan merujuk pada tingkat otonomi dan pengaruh yang dimiliki pekerja terhadap pelaksanaan tugas mereka. Dimensi ini mencakup kemampuan individu untuk mengatur aspek-aspek krusial seperti jumlah keseluruhan jam kerja, penentuan waktu memulai dan mengakhiri pekerjaan, metode penyelesaian tugas, hingga pengaturan urutan prioritas kerja.

Menurut Karasek dalam teori *Job Demand-Control* (JDC), beban kerja yang tinggi tidak serta-merta bertransformasi menjadi stresor negatif jika diimbangi dengan kontrol pekerjaan yang tinggi pula. Kondisi ini diklasifikasikan sebagai *active job*, di mana tenaga kesehatan merasa tertantang untuk berkembang alih-alih merasa tertekan.

Berdasarkan Model JDC, risiko kesehatan fisik maupun psikologis muncul ketika terjadi ketimpangan, yakni saat tuntutan kerja melampaui kendali pekerjaan yang dimiliki pekerja. Kombinasi dari kedua dimensi ini menghasilkan empat konfigurasi kerja (antara lain *high strain* atau *active job*) yang masing-masing membawa dampak kesehatan dengan intensitas yang berbeda-beda (leka).

c. Dukungan sosial di tempat kerja.

Johnson melengkapi kerangka berpikir Karasek dengan mengintegrasikan dimensi ketiga. Penambahan ini didasari oleh realitas bahwa manusia memiliki kebutuhan fundamental untuk berinteraksi dan didukung (de Araújo et al., 2016; Stavroula, Leka; Houdmont, 2010).

Dukungan sosial di tempat kerja dapat didefinisikan sebagai sumber daya psikososial yang berperan penting dalam mengurangi atau mencegah munculnya masalah kesehatan fisik dan psikologis bagi pekerja yang terpapar stres. Dalam konteks organisasi kesehatan, dukungan ini sering kali diukur

melalui *Perceived Organizational Support* (POS), yaitu persepsi tenaga kesehatan mengenai sejauh mana instansi tempat mereka bekerja mengapresiasi kontribusi mereka dan memedulikan kesejahteraan mereka (Bagheri Hossein Abadi et al., 2021; Batubara et al., 2020).

Pembahasan selanjutnya adalah tentang dampak tekanan kerja, kurangnya kendali pekerjaan dan kurangnya dukungan sosial tempat kerja pada kesehatan mental tenaga kesehatan dan implikasi pada kinerja dan kualitas pelayanan.

a. Dampak pada kesehatan mental tenaga kesehatan

Riset di berbagai negara menunjukkan masalah kesehatan mental yang bervariasi dan signifikan di kalangan tenaga kesehatan.

- 1) Gangguan mental umum (*common mental disorder*-CMD) dialami tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer sebanyak 1 dari 5 pekerja. Gangguan ini bukan suatu diagnosis gangguan mental namun merupakan kumpulan gejala yang dirasakan signifikan dalam 30 hari terakhir dan diukur dengan *Self-Report Questionnaire-20* (SRQ-20) (de Araújo et al., 2016).
- 2) Stress sebagai gangguan psikologis yang timbul dari tekanan emosional dan fisik yang disebabkan oleh upaya individu untuk menanggapi tekanan internal dan eksternal (Batubara et al., 2020; Zakaria et al., 2025).
- 3) *Burnout* adalah jenis kelelahan psikologis, emosional, dan fisik yang terjadi akibat stres kerja yang kronis atau berkepanjangan (Juanamasta et al., 2024). Kondisi ini ditandai dengan perasaan lelah yang luar biasa, hilangnya energi, serta munculnya perasaan frustrasi yang tidak kunjung hilang terkait dengan pekerjaan erwin. *Burnout* memiliki efek signifikan menurunkan tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan (Erwin et al., 2025; Yousef et al., 2024).
- 4) Depersonalisasi adalah salah satu dimensi atau gejala inti dari sindrom *burnout* yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlakukan pasien bukan sebagai manusia, melainkan sebagai objek atau angka (Juanamasta et al., 2024). Kondisi ini melibatkan munculnya sikap yang sinis, dingin, atau tidak peduli terhadap orang-orang yang seharusnya dilayani (pasien dan keluarga pasien) sebagai bentuk perlindungan diri dari tekanan emosional yang berlebihan. Perawat menunjukkan tingkat depersonalisasi yang cukup tinggi (Rostamabadi et al., 2019).
- 5) Depresi merupakan masalah kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan hampa kronis, kesedihan, kehilangan minat pada aktivitas yang menyenangkan, rasa bersalah, rendah diri, gangguan tidur, dan kesulitan

berkonsentrasi (Zakaria et al., 2025). Pada saat pandemi COVID-19, terjadi peningkatan depresi pada tenaga kesehatan seiring dengan meningkatnya tekanan kerja (Indrawati et al., 2021; Sulidah et al., 2024).

6) Kecemasan didefinisikan sebagai kondisi psikologis yang muncul bersamaan dengan stres dan depresi, di mana individu merasakan kekhawatiran yang signifikan secara klinis (Zakaria et al., 2025).

7) Kesepian (*loneliness*) merupakan perasaan terisolasi secara sosial. Masalah mental ini banyak terjadi pada tenaga kesehatan saat pandemi karena kebijakan pembatasan dan stigmatisasi terkait risiko penularan virus (Yousef et al., 2024).

b. Dampak pada kinerja dan kualitas pelayanan

1) Penurunan dedikasi dan motivasi kerja

Beban kerja yang berlebih dan dukungan organisasi yang rendah menyebabkan menurunnya semangat kerja serta keterlibatan emosional dalam menjalankan tugas (Batubara et al., 2020; Erwin et al., 2025; Jalilian et al., 2019).

2) Penurunan produktivitas dan kualitas layanan

Kelelahan yang berkelanjutan, stres dan kecemasan yang tidak tertangani menurunkan status kesehatan perawat secara keseluruhan, yang kemudian menghambat efisiensi kerja dan menurunkan produktivitas kerja di fasilitas kesehatan (Batubara et al., 2020; Erwin et al., 2025; Jalilian et al., 2019; Zakaria et al., 2025).

3) Kepuasan pasien rendah

Layanan kesehatan dengan kualitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasien secara langsung menurunkan angka kepuasan pasien terhadap rumah sakit (Batubara et al., 2020).

4) Terjadi medical errors

Kelelahan kronis pada perawat diidentifikasi sebagai faktor risiko utama terjadinya kesalahan manusia (*human errors*) dalam tindakan medis yang dapat membahayakan pasien (Jalilian et al., 2019).

5) Risiko fatal pada tenaga kesehatan

Laporan mencatat kasus ekstrem di mana seorang dokter meninggal dunia akibat kelelahan setelah melakukan 10 operasi dalam satu hari di Sulawesi Barat (Erwin et al., 2025).

2. Konflik antara Pekerjaan dan Kehidupan Keluarga (*Work-Family Conflict*)

Konflik antara pekerjaan dan keluarga didefinisikan sebagai bentuk konflik antar peran di mana tekanan dari domain pekerjaan dan keluarga saling bertentangan dalam beberapa hal (Kayanti & Alfikalia, 2023). Fenomena ini

bersifat dua arah (*bidirectional*), mencakup gangguan pekerjaan terhadap peran keluarga (*work interfering with family*) serta sebaliknya ketika tuntutan keluarga mengintervensi tanggung jawab profesional (*family interfering with work*) (Chen et al., 2018).

Menyeimbangkan tanggung jawab profesional di sektor kesehatan dengan peran dalam keluarga merupakan tantangan besar. Konflik kerja-keluarga muncul ketika tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab domestik saling berbenturan, sehingga pemenuhan peran di satu sisi menghambat efektivitas di sisi lainnya.

Menurut Greenhaus dan Beutell (1985), konflik kerja-keluarga terbagi dalam tiga dimensi utama (Kayanti & Alfikalia, 2023; Priastuty & Mulyana, 2021; Rahmawati & Susanti, 2026):

- a. Konflik berbasis waktu (*time-based conflict*): waktu yang dibutuhkan dalam melakukan salah satu tuntutan keluarga atau pekerjaan. Misalnya jadwal kerja *shift* atau panggilan darurat mendadak yang membuat kurangnya waktu untuk keluarga
- b. Konflik berbasis ketegangan (*strain-based conflict*): adanya tekanan dari salah satu peran yang berpengaruh pada peran lainnya. Misalnya ketegangan dari pekerjaan yang terbawa ke rumah.
- c. Konflik berbasis perilaku (*behavior-based conflict*): perilaku yang mempengaruhi satu peran ke peran lainnya, antara lain ketidaksesuaian perilaku profesional dengan peran di rumah.

Selain itu, tenaga kesehatan perempuan dapat mengalami dinamika konflik kerja-keluarga yang unik. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tenaga kesehatan perempuan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak lebih rentan mengalami konflik kerja-keluarga (Fitriana et al., 2022; Jahan Priyanka et al., 2024) karena beban ganda berupa tugas di tempat kerja dan tugas mengurus keluarga. Ekspektasi sosial mengharuskan tugas mengurus keluarga adalah tanggung jawab perempuan.

- a. Beban ganda: Di Indonesia, tenaga kesehatan perempuan sering kali harus menyelesaikan tugas rumah tangga (memasak, mengurus anak) sebelum berangkat kerja dan tetap bertanggung jawab atas pengasuhan anak saat pulang, yang memicu kelelahan fisik dan psikis yang luar biasa (Fitriana et al., 2022; Priastuty & Mulyana, 2021).
- b. Ketidakseimbangan peran: Konflik cenderung lebih berat jika pembagian peran dengan pasangan tidak seimbang, misalnya ketika suami kurang terlibat

dalam pengasuhan anak atau urusan domestik (Fitriana et al., 2022; Jahan Priyanka et al., 2024).

Pemicu konflik kerja-keluarga (*work-family conflict*) atau beban ganda pada tenaga kesehatan dapat dikategorikan menjadi faktor pekerjaan, faktor keluarga, dan faktor situasional (Fitriana et al., 2022; Jahan Priyanka et al., 2024; Kayanti & Alfikalia, 2023; Priastuty & Mulyana, 2021; Rahmawati & Susanti, 2026; Zhang et al., 2023).

a. Faktor pekerjaan (domain pekerjaan)

- 1) Beban dan durasi kerja: tekanan tugas yang berat, jam kerja yang panjang, serta adanya lembur dan jadwal yang tidak fleksibel secara langsung mengurangi waktu dan energi untuk keluarga.
- 2) Instabilitas jadwal: penerapan sistem kerja bergilir (*shift*) dan panggilan darurat medis yang mendadak memaksa tenaga kesehatan meninggalkan tanggung jawab domestik secara tiba-tiba.
- 3) Tekanan psikososial: ketegangan emosional saat melayani pasien, ambiguitas peran, serta rendahnya kendali dalam mengambil keputusan di tempat kerja memicu kelelahan mental yang terbawa ke rumah.
- 4) Lingkungan organisasi: kurangnya dukungan dari atasan serta lingkungan kerja yang tidak suportif terhadap kebutuhan personal tenaga kesehatan memperburuk persepsi konflik peran ganda.

b. Faktor keluarga (domain rumah tangga)

- 1) Tanggung jawab pengasuhan anak: adanya anak, terutama yang masih kecil atau usia sekolah yang memerlukan pendampingan belajar dapat meningkatkan beban domestik secara signifikan.
- 2) Kurangnya dukungan pasangan: pembagian peran yang tidak seimbang, di mana suami tidak terlibat aktif dalam urusan rumah tangga atau pengasuhan, menjadi pemicu utama beban ganda pada tenaga kesehatan perempuan.
- 3) Kewajiban mengurus rumah tangga: tugas rutin seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah yang harus diselesaikan sebelum atau sesudah bekerja menguras energi fisik tenaga kesehatan.
- 4) Interpersonal conflict di rumah: konflik dengan anggota keluarga atau pasangan mengenai prioritas waktu dapat memicu stres tambahan.

c. Faktor situasional dan individual

- 1) Sumpah profesi dan tanggung jawab moral: dorongan untuk mengutamakan pasien di atas kepentingan pribadi sering kali memaksa tenaga kesehatan untuk mengorbankan waktu keluarga.

- 2) Ketidakmampuan mengatur waktu: kesulitan dalam melakukan manajemen waktu antara tuntutan kantor dan rumah tangga memperbesar intensitas konflik yang dirasakan.
- 3) Perubahan struktur kehidupan: situasi luar biasa seperti pandemi yang mengubah protokol kerja dan sistem pendidikan anak menjadi beban tambahan yang harus diadaptasi secara mendadak.

Dinamika konflik kerja-keluarga dapat berdampak pada kesehatan mental tenaga kesehatan bahkan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

a. Dampak pada kesehatan mental tenaga kesehatan

Paparan konflik kerja-keluarga yang kronis memberikan tekanan psikologis yang berat bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang memicu masalah kesehatan mental, antara lain:

- 1) *Burnout*: konflik kerja-keluarga berkontribusi signifikan terhadap munculnya *burnout syndrome*. Gejala yang sering muncul meliputi kelelahan emosional yang ekstrem, sinisme terhadap pekerjaan dan perasaan tidak kompeten dalam menjalankan profesi maupun peran di rumah (Kayanti & Alfikalia, 2023; Zhang et al., 2023).
- 2) Gejala depresi dan kecemasan: konflik yang tidak teratasi berkaitan erat dengan distres psikologi yang memicu munculnya gejala depresi dan kecemasan. Ketidakpastian dalam mempertahankan keseimbangan peran sering kali memicu perasaan bersalah, cemas, dan insomnia. Tenaga kesehatan yang mengalami konflik tinggi cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk, yang pada akhirnya memperparah kondisi kesehatan mental mereka (Fitriana et al., 2022; Priastuty & Mulyana, 2021; Zhang et al., 2023).

b. Dampak pada kinerja dan kualitas pelayanan

Konflik kerja-keluarga yang memicu masalah kesehatan mental pada tenaga kesehatan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap produktivitas kerja dan kualitas pelayanan pada pasien. Beberapa penelitian mencatat:

- 1) Penurunan produktivitas: stres akibat konflik peran ganda menyebabkan tenaga kesehatan kehilangan fokus dan konsentrasi, yang secara langsung menurunkan produktivitas dan kualitas pelayanan (Fitriana et al., 2022).
- 2) Risiko kesalahan medis: *burnout* dan kelelahan emosional memicu hilangnya empati serta penurunan fungsi kognitif. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan dalam tindakan atau prosedur medis yang membahayakan pasien (Kayanti & Alfikalia, 2023).

- 3) Gangguan alur pelayanan: beban domestik tenaga kesehatan perempuan sering memicu keterlambatan atau ketidakhadiran mendadak, yang mengganggu koordinasi tim medis dalam menangani kasus kritis (Fitriana et al., 2022).
- 4) Ketidakstabilan staf: tingginya konflik meningkatkan intensi tenaga kesehatan untuk keluar dari pekerjaan (*turnover*), yang berakibat pada kekurangan tenaga terampil dan peningkatan beban kerja bagi staf yang tersisa (Chen et al., 2018; Zhang et al., 2023).

3. Ketidakpastian Kerja (*Job Insecurity*)

Dalam konteks kesehatan pekerja, *job insecurity* didefinisikan sebagai persepsi subjektif individu mengenai ketidakpastian atau ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaannya di masa depan (Danti et al., 2026; Guruh et al., 2025; Li et al., 2026). Dapat dikatakan *job insecurity* lebih bersifat persepsi subjektif daripada fakta objektif kehilangan pekerjaan.

Fenomena ini menjadi *hazard* psikososial bagi tenaga kesehatan (dokter, perawat, dan tenaga pendukung lainnya) yang bekerja dengan status non-permanen atau kontrak (Alamsyah & Rachmawati, 2023; Li et al., 2026). Mekanisme *job insecurity* sebagai stresor kerja dapat diuraikan bahwa *job insecurity* menciptakan tekanan psikologis yang kuat karena adanya rasa ketidakberdayaan individu untuk mempertahankan kesinambungan pekerjaan yang diinginkan. Hal ini dapat dipicu oleh kelangsungan status kepegawaian yang tidak pasti akibat sistem kontrak (Alamsyah & Rachmawati, 2023; Guruh et al., 2025) dan kekhawatiran finansial berupa jumlah penghasilan yang dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, juga kecemasan jika kontrak tidak diperpanjang (Sultana et al., 2022).

a. Dampak pada kesehatan mental tenaga kesehatan

Paparan terhadap *job insecurity* secara terus-menerus berkontribusi langsung pada penurunan kesejahteraan psikologis (*subjective well-being*) para tenaga kesehatan. Beberapa dampak mental yang teridentifikasi antara lain:

1) Peningkatan stres kerja, depresi dan kecemasan

Tenaga kesehatan yang mengalami ketidakpastian kerja memiliki risiko hampir tiga kali lipat lebih tinggi untuk mengalami depresi, kecemasan dan stres dibandingkan mereka yang merasa pekerjaannya aman (Danti et al., 2026; Li et al., 2026; Sultana et al., 2022)

2) Kelelahan emosional (*burnout*)

Job insecurity sering kali berjalan beriringan dengan kelelahan emosional di mana tenaga kesehatan kehilangan energi psikologis dan empati

terhadap pasien akibat tekanan beban kerja dan ketidakpastian posisi mereka (Alamsyah & Rachmawati, 2023; Guruh et al., 2025).

b. Dampak pada kinerja dan kualitas pelayanan

Kesehatan mental yang terganggu akibat *job insecurity* tidak hanya merugikan individu tenaga kesehatan, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan:

1) Penurunan performa kerja

Tenaga kesehatan yang merasa tidak aman secara posisi cenderung memiliki motivasi yang rendah, yang berdampak pada penurunan *job performance* (Alamsyah & Rachmawati, 2023; Guruh et al., 2025).

2) Risiko kesalahan medis

Kelelahan emosional dan hilangnya fokus tenaga kesehatan akibat stres dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam tindakan medis, yang membahayakan keselamatan pasien (Guruh et al., 2025).

3) Intensi berpindah (*turnover*)

Tingginya rasa ketidakamanan kerja mendorong tenaga kesehatan mencari peluang di tempat lain atau bahkan bermigrasi ke luar negeri demi stabilitas karier yang lebih baik (Li et al., 2026).

4) Faktor organisasi yang memperberat

Persepsi ketidakpastian ini sering kali diperburuk oleh ketidakpuasan terhadap gaji, lingkungan kerja yang tidak kondusif, serta kurangnya dukungan organisasi (Erwin et al., 2025).

4. Kekerasan di Tempat Kerja

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan di tempat kerja merupakan segala bentuk insiden yang melibatkan pelecehan, ancaman, atau serangan terhadap staf dalam lingkup pekerjaan mereka, termasuk saat melakukan perjalanan berangkat maupun pulang kerja. Tindakan ini dinilai sebagai tantangan serius karena mengancam keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan para pekerja. Cakupan kekerasan ini sangat luas, mulai dari bahaya fisik hingga gangguan psikologis yang meliputi kekerasan verbal, perundungan (*bullying*), serta pelecehan seksual.

Pekerja yang mengalami kekerasan di tempat kerja dapat mengalami depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), kelelahan, masalah tidur, peningkatan penggunaan antidepresan, serta penurunan kepuasan kerja dan kualitas hidup (WHO, 2022a, 2022b).

Tenaga kesehatan secara global memiliki risiko terpapar 20% lebih tinggi dibandingkan pekerja di sektor lainnya menurut laporan *Joint Commission* tahun 2018 (Rahmatika & Nadjib, 2019). Di sebuah rumah sakit publik di Kuala Lumpur,

sebanyak 71,3% responden tenaga kesehatan menyatakan mengalami kekerasan ketika sedang bekerja dengan angka kejadian lebih tinggi pada perawat (73,2%) dibandingkan dokter (69,2%) (Zainal et al., 2018). Di Indonesia, prevalensi kekerasan pada tenaga kesehatan di Aceh tercatat mencapai 64,4% (Putra et al., 2024), sementara di Yogyakarta ditemukan 13,6% dengan perawat di Instalasi Gawat Darurat sebagai kelompok paling rentan (Pidada & Wahab, 2024). Kekerasan verbal merupakan jenis yang paling umum dilaporkan, yakni mencapai 70,6%, bentuk lainnya mencakup perundungan/bullying (29,4%), kekerasan fisik (11,0%), dan pelecehan seksual (6,6%) ((Pidada & Wahab, 2024; Putra et al., 2024; Zainal et al., 2018)

Tinjauan sistematis dari berbagai negara menyebutkan kekerasan pada tenaga kesehatan lebih banyak dilakukan oleh pasien atau kerabat pasien (Rahmatika & Nadjib, 2019). Sedangkan penelitian di Aceh, Yogya dan Malaysia menyebutkan pelaku utama kekerasan adalah keluarga atau kerabat pasien (Pidada & Wahab, 2024; Putra et al., 2024; Zainal et al., 2018).

Dampak dari paparan kekerasan ini terhadap kesehatan mental pekerja meliputi berbagai dimensi psikologis:

a. Dampak pada kesehatan mental tenaga kesehatan

1) Reaksi pasca-trauma dan gangguan mood:

Tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan sering kali menunjukkan reaksi pasca-trauma seperti iritabilitas, perasaan tidak adil, syok, serta ketakutan yang mendalam. Paparan agresi ini juga berkontribusi langsung pada munculnya gejala depresi, serangan panik, dan kehilangan nafsu makan (Putra et al., 2024).

2) Stress, kelelahan emosional dan *burnout*

Kekerasan fisik maupun verbal menjadi pemicu terjadinya stress, kelelahan emosional (*emotional exhaustion*) yang menguras energi psikologis pekerja. Hal ini secara linear menurunkan kepuasan kerja dan moral tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit (Putra et al., 2024; Tjong; Eugenius; Pidada; Wahab, 2025).

3) Gangguan tidur dan kecemasan: Trauma akibat ancaman atau kekerasan menyebabkan gangguan tidur kronis dan peningkatan kewaspadaan berlebih (*heightened alertness*) yang mengganggu kualitas hidup pekerja sehari-hari. (Putra et al., 2024)

b. Dampak pada kinerja dan kualitas layanan

1) Penurunan performa dan kerusakan kredibilitas.

Dampak psikologis ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak integritas profesional tenaga kesehatan, yang pada akhirnya menghambat

produktivitas, menurunkan kualitas pelayanan pasien, serta meningkatkan keinginan tenaga kesehatan untuk meninggalkan tempat kerja.

2) Dampak organisasional

Secara kolektif, perilaku anti-sosial meningkatkan niat tenaga kesehatan untuk berhenti bekerja (*turnover intention*) dan meningkatkan jumlah absen karena sakit (*sick leave*).

Urgensi penanganan masalah ini semakin tinggi karena adanya kecenderungan di lingkungan kesehatan untuk menormalisasi kekerasan dari pasien sebagai bagian dari risiko pekerjaan, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan dan membuat kekerasan terus terjadi pada tenaga kesehatan.

E. Strategi Intervensi Kesehatan Mental bagi Tenaga Kesehatan

Strategi intervensi kesehatan mental bagi tenaga kesehatan dapat disusun dengan mengacu pada tiga pilar utama dari panduan WHO dan ILO untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis. Tiga pilar itu adalah *prevent* (pencegahan), *protect and promote* (perlindungan dan promosi) serta *support* (dukungan) (WHO & ILO, 2022).

1. Strategi *Prevent* (Pencegahan)

Fokus utama pada tahap ini adalah melakukan pengelolaan risiko psikososial melalui intervensi organisasi untuk mengubah kondisi kerja yang menekan.

a. Manajemen beban kerja dan kecepatan kerja

- 1) Menetapkan tingkat staf yang aman (*safe staffing levels*) untuk menghindari kelelahan kronis.
- 2) Membuat tenggat waktu dan target kerja yang realistis serta dapat dicapai.
- 3) Membatasi jam kerja atau jumlah *shift* untuk memastikan waktu istirahat yang cukup.

b. Desain tugas dan konten pekerjaan

- 1) Menerapkan rotasi tugas untuk mengurangi kejenuhan dan memberikan variasi dalam pekerjaan.
- 2) Melibatkan tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan terkait cara mereka menyelesaikan tugas mereka.

c. Budaya dan lingkungan organisasi:

- 1) Menyediakan kerangka kerja formal untuk menangani perlakuan tidak adil, diskriminasi, atau perilaku kasar di tempat kerja.
- 2) Menjamin komunikasi yang terbuka dan sering antara manajemen rumah sakit dan staf medis.

- 3) Memastikan lingkungan fisik kerja (seperti pencahayaan dan tingkat kebisingan) memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

2. Strategi *Protect and Promote* (Perlindungan & Promosi)

Tahap ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan, membangun kesadaran, dan memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk mengenali masalah kesehatan mental secara dini.

a. Pelatihan manajer (kepala ruangan/manajemen rumah sakit)

- 1) Melatih manajer untuk mengenali dan merespons tenaga kesehatan yang mengalami distress emosional secara tepat.
- 2) Mengembangkan keterampilan interpersonal manajer, seperti komunikasi terbuka dan mendengarkan aktif.
- 3) Memastikan manajer memahami bagaimana risiko psikososial memengaruhi kesehatan staf mereka.

b. Literasi kesehatan mental untuk tenaga kesehatan:

- 1) Mengadakan pelatihan literasi untuk mengubah sikap terhadap kondisi kesehatan mental guna mengurangi stigma di antara sesama tenaga medis.
- 2) Membangun keterampilan individu dalam mengelola stres (misalnya melalui teknik relaksasi atau *mindfulness*).

c. Intervensi individu:

- 1) Menyediakan alat bantu diri digital (*digital self-help tools*) atau psikoedukasi yang dapat diakses staf secara mandiri.
- 2) Memberikan kesempatan untuk aktivitas fisik berbasis waktu luang sebagai bagian dari kesejahteraan staf.

3. Strategi *Support* (Dukungan)

Strategi ini berfokus pada dukungan bagi tenaga kesehatan yang sudah mengalami masalah atau gangguan kesehatan mental agar mereka tetap dapat berfungsi dan berkembang di tempat kerja.

a. Akomodasi yang layak (reasonable accommodations):

- 1) Memberikan fleksibilitas jam kerja bagi staf yang sedang menjalani perawatan kesehatan mental.
- 2) Memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif jika diperlukan.
- 3) Menyediakan ruang pribadi bagi staf untuk beristirahat sejenak atau menyimpan pengobatan mereka.

b. Program kembali bekerja (*return-to-work*):

- 1) Menyusun rencana masuk kembali secara bertahap (*phased re-entry*) bagi staf yang baru saja mengambil cuti karena masalah kesehatan mental.

2) Menggabungkan penyesuaian kerja dengan perawatan klinis berkelanjutan yang berbasis bukti.

c. Dukungan inklusi:

Menjalankan inisiatif penempatan kerja yang didukung (*supported employment*) untuk staf dengan kondisi kesehatan mental yang berat agar tetap bisa berkontribusi secara ekonomi dan vokasional.

4. Faktor Pendukung (Enabling Environment)

Agar ketiga strategi di atas berhasil, diperlukan dukungan sistemik berupa komitmen kepemimpinan, investasi dana yang cukup untuk layanan kesehatan mental, serta penegakan hak-hak pekerja terkait kerahasiaan dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Pada sub bab berikut dicantumkan contoh rencana implementasi intervensi yang disusun berdasarkan panduan WHO dan ILO tersebut di atas. Tabel 2 menggambarkan contoh rencana saja dan belum dilaksanakan.

F. Contoh Rencana Implementasi Intervensi Kesehatan Mental di Rumah Sakit

Tujuan utama rencana ini adalah menyeimbangkan tuntutan pekerjaan (*job demands*) dengan dukungan organisasi (*job resources*) untuk mencegah munculnya masalah kesehatan mental pada tenaga kesehatan. Pada contoh ini ditampilkan lokus rumah sakit dan ditujukan untuk perawat yang bertugas di unit rawat inap. Struktur yang sama dapat digunakan di fasilitas kesehatan lainnya.

Tabel 5.2
Contoh Rencana Implementasi Intervensi Kesehatan Mental Perawat di Unit Rawat Inap Rumah Sakit

Pilar Strategi	Intervensi Spesifik Unit Rawat Inap	Frekuensi	Penanggung Jawab
PREVENT (Pencegahan)	Manajemen Rasio Pasien-Perawat: Menetapkan <i>safe staffing levels</i> (jumlah/tingkat kemampuan staf yang aman) berdasarkan tingkat keparahan pasien yang dirawat (<i>patient severity</i>) untuk menghindari beban kerja berlebih, atau tidak sesuai	Setiap <i>Shift</i>	Kepala Ruangan
	Redesain Jadwal <i>Shift</i>: Membatasi jam kerja harian dan memastikan jeda istirahat yang cukup antar <i>shift</i> untuk mencegah kelelahan kronis.	Bulanan	Komite Keperawatan / HRD
	Perbaiki Lingkungan Fisik: Optimalisasi pencahayaan, ergonomi di <i>nurse station</i> dan pengendalian kebisingan untuk kenyamanan kerja.	Semesteran	Sarana Prasarana (IPSRS)

Pilar Strategi	Intervensi Spesifik Unit Rawat Inap	Frekuensi	Penanggung Jawab
PROTECT & PROMOTE (Perlindungan dan Promosi)	Pelatihan Resiliensi & Manajemen Stres: Mengajarkan teknik <i>mindfulness</i> atau keterampilan coping untuk menjaga kesehatan psikologis individu.	Kuartalan	Unit Diklat / Psikolog RS
	Pelatihan Literasi Kesehatan Mental: Edukasi untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran sesama rekan kerja dalam mengenali tanda kecemasan atau depresi.	Bulanan	Unit Diklat / Psikolog RS
	Skrining Rutin pada Tenaga Kesehatan: - untuk mendeteksi burnout dengan instrumen SMB (Single Measurement Burnout) atau MBI (Maslach Burnout Inventory) (Dolan et al., 2015). - Untuk mendeteksi depresi dengan PHQ-9 (<i>Patient Health Questionnaire-9</i>) dan untuk mendeteksi kecemasan dengan GAD-7 (<i>General Anxiety Disorder-7</i>) (Dian et al., 2022; Idaiani et al., 2022).	Bulanan	Psikolog Klinis / K3RS
	Penyediaan Ruang Istirahat: Akses ke ruang istirahat yang tenang dan program aktivitas fisik santai untuk relaksasi staf.	Permanen	Manajemen RS
SUPPORT (Dukungan)	Akomodasi Fleksibel: Penyesuaian jadwal atau modifikasi tugas sementara bagi staf yang sedang dalam pemulihan kondisi kesehatan mental.	Sesuai Kasus	Kepala Ruangan & HRD
	Sistem Konseling Rahasia: Akses ke layanan psikologis profesional yang terjamin kerahasiaannya untuk mendorong perilaku mencari bantuan.	Setiap Saat	Psikolog Klinis / K3RS
	Program Kembali Bekerja: Dukungan transisi bagi perawat pasca-absen karena masalah mental agar dapat kembali beradaptasi dengan ritme kerja bangsal.	Kondisional	Manajer Kasus / HRD

Faktor Pendukung

1. Kepemimpinan yang berkomitmen:
 - a. Direksi rumah sakit harus menetapkan kebijakan tertulis mengenai kesehatan mental yang terintegrasi dalam sistem manajemen K3RS.
 - b. Kepala ruangan perlu dilatih dalam keterampilan manajemen interpersonal, seperti mendengarkan aktif dan komunikasi terbuka.

2. Partisipasi tenaga kesehatan:
 - a. Melibatkan perawat dalam pengambilan keputusan terkait desain tugas dan rotasi kerja untuk meningkatkan kepuasan kerja (*job satisfaction*).
 - b. Membentuk forum komunikasi rutin antara perawat dan manajemen untuk membahas hambatan kerja di unit rawat inap.
3. Keadilan dan kesejahteraan
 - a. Menjamin transparansi dalam sistem insentif dan gaji pokok untuk memitigasi rasa tidak puas yang memicu stres.
 - b. Menyediakan perlindungan dari perlakuan tidak adil, diskriminasi, atau perilaku kasar dari pasien maupun sesama staf melalui kerangka kerja formal.
4. Evaluasi berbasis bukti:
 - a. Melakukan survei kepuasan kerja dan penilaian risiko psikososial secara berkala.
 - b. Memantau data ketidakhadiran (*absenteeism*) dan kejadian kesalahan medis (*medical errors*) sebagai indikator kondisi mental staf.
 - c. Melakukan survei kesehatan mental periodik pada tenaga kesehatan.

Contoh rencana implementasi ini diharapkan dapat memperkuat sumber daya pekerjaan (*job resources*) bagi perawat, sehingga meskipun tuntutan pekerjaan tetap ada, namun risiko *burnout* dan munculnya kondisi kesehatan mental yang buruk dapat ditekan.

G. Simpulan dan Penutup

Kesehatan mental tenaga kesehatan merupakan fondasi utama dalam keberlanjutan sistem layanan kesehatan yang berkualitas. Sebagai garda terdepan, tenaga kesehatan terpapar pada berbagai bahaya psikososial yang kompleks, mulai dari tuntutan kerja yang tinggi (*job demand*), ketidakpastian kerja (*job insecurity*), konflik kerja-keluarga, hingga risiko kekerasan di tempat kerja. Berbagai stresor ini tidak hanya mengancam kesejahteraan individu tenaga kesehatan melalui munculnya kondisi *burnout*, depresi, dan kecemasan, tetapi juga membawa implikasi serius terhadap penurunan produktivitas, peningkatan risiko kesalahan medis (*medical errors*), dan degradasi kepuasan pasien.

Memahami kesehatan mental melalui model dua dimensi—patogenik dan salutogenik—menyadarkan kita bahwa kesehatan mental bersifat dinamis. Kondisi tenaga kesehatan dapat bervariasi dari tahap *flourishing* hingga *languishing*, yang dipengaruhi oleh interaksi faktor determinan di tingkat individu, keluarga, komunitas, serta struktural. Oleh karena itu, penanganan masalah kesehatan mental di sektor kesehatan tidak dapat hanya dibebankan pada resiliensi individu semata, melainkan memerlukan intervensi organisasional yang sistemik.

Strategi intervensi yang komprehensif harus mencakup pilar pencegahan (*prevent*) untuk memitigasi risiko psikososial, perlindungan dan promosi (*protect and promote*) untuk membangun literasi serta kesiapan manajerial, serta dukungan (*support*) bagi mereka yang sedang berjuang dengan gangguan kesehatan mental. Implementasi rencana aksi yang nyata, seperti pengaturan rasio pasien-perawat yang aman (*safe staffing levels*), skrining rutin, dan penyediaan sistem konseling yang rahasia, menjadi krusial untuk memperkuat sumber daya pekerjaan (*job resources*).

Sebagai simpulan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis adalah investasi strategis. Dengan menjamin kesehatan mental tenaga kesehatan melalui komitmen kepemimpinan dan kebijakan yang berbasis bukti, institusi layanan kesehatan tidak hanya melindungi aset manusianya, tetapi juga secara langsung menjaga keselamatan jiwa pasien dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

- Alamsyah, N. D. P., & Rachmawati, R. (2023). Peran psychological capital dalam menurunkan dampak negatif job insecurity dan burnout terhadap subjective-wellbeing dan job performance perawat kontrak. *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, 6(2). <https://doi.org/10.32584/jkmk.v6i2.1989>
- Aydın, D., & Demir, Ö. (2025). The effects of mental languishing on the work life of healthcare workers. *Fiscaeconomia*, 9(2), 1072–1087. <https://doi.org/10.25295/fsecon.1604078>
- Bagheri Hossein Abadi, M., Taban, E., Khanjani, N., Naghavi Konjin, Z., Khajehnasiri, F., & Samaei, S. E. (2021). Relationships between job satisfaction and job demand, job control, social support, and depression in Iranian nurses. *Journal of Nursing Research*, 29(2), 1–8. <https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000410>
- Batubara, K., Syam, B., & Wahyuni, S. E. (2020). Job demands–resources model affects the performance of associate nurses in hospital. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(2), 111–118. <https://doi.org/10.7454/jki.v23i2.1132>
- Chen, L., Liu, J., Yang, H., Ma, H., Wang, H., Huang, Y., Cheng, H., Tang, D., Liu, M., Luo, H., Qu, H., Shen, D., & Zhang, N. (2018). Work-family conflict and job burn-out among Chinese doctors: the mediating role of coping styles. *General Psychiatry*, 31(1). <https://doi.org/10.1136/gpsych-2018-000004>
- Dall’Ora, C., Ball, J., Reinius, M., & Griffiths, P. (2020). Burnout in nursing: A theoretical review. In *Human Resources for Health* (Vol. 18, Number 1). BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s12960-020-00469-9>
- Danti, A. R., Wulandari, D. A., Hamzah, I. F., Grafiyana, G. A. (2026). Pengaruh job insecurity dan work-life balance terhadap stres kerja pada perawat rumah sakit swasta di Bumiayu. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 3(2), 1–10.
- de Araújo, T. M., Mattos, A. I. S., de Almeida, M. M. G., & Santos, K. O. B. (2016). Aspectos psicossociais do trabalho e transtornos mentais comuns entre trabalhadores da saúde: Contribuições da análise de modelos combinados. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 19(3), 645–657. <https://doi.org/10.1590/1980-5497201600030014>
- Dian, C. N., Effendy, E., & Amin, M. M. (2022). The validation of Indonesian version of Patient Health Questionnaire-9. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(T7), 193–198. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.9293>
- Dolan, E. D., Mohr, D., Lempa, M., Joos, S., Fihn, S. D., Nelson, K. M., & Helfrich, C. D. (2015). Using a single item to measure burnout in primary care staff: a

- psychometric evaluation. *Journal of General Internal Medicine*, 30(5), 582–587. <https://doi.org/10.1007/s11606-014-3112-6>
- Erwin, Muh., Ferils, Muh., Burung, R., Dahri, N. W., & Junaeda, J. (2025). Pengaruh job demands dan perceived organizational support terhadap work engagement pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Economic Resource*, 8(1), 829–841. <https://doi.org/10.57178/jer.v8i1.1801>
- European Union. (2021). *Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH), Supporting mental health of health workforce and other essential workers*.
- Fisher, H. L. (2023). Editorial: Salutogenic mental health science—A phoenix rising from the pathogenic ashes of psychiatry? In *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines* (Vol. 64, Number 11, pp. 1529–1531). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13890>
- Fitriana, A. P., Anggraini, T., Fadila, D., Pambudi, G. S., Hamtina, M. R., Lestari, S., & Prihartanti, N. (2022). Konflik kerja-keluarga pada tenaga kesehatan perempuan selama masa pandemi COVID-19. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 13(3), 365–376.
- Guruh, M., Suryani, N. L., Syatoto, I., & Darmadi, D. (2025). Pengaruh job insecurity dan emotional exhaustion terhadap kinerja perawat RSUD Tangerang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1565–1573. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1298>
- Idaiani, S., Herawati, M. H., Mubasyiroh, R., Indrawati, L., Yunita, I., Sitorus, N., & Isfandari, S. (2022). *Reliability of the General Anxiety Disorder -7 Questionnaire for Non-Healthcare Workers*. 298–305. <https://doi.org/10.26911/icphepidemiology.fp.08.2021.07>
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (2023).
- Indrawati, L., Mubasyiroh, R., & Isfandari, S. (2021). Factors affecting anxiety and depression of health workers during the first wave COVID-19 pandemic. *The 8th International Conference on Public Health*, 358–369.
- Jahan Priyanka, T., Akter Mily, M., Asadujjaman, M., Arani, M., & Billal, M. M. (2024). Impacts of work-family role conflict on job and life satisfaction: a comparative study among doctors, engineers and university teachers. *PSU Research Review*, 8(1), 248–271. <https://doi.org/10.1108/PRR-10-2021-0058>
- Jalilian, H., Shouroki, F. K., Azmoon, H., Rostamabadi, A., & Choobineh, A. (2019). Relationship between job stress and fatigue based on job demand-control-support model in hospital nurses. *International Journal of Preventive Medicine*, 10(1). https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_178_17

- Juanamasta, I. G., Aunguroch, Y., Gunawan, J., Dino, M. J., & Polsook, R. (2024). Prevalence of burnout and its determinants among Indonesian nurses: a multicentre study. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-63550-6>
- Kayanti, D. D., & Alfikalia. (2023). Pengaruh konflik kerja keluarga terhadap burnout pada dokter di masa pandemi Covid-19. *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, 14, 33–63.
- Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. *Journal of Health and Social Behavior*, 43(2), 207–222. <https://doi.org/10.2307/3090197>
- Keyes, C. L. M., Wissing, M., Potgieter, J. P., Temane, M., Kruger, A., & van Rooy, S. (2008). Evaluation of the mental health continuum–short form (MHC–SF) in setswana-speaking South Africans. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 15(3), 181–192. <https://doi.org/10.1002/cpp.572>
- Khanlari, P., NoorbalaTafti, A. A., Ghasemi, F., Ghiyasvandian, S., Azam, K., & Zakerian, S. A. (2025). Identification and classification of risk factors for mental health problems in healthcare workers using a systemic framework: an umbrella review. *BMC Public Health*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-025-22840-y>
- Li, S. S., Sen, C. J., Subramaniam, S., Mahendran, H. A., Bujang, M. A., & Loong, K. J. (2026). Job insecurity and psychological wellbeing among junior doctors in Malaysia: A national cross-sectional study. *Medical Journal of Malaysia*, 81(1), 53–61.
- Mjøsund, N. H. (2021). A salutogenic mental health model: Flourishing as a metaphor for good mental health. In *Health Promotion in Health Care - Vital Theories and Research* (pp. 47–59). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63135-2_5
- Mohanty, A., Kabi, A., & Mohanty, A. (2019). Health problems in healthcare workers: A review. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 8(8), 2568. https://doi.org/10.4103/jfmpe.jfmpe_431_19
- Pidada, I. B. G. S. P., & Wahab, A. (2024). Survey analysis of workplace violence among public healthcare workers in Yogyakarta, Indonesia. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s41935-024-00407-z>
- Priastuty, B. A. D., & Mulyana, O. P. (2021). Hubungan antara konflik peran ganda dengan stres kerja pada tenaga kesehatan wanita di puskesmas. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(2), 94–104.
- Putra, A., Kamil, H., Adam, M., & Usman, S. (2024). Prevalence of workplace violence in Aceh, Indonesia: A survey study on hospital nurses. *Acta Biomedica*, 95(1), 1–8. <https://doi.org/10.23750/abm.v95i1.15430>

- Rahmatika, N., & Nadjib, M. (2019). *Violence on Health Workers at The Workplace and its Management Strategy: A Systematic Review*. 135–135. <https://doi.org/10.26911/the6thicph.02.42>
- Rahmawati, A. N., & Susanti, I. H. (2026). Hubungan strategi koping dengan konflik kerja-keluarga pada tenaga kesehatan perempuan di RSUD Ajibarang. *Cendekia Utama*, 15(1), 12–19. <http://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id>
- Rostamabadi, A., Shouroki, F. K., Jalilian, H., Choobineh, A., Azmoon, H., & Shakerian, M. (2019). The relationship between work-related psychosocial factors and burnout among iranian nurses: Job demand-control-support model. *Medicina Del Lavoro*, 110(4), 312–320. <https://doi.org/10.23749/mdl.v110i4.8025>
- Søvold, L. E., Naslund, J. A., Kousoulis, A. A., Saxena, S., Qoronfleh, M. W., Grobler, C., & Münter, L. (2021). Prioritizing the mental health and well-being of healthcare workers: an urgent global public health priority. *Frontiers in Public Health*, 9(May), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.679397>
- Stavroula, Leka; Houdmont, J. (2010). *Occupational health psychology* (1st ed.). Blackwell Publishing Ltd.
- Sulidah, S., Sugiyatmi, T. A., Efendi, F., Susanti, I. A., & Bushy, A. (2024). Determinant factors related to stress, resilience, and depression among health workers during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Electronic Journal of General Medicine*, 21(2). <https://doi.org/10.29333/ejgm/14484>
- Sultana, N., Asaduzzaman, M., Siddique, A. B., Khatun, H., Bari, F. S., Islam, M. N., Tabassum, A., Mondol, A. S., Sayem, M. A., Abdullah, A. Y. M., Hossain, M. P., & Biracyaza, E. (2022). Job insecurity and mental health related outcomes among the humanitarian workers during COVID-19 pandemic: a cross-sectional study. *BMC Psychology*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s40359-022-00974-7>
- Tjong; Eugenius; Pidada; Wahab, A. H. (2025). *Analisis hubungan kekerasan verbal dengan tingkat stres petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunung Kidul*. 49–50.
- WHO. (2022a). *WHO guidelines on mental health at work*.
- WHO. (2022b). *World mental health report: transforming mental health for all*.
- WHO & ILO. (2022). Mental health at work: policy brief. In *World Health Organization and International Labour Organization*. www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use
- Yousef, C. C., Farooq, A., Amateau, G., Esba, L. C. A., Burnett, K., & Alyas, O. A. (2024). The effect of job and personal demands and resources on healthcare

- workers' wellbeing: A cross-sectional study. *PLoS ONE*, 19(5 May), 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303769>
- Zainal, N., Rasdi, I., & Saliluddin, S. M. (2018). The risk factors of workplace violence among healthcare workers in public hospital. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 14, 120–127.
- Zakaria, M., Bardoe, D., Bio, R. B., Yar, D. D., & Hayford, D. (2025). Mental health burden among healthcare workers in Kintampo North Municipal Hospital: A descriptive analysis of stress, depression, and anxiety based on Job Demands-Resources (JD-R) model. *PLOS Mental Health*, 2(12 December), 1–27. <https://doi.org/10.1371/journal.pmen.0000478>
- Zhang, Y., Dugan, A. G., El Ghaziri, M., Siddique, S., & Punnett, L. (2023). Work–family conflict and depression among healthcare workers: the role of sleep and decision latitude. *Workplace Health and Safety*, 71(4), 195–205. <https://doi.org/10.1177/21650799221139998>

PROFIL PENULIS



Osep Yasier Almunsiri, S.Kep., Ners., M.Kep., Lahir di Tasikmalaya, 24 September 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023 sebagai Dosen Tetap di Horizon University Indonesia. Saat ini penulis meniti karier sebagai abdi negara sejak diterima PNS dosen pada tahun

2024 dan bekerja di Poltekkes Kemenkes Banten mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: osepyasier240996@gmail.com

Motto: "*Educate. Inspire. Empower*"



Titik Nuryanti, S. Kep., Ns., M.Kep., Lahir di Tuban, 21 Januari 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Airlangga 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai Dosen Tetap di STIKes Rajekwesi Bojonegoro. Saat ini penulis bekerja di STIKes Rajekwesi Bojonegoro berbagai kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: titiknuryanti01@gmail.com

Motto: Keep Fighting.

PROFIL PENULIS



Ns. Mutianingsih, M.Kep., Lahir di Kuningan, 10 desember 1988 dan merupakan staff pengajar di Akepr RS Efarina. Penulis merupakan lulusan Sarjana Keperawatan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran tahun 2011 dan menyelesaikan Pendidikan Profesi Ners dari kampus yang sama pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan magister pada tahun 2017 di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia peminatan Keperawatan Jiwa dan lulus pada tahun 2019. Penulis saat ini aktif sebagai staff pengajar di Akper RS Efarina dan mengampu mata Kuliah Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gerontik dan Keperawatan Keluarga. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, dan publikasi ilmiah baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi.



Dr. Ns. Mamnu'ah, M.Kep., Sp.Kep.J., Lahir di Indramayu, pada tahun 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari Akademi Keperawatan di AKPER 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 1995. Selanjutnya menempuh S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2001. Pada tahun 2002 penulis selesai menempuh Pendidikan Profesi Ners di Universitas Gadjah Mada. Penulis melanjutkan Pendidikan S2 Program Studi Keperawatan Jiwa pada Universitas Indonesia lulus tahun 2008 dan tahun 2010 lulus Spesialis Keperawatan Jiwa. Pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK), Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2019. Bekerja sejak tahun 1996 mulai dari AKPER sampai saat ini menjadi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA). Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial, Keperawatan Psikiatri, Biostatistik, dan Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Selain menjadi Dosen, penulis juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Keperawatan Program Magister Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mamnuaah@unisayogya.ac.id

Motto: "Hidup mengalir seperti air."

Sinopsis

Buku *Kesehatan Mental dalam Praktik Keperawatan: Pendekatan Holistik dan Komunitas* merupakan buku referensi yang membahas kesehatan mental sebagai bagian penting dari pelayanan keperawatan yang komprehensif. Kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya gangguan jiwa, tetapi juga mencakup kemampuan individu dalam beradaptasi, mengelola stres, menjalin hubungan sosial, serta menjalankan peran secara produktif dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini menguraikan konsep dasar kesehatan mental dalam keperawatan sebagai landasan bagi perawat dalam memahami kondisi psikologis, emosional, sosial, dan spiritual pasien. Pembahasan dilanjutkan dengan intervensi keperawatan pada gangguan depresi dan ansietas yang sering dijumpai dalam praktik pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan asuhan keperawatan yang tepat, perawat diharapkan mampu melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi intervensi secara efektif dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Selain berfokus pada individu, buku ini juga menekankan pentingnya keperawatan jiwa berbasis komunitas. Pendekatan komunitas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses pelayanan, mendukung proses pemulihan, serta mencegah kekambuhan pada orang dengan masalah kesehatan mental. Dalam konteks ini, keluarga, kader kesehatan, lingkungan sosial, dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan.

Buku ini juga membahas stigma dan pendekatan psikososial sebagai tantangan utama dalam pelayanan kesehatan mental. Stigma sering kali menjadi hambatan bagi individu untuk mencari pertolongan dan memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu, pendekatan psikososial menjadi penting dalam membangun penerimaan, meningkatkan dukungan sosial, serta memperkuat keberdayaan pasien dan keluarga.

Tidak hanya membahas kesehatan mental pasien dan masyarakat, buku ini turut memberikan perhatian pada kesehatan mental tenaga kesehatan. Perawat dan tenaga kesehatan lainnya rentan mengalami stres kerja, kelelahan emosional, burnout, serta tekanan psikologis akibat tuntutan pelayanan. Pembahasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesejahteraan mental tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan.

Secara keseluruhan, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, praktisi kesehatan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pelayanan kesehatan mental. Dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas, buku ini diharapkan dapat memperkuat peran perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang humanis, profesional, dan berkelanjutan.

Buku Kesehatan Mental dalam Praktik Keperawatan: Pendekatan Holistik dan Komunitas merupakan buku referensi yang membahas kesehatan mental sebagai bagian penting dari pelayanan keperawatan yang komprehensif. Kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya gangguan jiwa, tetapi juga mencakup kemampuan individu dalam beradaptasi, mengelola stres, menjalin hubungan sosial, serta menjalankan peran secara produktif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menguraikan konsep dasar kesehatan mental dalam keperawatan sebagai landasan bagi perawat dalam memahami kondisi psikologis, emosional, sosial, dan spiritual pasien. Pembahasan dilanjutkan dengan intervensi keperawatan pada gangguan depresi dan ansietas yang sering dijumpai dalam praktik pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan asuhan keperawatan yang tepat, perawat diharapkan mampu melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi intervensi secara efektif dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Selain berfokus pada individu, buku ini juga menekankan pentingnya keperawatan jiwa berbasis komunitas. Pendekatan komunitas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses pelayanan, mendukung proses pemulihan, serta mencegah kekambuhan pada orang dengan masalah kesehatan mental. Dalam konteks ini, keluarga, kader kesehatan, lingkungan sosial, dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan.

Buku ini juga membahas stigma dan pendekatan psikososial sebagai tantangan utama dalam pelayanan kesehatan mental. Stigma sering kali menjadi hambatan bagi individu untuk mencari pertolongan dan memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu, pendekatan psikososial menjadi penting dalam membangun penerimaan, meningkatkan dukungan sosial, serta memperkuat keberdayaan pasien dan keluarga.

Tidak hanya membahas kesehatan mental pasien dan masyarakat, buku ini turut memberikan perhatian pada kesehatan mental tenaga kesehatan. Perawat dan tenaga kesehatan lainnya rentan mengalami stres kerja, kelelahan emosional, burnout, serta tekanan psikologis akibat tuntutan pelayanan. Pembahasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesejahteraan mental tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan. Secara keseluruhan, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, praktisi kesehatan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pelayanan kesehatan mental. Dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas, buku ini diharapkan dapat memperkuat peran perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang humanis, profesional, dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-08-4 (PDF)



9

786347

756084